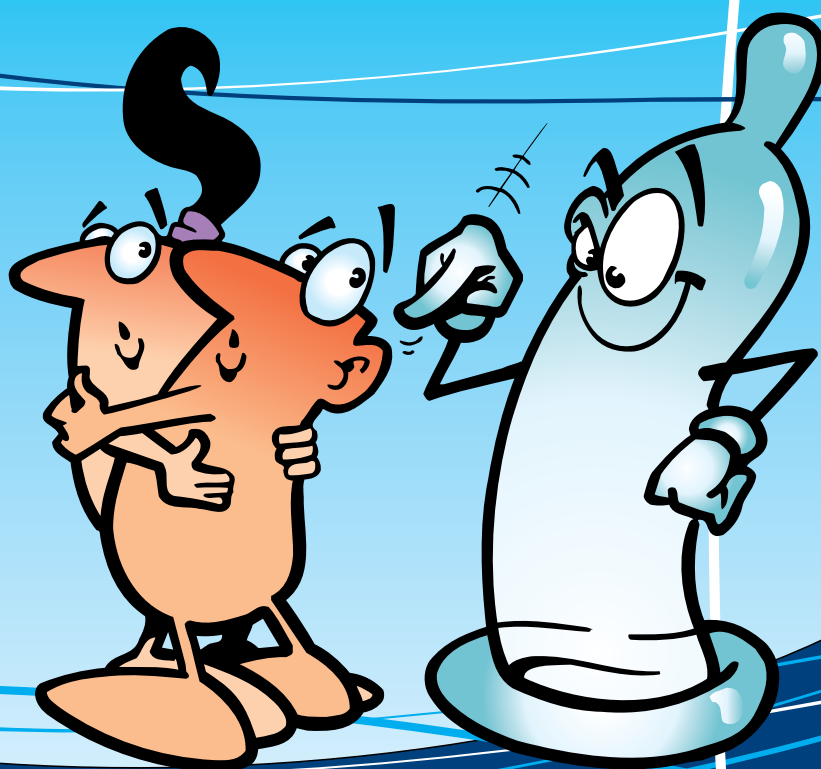


# ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

**организация работы с группами риска,  
профилактика, консультирование,  
диагностика и лечение**



Минск  
2009 г.



# **ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ**

**(организация работы с группами риска, профилактика,  
консультирование, диагностика и лечение)**

**Минск  
2009 г.**

«Ведение пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем» издано в рамках совместного проекта программы развития ООН и Министерства здравоохранения "Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь", финансируемого Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Книга предназначена для врачей-дерматовенерологов, осуществляющих обследование и лечение людей, наиболее подверженных риску заболевания ИППП и ВИЧ-инфекцией - мужчин, имеющих сексуальные отношения с другими мужчинами, и женщин, вовлеченных в секс-бизнес. А также для всех врачей-дерматовенерологов, интересующихся особенностями работы, консультирования, диагностики и лечения ИППП у представителей групп риска.

## Содержание (номера разделов)

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Введение</b>                                                                                | 1    |
| <b>Классификация инфекций, передаваемых половым путем</b>                                      | 2    |
| <b>Клинико-эпидемиологическая характеристика инфекций, передаваемых половым путем</b>          | 3    |
| <b>Восприимчивость к инфекциям, передаваемым половым путем</b>                                 | 4    |
| <b>Организация профилактики и борьбы с ИППП</b>                                                | 5    |
| • организация первичной и вторичной профилактики ИППП                                          | 5.1  |
| • скрининг ИППП среди наиболее эпидемиологически значимых групп населения                      | 5.2  |
| • регистрация и учет случаев ИППП                                                              | 5.3  |
| • организация системы выявления, уведомления и обследования сексуальных партнеров больных ИППП | 5.4  |
| • обеспечение конфиденциальности сведений о больных ИППП                                       | 5.5  |
| <b>Организация работы доверенного врача</b>                                                    | 6    |
| <b>Пути повышения качества ведения пациентов</b>                                               | 7    |
| <b>Рекомендуемая последовательность действий доверенного врача</b>                             | 8    |
| <b>Алгоритмы консультирования лиц с рискованным сексуальным поведением</b>                     | 9    |
| • гонококковая инфекция                                                                        | 9.1  |
| • негонококковый уретрит                                                                       | 9.2  |
| • хламидийная инфекция                                                                         | 9.3  |
| • аногенитальная герпетическая инфекция                                                        | 9.4  |
| • аногенитальные бородавки                                                                     | 9.5  |
| • сифилис                                                                                      | 9.6  |
| • урогенитальный кандидоз                                                                      | 9.7  |
| • бактериальный вагиноз                                                                        | 9.8  |
| • трихомониаз                                                                                  | 9.9  |
| • воспалительные заболевания органов малого таза                                               | 9.10 |
| • ВИЧ-инфекция (дотестовое консультирование)                                                   | 9.11 |
| • ВИЧ-инфекция (послетестовое консультирование – отрицательный результат)                      | 9.12 |
| • ВИЧ-инфекция (послетестовое консультирование – положительный результат)                      | 9.13 |
| <b>Алгоритмы индивидуальной профилактики ИППП</b>                                              | 10   |
| <b>Алгоритмы ведения пациентов в соответствии с симптомами заболевания</b>                     | 11   |
| <b>Алгоритмы ведения больных с ИППП и болезнями, ассоциированными с половым путем передачи</b> | 12   |
| • гонококковая инфекция                                                                        | 12.1 |
| • негонококковый уретрит и цервицит                                                            | 12.2 |
| • баланит/баланопостит, вульвовагинит (кольпит)                                                | 12.3 |
| • хламидийная инфекция                                                                         | 12.4 |
| • трихомониаз                                                                                  | 12.5 |
| • аногенитальная герпетическая вирусная инфекция                                               | 12.6 |
| • сифилис                                                                                      | 12.7 |
| • кандидозный вульвовагинит                                                                    | 12.8 |
| • бактериальный вагиноз                                                                        | 12.9 |

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека_____                          | 12.10 |
| • паразитарные дерматозы, ассоциированные с половым<br>путем передачи_____         | 12.11 |
| <b>Взятие материала для диагностики</b> _____                                      | 13    |
| • прямая микроскопия_____                                                          | 13.1  |
| • хламидийная инфекция_____                                                        | 13.2  |
| • гонококковая инфекция_____                                                       | 13.3  |
| • аногенитальный герпес_____                                                       | 13.4  |
| • сифилис_____                                                                     | 13.5  |
| • ВИЧ/СПИД, гепатиты_____                                                          | 13.6  |
| • трихомониаз_____                                                                 | 13.7  |
| • кандидоз_____                                                                    | 13.8  |
| • бактериальный вагиноз_____                                                       | 13.9  |
| • чесотка_____                                                                     | 13.10 |
| <b>Схема действий при положительной пробе</b> _____                                | 14    |
| <b>Выявление контактов</b> _____                                                   | 15    |
| <b>Порядок направления пациентов в кожно-венерологическое<br/>учреждение</b> _____ | 16    |

## Приложения



## Список сокращений

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ИППП     | – инфекции, передаваемые половым путем                                               |
| ВИЧ      | – вирус иммунодефицита человека                                                      |
| ВЗОМТ    | – воспалительные заболевания органов малого таза                                     |
| ГЕИ      | – субпопуляция мужчин, имеющих сексуальные отношения только с мужчинами              |
| СПИД     | – синдром приобретенного иммунодефицита                                              |
| ПИФ      | – прямая иммунофлюоресценция                                                         |
| ПЦР      | – полимеразная цепная реакция                                                        |
| ЛЦР      | – лигазная цепная реакция                                                            |
| ИФА      | – иммуноферментный анализ                                                            |
| ПС       | – первичная сифилома                                                                 |
| ВГА      | – вирус гепатита А                                                                   |
| ГА       | – гепатит А                                                                          |
| ГВ       | – гепатит В                                                                          |
| ВГВ      | – вирус гепатита В                                                                   |
| ГС       | – гепатит С                                                                          |
| ВГС      | – вирус гепатита С                                                                   |
| ПМЯЛ     | – полиморфноядерные лейкоциты                                                        |
| ПЗ       | – поле зрения                                                                        |
| ДДУ      | – детские дошкольные учреждения                                                      |
| КВУ      | – кожно-венерологические учреждения                                                  |
| КВД      | – кожно-венерологический диспансер                                                   |
| КВО      | – кожно-венерологические отделения                                                   |
| КВК      | – кожно-венерологические кабинеты                                                    |
| КСР      | – коммерческие секс-работники                                                        |
| ЛПУ      | – лечебно-профилактические учреждения                                                |
| МАНК     | – методы амплификации нуклеиновых кислот                                             |
| ЖСБ      | – женщины, вовлеченные в секс-бизнес                                                 |
| МСМ      | – мужчины, постоянно или периодически практикующие сексуальные отношения с мужчинами |
| ПИН      | – потребители инъекционных наркотиков                                                |
| НГУ      | – негонококковый уретрит                                                             |
| МАНК     | – методы амплификации нуклеиновых кислот                                             |
| РАР-тест | – тест Папаниколау (цитологическое исследование мазка на атипичные клетки)           |

## ВВЕДЕНИЕ

10

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – одна из серьезных социально-медицинских и психологических проблем современности. Их значение определяется большой распространенностью и опасностью для различных институтов общества. Они несут, в первую очередь, тяжелые последствия для здоровья заболевших, оказывают пагубное влияние на воспроизводство потомства, сопровождаются значительными затратами на диагностику, лечение и реабилитацию больных.

Рост заболеваемости ИППП и ВИЧ-инфекцией в странах СНГ, в последние десятилетия в значительной степени обусловлен распространением практики рискованного сексуального поведения, наркомании и несовершенством профилактических программ.

Традиционно, из ИППП, наиболее сложным в диагностике и лечении считается сифилис. В то же время новую и весьма непростую проблему представляют собой диагностика и лечение хламидийной и ряда других инфекций урогенитального тракта. Современные интенсивные исследования в области ИППП раскрывают все новые аспекты их негативного влияния на организм человека, их взаимосвязь с самой разнообразной патологией органов и систем. Так, согласно ряду исследований, герпетическая и папилломавирусная инфекция рассматривается как фактор онкогенеза, а примерно у 20-25% больных сексуально активного возраста с артритами выявляются хламидии. Последнее десятилетие принесло убедительную информацию о роли полового пути передачи в распространении гепатитов. Стала известна негативная роль ИППП, как фактора, способствующего ускорению темпов распространения ВИЧ-инфекции.

К проблеме диагностики, терапии, профилактики, реабилитации больных ИППП имеют непосредственное отношение врачи, представляющие самые разнообразные направления медицины. Это врачи-акушеры-гинекологи, урологи, дерматовенерологи, сексопатологи, андрологи, инфекционисты, врачи клинической лабораторной диагностики, валеологи, психиатры, психотерапевты, педиатры, онкологи, вирусологи, эпидемиологи, организаторы здравоохранения, ревматологи и др. Врачам данного профиля в практической работе периодически приходится сталкиваться как со свежими формами, так и с осложнениями и последствиями ИППП. Эти заболевания нередко приводят к семейным конфликтам, к разрушению общего физического и нервно-психического состояния больных, вызывают осложнения, которые приводят к утрате трудоспособности, бесплодию или внутриутробной инфекции. В то же время зачастую их длительное малосимптомное и скрытое течение не заставляет больного спешить к врачу и значительно затрудняет своевременное выявление, что ведет к разнообразной патологии.

Очень высокими являются экономические потери, которые государствам приходится затрачивать на диагностику и лечение больных ИППП. Особенно ощутимы прямые затраты на лечение больных СПИДом. В то же время, отдаленные социально-экономические потери государств с высоким уровнем ИППП достаточно трудно подсчитать. Они связаны, в первую очередь, с необходимостью организации разнопрофильной медицинской помощи пациентам и больным с последствиями ИППП, со снижением рождаемости и численности трудоспособного населения и др. А высокий уровень смертности от СПИДа уже сейчас опустошил некоторые африканские страны и подорвал их экономику.

В связи со сказанным все шаги по организации на национальном уровне эффективной медицинской помощи больным с ИППП и построение действенной системы профилактики ИППП и СПИДа являются вопросом национальной без-

### 1



опасности и залогом процветания стран, где это удастся сделать.

Сегодня борьба с распространением ВИЧ-инфекции является приоритетным направлением. Однако во многих странах до настоящего времени профилактика ВИЧ недостаточно интегрирована с профилактикой других ИППП.

В то же время по данным ВОЗ 1 доллар США, затраченный на эффективные профилактические программы по ИППП, экономит, по меньшей мере, 10 долларов, которые идут на лечение больных. Поэтому очень важно использование различных методов информирования, поддержание усилий, направленных на изменение модели поведения населения. Все материалы, направленные на обучение безопасным видам сексуального поведения являются приоритетными. При этом существенная роль должна отводиться поиску и развитию адекватных форм лечебно-диагностической помощи и профилактической работы и их активное продвижение, особенно в группы повышенного поведенческого риска.

Эффективность борьбы с ИППП в большой степени зависит от концентрации внимания именно на группах населения наиболее подверженных риску заражения этими болезнями, например, лица, вовлеченные в коммерческий секс и их клиенты, мужчины, имеющие секс с мужчинами и наркоманы. По данным многолетних исследований, данные группы являются резервуаром, в котором инфекция сохраняется даже в периоды низкой заболеваемости. Проведение лечебно-диагностических и профилактических программ среди этих контингентов населения имеет свои особенности и должно быть основано на всестороннем изучении нужд и оценках ситуации в целевом сообществе. Поэтому при подготовке данного руководства использован опыт по ведению пациентов с ИППП, в том числе из групп риска, ряда известных зарубежных и отечественных ученых (приложение 6). Приведены также выдержки из документов Министерства здравоохранения Республики Беларусь и формы медицинской документации.

Несмотря на сильную связь ИППП с ВИЧ-инфекцией, их профилактике в республике придается еще недостаточное значение. Поэтому весьма важным является то, что большое внимание этой проблеме уделяет Программа развития ООН в Республике Беларусь, посредством которой совместно с Министерством здравоохранения республики реализуется проект «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь». Финансовым донором проекта является Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Участие в этом проекте организаций здравоохранения республики предполагает бесплатное оказание на их базе медицинских услуг и покупку в доверенных аптеках лекарственных препаратов для пациентов из групп риска за счет денежных средств проекта. Это требует от врачей, работающих в проекте («доверенные врачи»), качественного ведения пациентов, своевременного заполнения всех специальных отчетных форм проекта и форм официальной медицинской документации строго в соответствии с образцами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Очень важной основой для проведения диагностических, лечебных, противоэпидемических и профилактических мероприятий доверенными врачами являются единые подходы к ведению пациентов. Успешное ведение пациентов с ИППП требует специальных знаний в этой области. Поэтому, стандартизованные процедуры (алгоритмы), описанные в настоящем руководстве, могут быть использованы в повседневной работе с пациентами из групп риска.

# КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

12

## 2

### I. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ 10-ГО ПЕРЕСМОТРА

#### Раздел: Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (A50-A64)

**Исключены:** болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека /ВИЧ/ (B20-B24), неспецифические и негонококковые уретриты (N34.1), болезнь Рейтера (M02.3)

**A50 Врожденный сифилис**

**A51 Ранний сифилис**

**A52 Поздний сифилис**

**A53 Другие и неуточненные формы сифилиса**

**A54 Гонококковая инфекция**

**A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)**

**A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем**

**A57 Шанкроид**

**A58 Паховая гранулема**

**A59 Трихомониаз**

**A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes simplex)**

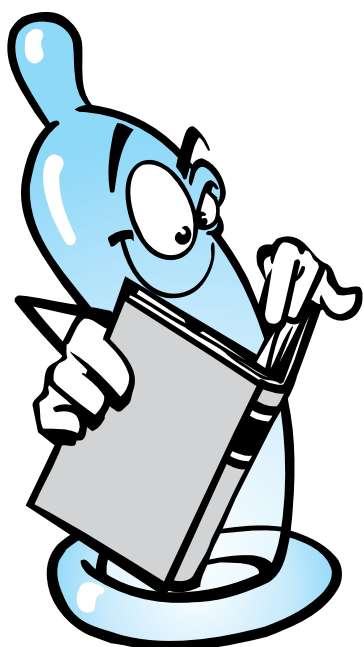
**A63 Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках**

A63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки

A63.8 Микоплазмоз (в соответствии с установленным этиологическим фактором *M.genitalium*)

**A64 Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные**

Как видно из приведенных данных каждая рубрика имеет трехзначный шифр, который включает в себя все клинические формы этой болезни. Например, врожденный сифилис – A50, ранний сифилис – A51, поздний сифилис – A52. Если необходимо уточнение Диагноза, то вводится четырехзначная подрубрика. Например, вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек A51.3; гонококковая инфекция глаз A54.3. Приводим согласно МКБ-10 шифры рубрик и подрубрик некоторых других заболеваний, ассоциированных с половым путем передачи, но не вошедших в рубрику «Инфекции, пе-



редаваемые преимущественно половым путем»:

- **болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека /ВИЧ/ В20-В24.** Это заболевание выделено в отдельную рубрику, учитывая его медико-социальную значимость и особенности клинического течения;

- **кандидоз вульвы и вагины В37.3 и кандидоз других урогенитальных локализаций: уретрит, баланит, баланопостит В37.4** (из рубрики «кандидоз» В37);

- **бактериальный вагиноз** (из рубрики «другие невоспалительные болезни влагалища» N89.8);

- **фтириаз В85.3** (из рубрики «педикулез, акариаз и другие инфекации» В85-В89);

- **вирусные гепатиты В15-19;**

- **контагиозный моллюск В08.1** (из рубрики «другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках» В08);

- **цитомегаловирусная болезнь В25** (из рубрики «другие вирусные инфекции» В25-В34);

- **чесотка В86** (из рубрики «педикулез, акариаз и другие инфекации» В85-В89);

Названия заболеваний, приведенные выше, являются общепринятыми в международном медицинском сообществе и легализованными в форме «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем», 10-го пересмотра. В то же время в разговорной практике нередко встречается использование других терминов-синонимов, которые зачастую устарели (приложение 2). Врачи при оформлении амбулаторных карт и историй болезни иногда допускают применение таких синонимов.

**Внимание! При оформлении официальной медицинской документации на пациентов, получающих медицинские услуги в рамках проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь», доверенные врачи должны использовать лишь терминологию, приведенную в МКБ-10.**

## II. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

### 1. Бактериальные

- сифилис, гонококковая инфекция, шанкроид, паховая гранулема, хламидийная лимфогранулема (венерическая)

- хламидиоз урогенитальный
- микоплазмоз урогенитальный
- бактериальный вагиноз

### 2. Вирусные

- аногенитальная герпетическая вирусная инфекция
- аногенитальные (венерические) бородавки,
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека /ВИЧ/
- парентеральные гепатиты
- контагиозный моллюск
- цитомегаловирусная болезнь

**3. Протозойные** – урогенитальный трихомоноз, амебиаз кожи аногенитальной области

**4. Вызванные грибами** – урогенитальный (вульвовагинальный) кандидоз

**5. Вызванные эктопаразитами** – чесотка и фтириаз

## III. СИНДРОМНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

### 1. Инфекции, характеризующиеся эрозивно-язвенным синдромом

Выделяют ИППП, характеризующиеся эрозивно-язвенными поражениями гениталий. Эрозии и язвы в аногенитальной области могут быть вызваны раз-

личными причинами. К инфекционным агентам относятся возбудители сифилиса, аногенитального герпеса, шанкроида, венерической лимфогранулемы и паховой гранулемы.

Последние три инфекции встречаются в тропических странах. Изъязвления могут также иногда возникать при трихомониазе, амебиазе, при чесотке или фтириазе в результате присоединения вторичной инфекции.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить с травмой, злокачественными заболеваниями генитальной области, лекарственным дерматитом, а также синдромами Бехчета и Рейтера.

## **2. Инфекции, характеризующиеся синдромом уретрально-вагинальных выделений**

Влагалищные выделения могут быть связаны с различными причинами. Из инфекций они чаще всего вызваны тремя распространенными заболеваниями: бактериальный вагиноз, трихомониаз и кандидоз. Самой распространенной причиной патологических влагалищных выделений у женщин детородного возраста является бактериальный вагиноз.

Дифференциальная диагностика. Вагинальные выделения могут также быть вызваны рядом физиологических и патологических состояний, таких как дерматозы вульвы или же аллергические реакции. Их следует учитывать, если тесты на специфические инфекции окажутся отрицательными. Многие симптомы и признаки неспецифичны. Иногда причиной влагалищных выделений может быть инфицирование шейки матки хламидиями или гонококками.

## **3. ИЗЛЕЧИМЫЕ И НЕИЗЛЕЧИМЫЕ ИППП**

Все инфекции, которые могут передаваться при половых контактах, делят на излечимые и неизлечимые. Большинство инфекций излечимы. К заболеваниям, при которых сегодня этиологического излечения добиться не удастся, относят вирусные инфекции – СПИД и аногенитальную герпетическую инфекцию. Согласно научным публикациям папилломавирусная инфекция в достаточно высоком количестве случаев (около 50% в течение 1 года) самопроизвольно элиминируется из организма инфицированного человека. Однако она, так же как и вирусные гепатиты, может принимать хроническое течение.

## **4. ИППП ВЫЗВАННЫЕ ПАТОГЕННЫМИ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ**

**1.** Большинство ИППП вызваны патогенными микроорганизмами: сифилис, гонококковая инфекция, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, урогенитальный хламидиоз, трихомониаз, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция, хламидийная лимфогранулема (венерическая), паховая гранулема, цитомегаловирусная болезнь, контагиозный моллюск, аногенитальные (венерические) бородавки, фтириаз, чесотка, вирусные гепатиты.

**2.** ИППП, вызванные условно-патогенными микроорганизмами: урогенитальные микоплазмоз и кандидоз, бактериальный вагиноз, уретриты, вызванные гемолитическим и эпидермальным стафилококками, энтерококками, катаральным диплококком.

# КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Наиболее характерными для большинства инфекций, передаваемых половым путем, клинико-эпидемиологическими особенностями являются:

- возможность передачи половым путем
- быстрое распространение заболеваний, особенно в группах риска
- наличие очага инфекции и необходимость обследования и лечения сексуальных партнеров
- высокий удельный вес осложнений и последствий, связанных с репродуктивной системой
- высокая частота малосимптомного либо бессимптомного течения (в течение месяцев и лет) при попадании возбудителя в организм
- периодическое обострение заболеваний с манифестными проявлениями
- отсутствие патогномичных симптомов при многих ИППП
- возможность вертикального пути передачи
- крайняя неустойчивость и гибель во внешней среде возбудителя
- необходимость подтверждения Диагноза с помощью лабораторных тестов
- возможность диагностики на ранних стадиях заболевания с помощью серологических (иммунологических) методов
- повышение риска заражения другими ИППП, в первую очередь ВИЧ-инфекцией
- повышение риска развития злокачественных новообразований гениталий
- негативное влияние на психосексуальную сферу и гармонию семейных отношений
- отсутствие приобретенного иммунитета
- высокая эффективность мер индивидуальной профилактики

3

15

**Значение полового пути передачи** для болезней, включенных в раздел МКБ-10 «Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем», достаточно хорошо изучено. На это указывает само название раздела. В то же время по мере развития медицинской науки появляется новая информация о роли полового пути передачи в развитии самой разнообразной инфекционной патологии человека. Для различных ИППП и болезней, ассоциированных с половым путем передачи, значение полового пути передачи довольно сильно отличается.

Хотя ВИЧ-инфекция согласно МКБ-10 не относится к инфекциям, передаваемым половым путем, тем не менее, половой путь передачи является для нее основным (75-90% от всех зарегистрированных случаев). Несмотря на то, что во многих странах чрезвычайно важную роль в быстром распространении эпидемии играет инъекционный путь, на «родине» СПИДа - в странах Африки, где население мало употребляет наркотики, это заболевание в подавляющем большинстве случаев передается половым путем.

В Белоруссии, несмотря на то, что за период 1987-2008 гг. основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией являлось употребление инъекционных наркотиков (56,4%), четко прослеживается тенденция роста числа случаев, когда заражение произошло половым путем. Например в 2001 г. – 27,2%, в 2008 г. – уже 75%, а за 1-е полугодие 2009 г. - 75,8%.

Для чесотки основным путем заражения является совместное пребывание в постели (более 50% всех случаев), а на интимный контакт приходится около 20%. Для таких больных характерным является расположение морфологических эле-



ментов на животе, передней стороне грудной клетки, бедрах, половых органах.

Бактериальным вагинозом могут заболевать женщины, не живущие половой жизнью. Однако отмечено, что частая смена половых партнеров увеличивает риск возникновения этой болезни в 5 - 6 раз.

Важнейшей особенностью ИППП и ВИЧ-инфекции является их **взаимное влияние друг на друга**.

Например, многочисленными исследованиями, проведенными с момента открытия вируса иммунодефицита человека в 1983 г. (Л.Монтанье, Р.Галло) доказано, что различные ИППП увеличивают риск передачи этого вируса от 2 до 23 раз (в среднем в 4 раза). На территориях, где увеличивается заболеваемость ИППП, через 2-3 года нарастает число ВИЧ-инфицированных.

Своевременное выявление и лечение ИППП существенно тормозит развитие эпидемии ВИЧ-инфекции. Так, опыт, полученный ВОЗ в городе Мванза (Танзания) показал следующее. Выявление и лечение всех больных ИППП снизило прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции за этот год на 42%. Повторение эксперимента в Ракаи (Уганда) не дало такого же эффекта, поскольку не проводилось лечение больных генитальным герпесом, а исходный уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией был около 15%. Контроль за ИППП дает максимальный эффект в тех случаях, когда внимание уделяют всем ИППП, а пораженность населения ВИЧ-инфекцией еще не высока.

Одной из особенностей клинического течения ИППП, которая оказывает существенное влияние на распространение этих заболеваний, является **частое малосимптомное течение**. Так, ИППП протекают бессимптомно или с незначительно выраженными симптомами у 70 из 100 женщин и у 50 из 100 мужчин. Это связано с анатомическими и физиологическими различиями органов репродуктивной системы женщин и мужчин, что обуславливает более позднее обращение первых за медицинской помощью в случае инфицирования ИППП. В результате затрудняется постановка правильного Диагноза, происходит откладывание лечения и, следовательно, возрастает риск возникновения осложнений, а также дальнейшего распространения инфекции в обществе.

По степени **воздействия на репродуктивную систему** и в целом на организм больного у женщин последствия ИППП носят более широкий характер, чем у мужчин. Если у мужчин наблюдаются повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией, бесплодие, сексуальные расстройства, рак гениталий, то последствия ИППП у женщин включают:

1. повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией;
2. рак (шейки матки, влагалища, вульвы, ануса, печени), а также саркому Капоши;
3. воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), и их последствия, включая бесплодие;
4. осложнения беременности;
5. перинатальные и постнатальные инфекции плода и новорожденного;
6. различные неврологические синдромы и ряд других заболеваний.

## ВОСПРИИМЧИВОСТЬ к ИППП

В результате контакта с инфицированным лицом неинфицированный человек может заразиться ИППП. Эффективность передачи при разных ИППП очень отличается и зависит от ряда факторов:

- восприимчивость макроорганизма,
- вирулентность микроорганизма и его концентрация в биологических жидкостях (сперме, генитальных секретах, крови)

Имеются **условия**, которые тесно связаны, а в ряде случаев зависят от факторов передачи и увеличивают либо понижают вероятность инфицирования:

- **наличие у реципиента ИППП воспалительного заболевания мочеполовых путей или другой ИППП** - риск заражения при контакте с больным либо носителем ИППП значительно возрастает при наличии у неинфицированного человека воспалительного заболевания репродуктивного тракта или другой ИППП

- **фаза заболевания у донора инфекции** - эффективность передачи тесно связана с тем, в какой фазе заболевания находится донор ИППП. В фазе манифестных проявлений, в малосимптомной, торпидной форма, или является носителем инфекции. При переходе течения ИППП в малосимптомное, торпидное течение вероятность заражения снижается

- **травматичность сексуального контакта** - при половом пути передачи определенное значение играет степень его травматичности:

1. тип сексуального контакта (риск возрастает от орогенитального к обычному гетеросексуальному вагинальному контакту и далее к анальной форме как гетеросексуального, так и гомосексуального контакта между мужчинами)

2. количество половых актов с донором инфекции – повышает риск травматизации и, как следствие, заражения ИППП

3. использование психоактивных веществ (алкоголь, наркотики), растормаживающих сексуальное влечение может повышать травматичность сексуального контакта

- **отношение к использованию средств индивидуальной защиты от ИППП:**

1. отказ от использования средств защиты

2. неправильное использование средств защиты (эпизодичность, незнание методики)

3. использование средств защиты недостаточно высокого качества

4

17



# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ИППП

18

## 5

Для организации эффективной борьбы с ИППП важно понимать основные причины их распространения. Наиболее важной причиной эпидемического роста заболеваемости сифилисом, гонореей и другими ИППП, который наблюдался в 90-х годах 20-го столетия, были большие социальные и экономические перемены в обществе. Они стимулировали многочисленные социально-экономические и социально-психологические факторы, способствующие росту ИППП. Их можно подразделить на популяционные (общие) и индивидуальные, социальные и медицинские. Факторы тесно взаимосвязаны и оказывают существенное влияние на демографическую ситуацию и репродуктивные способности населения. Среди наиболее важных - снижение уровня жизни и рост

безработицы, увеличение миграции населения, падение нравственности и изменение сексуального поведения, рост проституции и потребления алкоголя, наркотиков, увеличение числа разводов и более раннее начало половой жизни, недостаточное информирование населения по вопросам профилактики ИППП, нехватка средств индивидуальной профилактики ИППП, неполное выявление источников заражения больных ИППП и их сексуальных контактов, отсутствие профилактических программ в учреждениях образования и специальных программ по контролю над заболеваемостью среди лиц, имеющих факторы риска и др.

Особое значение в распространении ИППП играет так называемое **«рискованное» поведение**. Это поведение, которое характеризуется действиями, значительно повышающими для индивидуума риск заражения ИППП. Формы такого поведения называют **факторами риска**, а людей, склонных к такому поведению – **группами высокого риска, ядерными** или **уязвимыми группами**.

На популяционном уровне наиболее подверженной риску заражения ИППП является молодежь от 15 до 29 лет. К данной возрастной группе относится большинство лиц, страдающих ИППП. Их удельный вес в общей структуре заболеваемости сифилисом и гонореей превышает 50-60%. В молодежной среде в свою очередь наиболее подвержены риску женщины в возрасте 18-19 лет и мужчины 20-29 лет. Организация эффективной профилактической работы с этой возрастной категорией населения чрезвычайно важна, должна носить постоянный характер и отличаться разнообразием форм.

В то же время самое пристальное внимание при профилактике ИППП должно уделяться группам высокого риска.

К группам риска, среди которых регистрируется повышенный уровень заболеваемости ИППП, в первую очередь относятся:

- лица, занятые в сфере коммерческого секса и их клиенты
- мужчины-гомосексуалисты
- лица, находящиеся в заключении (заболеваемость сифилисом среди поступающих в следственные изоляторы составляет 700 - 800, а гонореей – 130 -150 случаев на 100 тыс.населения)
- наркоманы, потребляющие инъекционные наркотики
- бездомные
- мигранты
- подростки, состоящие на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних



В научно-медицинской лексике нередко для некоторых групп риска используются следующие названия и аббревиатуры.

**ЖСБ** – женщины, вовлеченные в секс-бизнес (проститутки);

**МСМ** – мужчины, имеющие секс с мужчинами (гомосексуалисты);

**КСР** – коммерческие секс-работники (термин употребляют как в отношении женщин, так и в отношении мужчин, оказывающих секс-услуги);

**ПИН** – потребители инъекционных наркотиков.

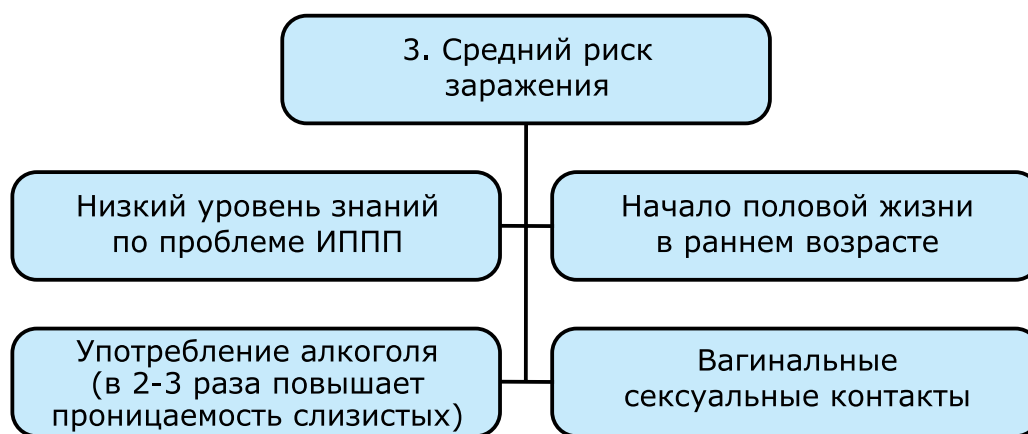
Именно перечисленные группы являются постоянным резервуаром ИППП и поддерживают эпидемический процесс даже в периоды низкого уровня заболеваемости. В периоды подъема заболеваемости ИППП численность групп риска достигает критической массы необходимой для развития эпидемического процесса. Их роль, как наиболее активных распространителей инфекции, значительно возрастает.

Разработка профилактических мероприятий в группах риска должна проводиться с учетом особенностей поведения, возраста, пола, культурного, интеллектуального и материального уровня, а также мнения представителей этих групп об адекватности адресованных им профилактических мероприятий.

Индивидуальные факторы риска так же многочисленны, как и популяционные. По важности их можно разделить по степеням риска.

### **ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА)**





С рискованным сексуальным поведением тесно связано **употребление алкоголя и других наркотических веществ**. Алкоголь и наркотики стимулируют сексуальное влечение, а также изменяют поведение человека в сторону менее критического, что подталкивает его к необдуманным поступкам.

Клиническая практика показывает, что более чем в 50% случаев заражение ИППП происходит в состоянии алкогольного опьянения. Употребление даже 0,5 литра пива в 2-3 раза увеличивает проницаемость слизистых оболочек (3). В то же время исследование женщин, вовлеченных в секс-бизнес, и мужчин, имеющих секс с мужчинами, проводившееся в Белоруссии в 2006 г. (8), показало, что многие из них злоупотребляют алкоголем, являются потребителями наркотиков. Инфицированы ИППП были соответственно 24,7% и 23,1%: чаще всего - хламидийной инфекцией, трихомониазом, гонореей, сифилисом. С употреблением алкоголя нередко был связан также тот факт, что частота использования презервативов с последним сексуальным партнером была достаточно низкой (соответственно 69% и 57,8%).

В связи с высокой частотой вирусных гепатитов в группах риска ряд ученых высказываются в пользу проведения политики вакцинации против гепатита В при лечении ИППП у лиц, относящихся к этим группам. По рекомендации ВОЗ в Беларуси была разработана и реализована Программа иммунизации против вирусного гепатита В (ВГВ) в Республике Беларусь на 1996-2000 годы, утвержденная приказом Министерства здравоохранения №29 от 14 февраля 1996 г. В соответствии с этой программой проводилась иммунизация против ВГВ среди новорожденных и подростков 14-15 лет и контингентов из названных групп повышенного риска инфицирования.

Особое место среди факторов риска занимает **сексуальное насилие**. Чаще всего оно сопровождается заражением жертвы одной либо даже несколькими ИППП. Это связано с тем, что активные действия совершают лица, отличающиеся рискованным поведением и имеющие обычно беспорядочные половые связи. Секс по принуждению приводит, как правило, к травмированию слизистых половых органов, тем самым, открывая входные ворота для инфекции и поэтому увеличивая вероятность заражения ВИЧ и другими ИППП.

Значительный риск несет в себе **начало половой жизни в раннем возрасте**, поскольку обычно подростки не имеют при этом необходимой информации, навыков и знаний, помогающих им защититься от ИППП. Так, многие молодые люди считают, что ИППП не представляют для них угрозы, поскольку встречаются только среди «опустившихся» людей, БОМЖей, среди лиц ведущих разгульный образ жизни, наркоманов и т.д. Неосведомленность об эпидемии ИППП – это широко распространенное явление среди молодежи. Примерно половина подростков не знают о том, что совершенно здоровый на вид

человек может иметь ВИЧ/СПИД или другую ИППП.

Подросткам и детям **из маргинальных групп** (уличные дети, беженцы, мигранты) может грозить особо высокий риск заражения в связи с высокой вероятностью опасных половых контактов (в обмен на еду, защиту или деньги) и употребление наркотических веществ.

Высокий уровень ИППП наблюдается среди **молодежи с отклоняющимся поведением**. Было обследовано на ИППП более 700 подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних г.Минска (Навроцкий А.Л., 1984-87гг.). Около 50% из них имели одну либо более ИППП.

Биологические, социальные и экономические факторы делают особенно уязвимыми к ВИЧ-инфекции и другим ИППП молодых женщин; иногда это приводит к тому, что женщины заражаются вскоре после начала половой жизни. В некоторых наиболее пострадавших от СПИДа странах девочки-подростки заражаются в 5-6 раз чаще, чем мальчики. Появляются все новые сведения, подтверждающие тот факт, что большой процент таких новых случаев инфекции является результатом половых сношений с мужчинами старшего возраста.

Меры медицинского характера недостаточно эффективны для борьбы с ИППП, если они применяются без учета названных выше социально-экономических и социально-психологических факторов. Планирование медицинских мер должно быть долгосрочным и всеобъемлющим.

Среди медицинских мер по борьбе с ИППП особое значение имеет профилактика.

Работа по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), включает в себя **первичную и вторичную профилактику, а также общественную и индивидуальную (личную)**. Формы профилактики тесно интегрированы друг с другом. Меры общественной профилактики оказывают воздействие, как на население, так и на отдельных членов общества, а первичная и вторичная профилактика имеют общую информационную базу и адресованы самым разнообразным категориям населения. В основе организации борьбы с ИППП на каждой территории должен быть целый комплекс профилактических мероприятий. Обязательным их условием должно быть объединение с другими профилактическими программами (по ВИЧ-инфекции, наркологии, охране репродуктивного здоровья) и интеграция в общую систему здравоохранения.

**Наиболее важными являются следующие направления работы:**

### **5.1. Организация первичной и вторичной профилактики ИППП.**

**Первичная профилактика ИППП** - это проведение научно обоснованных мероприятий, направленных на изменение моделей поведения и предотвращение заражения ИППП.

Эта форма работы является наиболее массовой и в большинстве своем основана на общественной профилактике. В то же время важным элементом первичной профилактики является индивидуальная (личная) профилактика.

К первичной профилактике ИППП относится, в первую очередь, медицинское просвещение, направленное на информирование населения об ИППП и их последствиях и формирование безопасного сексуального поведения.

Безопасный секс играет существенную роль в снижении риска заражения ИППП. Под безопасным сексом, в первую очередь, понимают половую связь, при которой отсутствует незащищенный контакт кожи и слизистых оболочек полости рта, носа, прямой кишки и половых органов с различными биологическими жидкостями партнера (кровью, спермой и выделениями из влагалища и др.). Следует подчеркнуть, что абсолютно безопасного секса в указанном понимании не существует.

Половая связь, или половой контакт подразумевает:

- вагинальный секс, когда половой член вводится во влагалище
- оральный секс, когда партнеры целуют или каким-то другим образом стимулируют половые органы друг друга или прямую кишку, например, языком
- анальный секс, когда половой член, палец, язык и др. вводится в прямую кишку.

Половые контакты бывают проникающими и непроникающими. Проникающими половыми контактами считают контакты, при которых происходит введение полового члена в естественные отверстия партнера. При проникающих контактах риск заражения ИППП всегда выше.

С другой стороны, основными принципами безопасного сексуального поведения являются - откладывание начала половой жизни среди подростков на более поздний возраст, сокращение числа сексуальных партнеров, выбор одного постоянного партнера, избегание случайных сексуальных контактов, постоянное использование средств индивидуальной профилактики ИППП. В понятие безопасного секса также должно быть включено воздержание от проникающих видов сексуальных сношений между партнерами, получающими лечение по поводу ИППП.

Очень важной формой профилактической работы является организация систематического информирования населения об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики ИППП через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы). Оно должно проводиться в форме интервью ведущих специалистов-врачей в области дерматовенерологии, акушерства-гинекологии, урологии.

Среди других форм необходимо отметить выпуск и распространение среди населения печатной продукции – памяток, буклетов, санитарных бюллетеней, выступление с лекциями, беседами, проведение «круглых столов», викторин, акций, разработка видеороликов, организация специальных сайтов и чатов в интернете и локальных компьютерных сетях и др.

Программы первичной профилактики должны включать не только мероприятия, проводимые медицинскими работниками. Наоборот, медработники должны выступать в роли источника достоверной научной информации об ИППП и проводить обучение лиц, которые могут в дальнейшем выступать распространителями (донорами) достоверных сведений об ИППП. В качестве обучаемых (реципиенты информации) в первую очередь должны выступать преподаватели учебных заведений, представители молодежных организаций и журналисты.

Формой первичной профилактики организованной по принципу «равный беседует с равным» является волонтерское (добровольческое) движение по профилактике ИППП/ВИЧ-инфекции среди студентов БГМУ. После специальной подготовки на факультативных занятиях на кафедре кожных и венерических болезней студенты-волонтеры в свободное от учебы время занимаются первичной профилактикой (беседы, тренинги) среди учащихся общеобразовательных школ и студентов немедицинских ВУЗов.

**Индивидуальная (личная) профилактика** – это самостоятельное применение здоровыми лицами мер, направленных на предупреждение заражения ИППП. В большинстве случаев это обеспечивается использованием барьерных средств контрацепции (презерватив). Реже используются средства для экстренной профилактики – 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата, 0,01% раствор мирамистина или комбинированный контрацептивный препарат Фарматекс, в состав которого входит хлористый бензалконий, обладающий микробицидным действием.

Практика безопасного, или защищенного, секса предполагает использование презерватива или других способов индивидуальной профилактики при каждом половом контакте! Степень риска заражения при использовании ука-

занных способов зависит от инфекционного агента, вызвавшего ИППП, стадии болезни и наличия тех или иных клинических проявлений у партнера. Риск заражения минимален при использовании средств индивидуальной защиты при инфекциях, преимущественно поражающих уретру и влагалище. Вместе с тем, риск заражения возрастает при наличии у партнера заразных проявлений на тех участках кожи и слизистых оболочек, которые не закрыты презервативом или в случае нахождения возбудителя в периферической крови и других биологических жидкостях.

Мерой общественного характера носит организация на базе дерматовенерологических учреждений круглосуточных пунктов индивидуальной профилактики ИППП, где лица, имевшие случайные половые связи, могут получить экстренную помощь по предупреждению ИППП. Такая помощь заключается в однократной обработке половых органов 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата или 0,01% раствором мирамистина, согласно методике изложенной в инструкции по их применению. Обработка проводится не позднее 2-х часов после случайной половой связи.

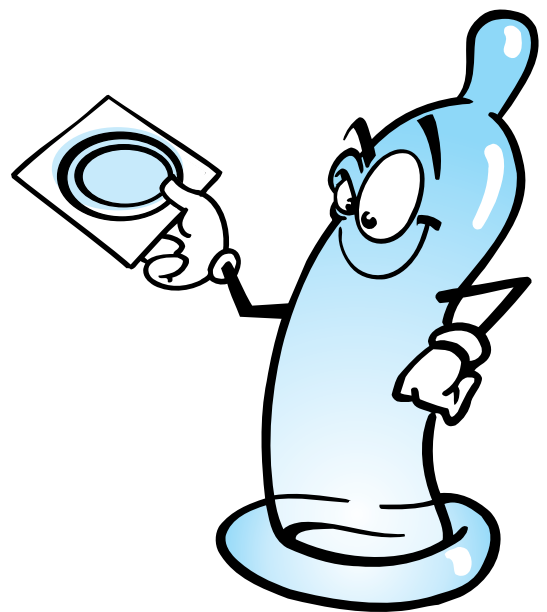
**Вторичная профилактика** – это проведение мероприятий среди лиц с диагностированными ИППП в целях снижения вероятности передачи инфекции партнерам во время заразного периода при половом контакте или через общие предметы, а также снижения риска повторного заражения. Вторичная профилактика основана на консультировании этих лиц, проведении разъяснительных бесед, чтении лекций, издании брошюр, памяток, буклетов, санитарных бюллетеней в целях активного информирования пациентов и изменения их поведения на более безопасное. Вторичная профилактика проводится врачами-дерматовенерологами, акушерами-гинекологами, урологами с учетом социально-демографических характеристик пациентов: пол, возраст, образовательный уровень, наличие поведенческих особенностей и индивидуальных факторов риска и др. Врач дает рекомендации пациенту как избежать распространения и повторного заражения ИППП на основе соблюдения гигиенических правил в быту, коррекции поведения и использования средств индивидуальной профилактики. Обязательным является разъяснение режима лечения и последующего контрольного наблюдения.

**Консультирование** пациентов должно быть обязательным элементом работы врача-дерматовенеролога, акушера-гинеколога и уролога и проводиться устно по специальному для каждой ИППП алгоритму, кратко охватывая вопросы этиологии, диагностики, путей передачи, клинических проявлений, принципов лечения и профилактики.

Важным моментом консультирования является формирование у пациента убеждения в необходимости использования средств индивидуальной профилактики ИППП (презерватив, противомикробные растворы – хлоргексидина биглюконат и мирамистин). Врач обосновывает и разъясняет необходимость и правила их использования. А также подчеркивает опасность самолечения и непрофессионального лечения.

## 5.2. Скрининг и лечение ИППП среди наиболее эпидемиологически значимых групп населения

Основной задачей борьбы с ИППП является активное выявление и лечение новых случаев. В 2006 г. в Белоруссии 91,7% больных сифилисом были активно выявлены медицинскими работника-





ми при клинико-лабораторном обследовании различных контингентов здоровых и больных лиц. Самостоятельно обратились в медицинские учреждения лишь 8,3% от всех больных сифилисом. Согласно анализу к наиболее эпидемиологически значимым группам относятся лица, имевшие сексуальные контакты с больными ИППП. Среди них выявляется наиболее значительное число новых больных. Так, в 2006 году из всех зарегистрированных больных сифилисом в Республике Беларусь 25,4% были выявлены при обследовании половых контактов больных сифилисом.

Важную роль имеет скрининг на сифилис среди больных, находящихся на лечении в соматических стационарах. Среди них в 2006 г. было выявлено 20,6% от всех зарегистрированных больных сифилисом.

Огромное значение имеет скрининг среди лиц с беспорядочными половыми связями. В любом обществе имеются лица, для которых «нормой» интимной жизни являются частые половые связи с постоянной сменой половых партнеров. При этом происходит расширение путей передачи возбудителя инфекции, что ведет к эпидемическому распространению ИППП. Употребление алкоголя, наркотиков провоцирует случайные половые связи, а также порождают рост преступлений на сексуальной почве, что также ведет к подъему заболеваемости ИППП.

Из групп риска чрезвычайно высокую эпидемиологическую значимость имеют лица, занятые в сфере сексуальных услуг. Процесс распространения инфекции происходит по следующей схеме. Лица из групп риска обеспечивают сохранение инфекции и воспроизводство новых больных. Следующий уровень принадлежит пользователям (клиенты, сексуальные партнеры), которые представляют собой довольно широкий круг людей. На третьем уровне находятся их жены, мужья, близкие, дети и случайные знакомые.

Показатель воспроизводимости ИППП зависит от частоты смены половых партнеров и продолжительности периода инфекционности. Оба эти показателя у КСР обеспечивают максимально высокий уровень распространения инфекции в связи со спецификой их работы – большим числом партнеров и, как правило, поздним выявлением заболеваний из-за трудностей с медицинской помощью. Если первый из этих факторов является неконтролируемым, то на второй можно оказывать влияние, улучшая доступ для КСР к медицинской помощи путем ее приспособления к запросам КСР, их образу жизни и поведению.

Согласно исследованиям (дозорный эпидемиологический надзор в рамках Государственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции)), проводившимся в Белоруссии, пораженность инфекциями, передаваемыми половым путем, групп риска (проститутки, мужчины-гомосексуалисты) превышает 20%.

Необходимо обследование доноров крови и органов, работников, которые в силу своих профессиональных обязанностей могут выступить источником заражения ИППП других лиц или подвержены опасности профессионального заражения (работающие в детских учреждениях, таксисты, водители дальнобойщики, горничные в гостиницах и др.). Необходимо также выборочное обследование целого ряда контингентов амбулаторных больных с разной соматической патологией, с которой могут быть схожи проявления ИППП. В целях предупреждения врожденного сифилиса необходимо обследование беременных женщин.

### **5.3. Регистрация и учет всех случаев ИППП**

Точная клиническая и лабораторная идентификация и своевременное сообщение о всех случаях ИППП является важнейшим условием успешного контроля над заболеваемостью. На основании сведений о больных ИППП и лицах, имевших с ними сексуальный контакт (их называют «половые контакты»), все региональные организации здравоохранения должны проводить противоэпидемические мероприятия. Они заключаются в выявлении и привлечении к обследованию на ИППП лиц, которые могут быть инфицированы. Лечение вы-

явленных новых случаев ИППП позволяет прервать эпидемическую цепочку и контролировать эпидемическую ситуацию в регионе.

Задачей каждого врача, который выявил новый случай ИППП, является сообщение об этом в вышестоящую организацию здравоохранения, осуществляющую учет ИППП на данной территории. Кроме того, при выявлении случаев сифилиса и гонореи в целях регистрации и учета должно быть заполнено Извещение о больном с вновь установленным Диагнозом сифилиса, гонореи, микроsporии, трихофитии, фавуса, чесотки (форма №089/у, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2006 г. №976).

На основании сведений о новых случаях заболеваний ИППП, переданных врачами, формируется общий отчет (ежеквартальный и годовой) о заболеваемости на территории. Он позволяет руководителям здравоохранения оценивать тенденции заболеваемости ИППП и планировать выделение необходимых финансовых средств на борьбу с ИППП.

#### **5.4. Организация системы выявления, уведомления, обследования и лечения сексуальных партнеров больных ИППП.**

Правильное ведение сексуальных партнеров является одним из основных средств контроля над заболеваемостью ИППП и предусматривает выявление, уведомление, обследование этих лиц и их лечение. В Республике Беларусь среди обследованных половых партнеров больных сифилисом выявляются более 20% от всех зарегистрированных больных данной патологией.

Выявление половых партнеров у лиц из групп риска достаточно затруднено и требует от доверенного врача большого чувства такта, умения работать с представителями разных уязвимых групп, учета их сексуальной ориентации. Поскольку целью ведения половых партнеров является лечение возможно большего их числа, то существует два пути привлечения половых партнеров в медицинское учреждение.

- Оповещение партнера пациентом;
- оповещение партнера медицинским работником

При выборе первого пути пациенту поручают уведомить партнера о его возможном заражении и попросить обратиться за обследованием и лечением. Многие больные не могут осуждать заболевание ИППП со своими партнерами, и врач должен помочь пациенту принять правильное решение.

С другой стороны пациент может:

- сообщить партнеру всю информацию об ИППП и необходимости лечения;
- сопровождать партнера в медицинское учреждение или обратиться с просьбой пойти туда, не объясняя всех подробностей;
- передать каждому половому партнеру бланк уведомления с просьбой посетить медицинское учреждение.

Если выбирается второй путь, то есть оповещение партнера медицинским работником, то приглашает на лечение врач или патронажная медсестра.

#### **5.5. Обеспечение конфиденциальности сведений о больных ИППП.**

Предполагает сохранение в тайне информации о больном и его половых контактах, что должно обеспечить доверие к врачу со стороны его пациентов.



## ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОВЕРЕННОГО ВРАЧА ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ГРУПП РИСКА

26

6

**ВНИМАНИЕ!** К работе с лицами из групп риска должны привлекаться наиболее опытные врачи, имеющие достаточный стаж работы по специальности и знающие социальные, психологические и поведенческие характеристики пациентов из групп риска. Это помогает врачу оценить их потенциал в распространении ИППП и выбрать адекватный стиль собственного поведения и адекватные диагностические и лечебные методики.

Доверенными врачами могут быть дерматовенерологи, акушеры-гинекологи и урологи.

Доверенный врач должен обладать чувством такта, уметь проявить уважительное отношение к сексуальной ориентации пациентов, а также иметь навыки ведения пациентов, вовлеченных в сферу коммерческого секса, включая навыки их консультирования по вопросам ИППП/ВИЧ-инфекции.

При работе с пациентами, имеющими нетрадиционную сексуальную ориентацию и вовлеченными в секс-бизнес, общение должно быть таким же доброжелательным, как с любым другим пациентом.

Врач, работающий с пациентами из числа MSM, путем самоанализа должен убедиться, что он не испытывает гомофобных чувств. В противном случае эти чувства создадут помехи при оказании помощи данной категории пациентов. Доверенный врач не должен сообщать другим людям о гомосексуальной ориентации своего пациента (особенно членам его семьи), поскольку не исключено, что данная информация может быть использована против пациента

Прием каждого пациента из числа лиц, относящихся к группам повышенного риска, должен проводиться в отдельном специально оборудованном для венерологического (урологического, гинекологического) приема кабинете, закрепленном для данных целей приказом главного врача медицинского учреждения.

Прием осуществляется на основании талонов, выданных организацией, реализующей работу в своем регионе по профилактике ИППП/ВИЧ среди уязвимых групп (ЖСБ, MSM). Талоны должны быть пронумерованы, что позволяет провести анализ обращаемости за медицинскими услугами и тестированием и провести учет работы каждого аутрич-работника.

На каждого пациента должна быть заполнена Медицинская карта амбулаторного больного, инфекциями, передаваемыми половым путем (форма №065/у-07), установленного Министерством здравоохранения Республики Беларусь образца (приказ МЗ РБ №710 от 30.08.2007 г., «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»). Диагноз пациента на лицевую сторону Медицинской карты не выносится.

В целях повышения качества оформления медицинской документации, оперативности ее заполнения, повышения качества обследования и лечения па-



циентов рекомендуется при сборе жалоб, анамнеза, данных объективного обследования использовать бланки Первичного осмотра мужчины и Первичного осмотра женщины (приложение 4).

Для повышения качества сбора анамнеза болезни и других, необходимых для назначения лечения данных, нужно предложить пациентам до приема у врача заполнить специальные анкеты для мужчин и женщин (приложение 1).

На больных, у которых в процессе обследования выявлено венерическое заболевание (сифилис или гонорея), доверенный врач должен заполнить Извещение о больном с вновь выявленным Диагнозом сифилиса, гонореи, микро-спории, трихофитии, фавуса, чесотки (форма №089/у), которое утверждено приказом Министерства здравоохранения от 22.12.2006 г. №976 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ».

Больному, у которого выявлено венерическое заболевание, доверенный врач должен дать заполнить Предупреждение лицу, заболевшему венерической болезнью.

Каждому пациенту проводится лабораторное тестирование на стандартный перечень ИППП: сифилис, гонококковая инфекция, хламидийная инфекция, трихомониаз, микоплазменная инфекция, кандидоз, бактериальный вагиноз, а также, при необходимости, герпетическая и папилломавирусная инфекции.

При выявлении ИППП доверенный врач проводит медицинское консультирование больного и назначает ему лечение, согласно действующим Клиническим протоколам диагностики и лечения ИППП, утвержденным приказом Министерства здравоохранения.

После внесения схемы лечения в Медицинскую карту амбулаторного больного, ему на руки выдаются рецепты на приобретение лекарственных препаратов в закрепленных аптеках данного населенного пункта.

Выдача рецептов и их номера фиксируются в специально заведенном для этих целей журнале.

Доверенный врач ведет журнал регистрации обращений пациентов за тестированием и лечением, а также вносит данные о пациенте в специальный бланк регистрации по обследованию и лечению (приложение 3).

Аптека направляет в адрес РОО «БелАЮ», реализующей .... счет на выданные лекарственные препараты и реестр, в котором указываются: количество рецептов, по которым были выданы лекарственные препараты, их номера и перечень лекарств. Обязательно указывается количество пациентов, которым были отпущены лекарственные препараты. Оплате в «БелАЮ» подлежат только этиотропные лекарственные препараты для лечения ИППП. Патогенетические и другие лекарственные препараты пациент оплачивает самостоятельно. В последующие годы предполагается, что оплата всех лекарственных препаратов будет производиться самим пациентом.

Больным, прошедшим лечение, проводится контрольное обследование в сроки, которые регламентированы инструктивно-методическими документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Об этом в Медицинскую карту данного больного вносится соответствующая информация. О фактах неявки пациентов за результатами тестирования, случаях отказа от бесплатных рецептов в Медицинской карте также делается отметка.

При работе с пациентами из групп риска доверенный врач должен подчеркивать:

1. обследование на ВИЧ-инфекцию является обязательным исследованием;
2. лечение нужно проходить полностью, так как при срыве лечения пациента (из числа ЖСБ) останется заразной для своих клиентов и рискует подвергнуться насилию со стороны этого клиента, вплоть до нанесения тяжких телесных повреждений или даже смерти.

Доверенный врач при выборе методик лечения преимущество должен отдавать экспресс-терапии, не оказывать давления на пациентов и дать возможность начать лечение в удобное для них время в ближайшие 2 дня.

С учетом вероятности микст-инфекций и отсутствия возможности полноценного обследования при однократном посещении допустимым в период эпидемии ИППП является назначение пациентам, вовлеченным в секс-бизнес, синдромного лечения.

При любой однократной явке следует не упускать возможности проведения максимальной информационной работы, консультирования, снабжения презервативами.

# ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИППП ИЗ ГРУПП РИСКА В РАБОТЕ ДОВЕРЕННОГО ВРАЧА

1. Постоянное обучение всего персонала, участвующего в ведении больных.
2. Неукоснительное выполнение алгоритмов консультирования, диагностики и лечения ИППП.
3. Осуществление взаимодействия с различными организациями здравоохранения, принимающими участие в ведении больных ИППП.
4. Сбор и анализ информации об эпидемиологической ситуации с ИППП в регионе.
5. Проведение работы по первичной и вторичной профилактике ИППП.
6. Учет принадлежности пациента к группам риска, их социально-психологических и поведенческих характеристик, медицинских потребностей и проблем.
7. Создание дружественной атмосферы для пациентов из групп риска в медицинском учреждении.
8. Оценка сексуального риска пациентов.
9. Проведение скрининговых исследований среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами.
10. Проведение мониторинговых исследований на ВИЧ/ИППП среди представителей групп риска (ЖСБ и MSM).

## МЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ГРУПП РИСКА

### ЖЕНЩИНЫ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В СЕКС-БИЗНЕС

По данным О.К.Лосевой (2008), число сексуальных партнеров у женщин, вовлеченных в секс-бизнес, в связи со спецификой работы, многократно превышает таковое у женщин, не связанных с секс-бизнесом. Среднее число половых партнеров за последний год составляет для ЖСБ 295 (в сравнении - для не работающих в этой сфере - 5,8). Если учесть, что из 10 половых контактов презерватив в среднем используется в 6,9 случаях, то около 100 половых контактов в год у ЖСБ являются незащищенными, что представляет широкое поле для инфицирования ИППП.

Наиболее распространенными видами сексуальных услуг являются:

- проникающий вагинальный контакт;
- оральный секс (фелляция), или контакт рта с пенисом;
- оральный секс с последующим вагинальным половым актом;
- мастурбация (удовлетворение руками);
- анальный секс.

Большинство ЖСБ предпочитают непроникающие виды секса, более гигиеничные, менее обременительные для женщин и менее опасные в плане инфицирования ИППП и нежелательной беременности. Эти виды секса занимают меньше времени, что позволяет обслужить больше клиентов и больше заработать. Кроме того, вагинальный секс сопровождается у большинства ЖСБ неприятными ощущениями, болезненностью, сухостью в области влагалища, что обусловлено недостаточной выработкой вагинального секрета, в том числе из-за отсутствия сексуального возбуждения и большого числа контактов. Это может способствовать травмированию слизистой оболочки влагалища и повышению риска инфицирования ИППП.

Практически все ЖСБ практикуют вагинальный секс, подавляющее большинство (80%) – оральный. Наименее распространен и отвергается большин-

ством ЖСБ анальный секс, хотя нередко клиент навязывает его насильно.

Работа в секс-бизнесе сопряжена с высоким риском физического и сексуального насилия. Ему подвергается более 2/3 уличных ЖСБ. Употребление алкоголя и наркотиков является для ЖСБ доступным и приемлемым средством психологической защиты. Это разрушает навыки безопасного сексуального поведения и повышает риск инфицирования.

ЖСБ довольно хорошо осведомлены об основных ИППП – сифилисе, гонорее и ВИЧ-инфекции. Однако о других ИППП знают мало. Осведомленность, однако, не оказывает существенного влияния на поведение. Около 50% ЖСБ вступали в контакт с клиентами, у которых заметили признаки болезни. Еще 2/3 не отказывались от работы, будучи больными, что связано с необходимостью зарабатывать на жизнь. Более половины ЖСБ продолжали работу во время менструации, что повышало возможность распространения инфекций.

Психологическое тестирование показывает у ЖСБ такие черты личности как недоверчивость, настороженность, подозрительность, обидчивость, забывчивость, сопряженные с трудностями контроля над собственными аффектами и поведением. Характерны эпизоды алкоголизации и наркотизации, вспышки гнева, авантюрное и рисковое поведение. Психологические особенности ЖСБ позволяют говорить о наличии у них посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), характерного для жертв катастроф. Такие лица затрудняются или неспособны планировать свои действия, что сказывается на соблюдении правил безопасного сексуального поведения.

Описанные особенности ЖСБ обеспечивают максимальный риск инфицирования ИППП, как для них самих, так и для всех контактных лиц. С другой стороны – дают основание для развития хронических, бессимптомных и смешанных форм ИППП.

По данным О.В.Поршиной и Ю.Е.Кузнецовой (2008), отличительной особенностью ЖСБ является их низкая приверженность к обследованию и лечению. В большинстве случаев женщины посещают врача однократно, на повторный прием приходят единицы, даже за результатами обследования. Воздержание от половых контактов на период лечения для ЖСБ практически невозможно, что делает также весьма проблематичной возможность полного излечения.

Применение синдромного лечения дает возможность не столько излечить пациенток, сколько снизить риск для их здоровья, уменьшить возможность инфицирования их партнеров, как коммерческих, так и некоммерческих. Несмотря на что, синдромное лечение нужно проводить, чтобы снизить риск тяжелых последствий ИППП для здоровья женщин.

В среде ЖСБ существует много мифов о способах профилактики и контрацепции. Практически все женщины, вовлеченные в коммерческий секс, соглашаются по разным причинам на незащищенный секс. Основная причина – сексуальные контакты без использования презерватива с постоянным половым партнером, что расценивается как проявление личной привязанности и доверия. Женщины-потребительницы инъекционных наркотиков соглашаются на небезопасный секс за более высокую плату или в состоянии абстинентного синдрома. Незащищенный секс может быть проявлением насилия к ЖСБ.

Врачи в государственных организациях здравоохранения с неохотой оказывают медицинские услуги представительницам уличного секс-бизнеса, так как они являются «трудными» пациентками. Их психологические особенности не позволяют собрать достоверный анамнез, они не являются на повторные приемы. Патронажная служба не может их разыскать ввиду заведомо ложной информации о месте проживания. Те же проблемы возникают при розыске половых контактов. Характерной является суперинфекция во время лечения, попытки самолечения и резистентность к различным антибиотикам. Типич-



ным является сочетание нескольких инфекций, передаваемых половым путем (микст-инфекция).

Попытки принудительно доставлять ЖСБ на лечение не дают эффекта. Даже находясь в стационаре, пациентки часто самовольно покидают отделение.

Вышеперечисленные особенности женщин, вовлеченных в секс-бизнес, говорят о сложности работы практического врача с этим контингентом. Выходом из создавшейся ситуации является работа доверенного врача, который должен проводить все действия согласно рекомендуемым алгоритмам.

## **МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ СЕКС С МУЖЧИНАМИ**

В доступной медицинской литературе вопросы медицинской помощи МСМ обсуждаются крайне редко. Между тем оказание эффективной помощи этой категории пациентов с ИППП весьма актуально. Среди медицинских работников глубоко укоренилось убеждение, что ничего специфического в проведении лечебно-диагностических и профилактических мероприятий среди представителей данной группы населения нет, поскольку «болезни у всех одинаковые». В результате медицинский персонал не получает знаний и навыков, необходимых для понимания специфических потребностей пациентов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Между тем, по данным научной литературы, частота распространения гомосексуальных практик среди мужчин и женщин в течение всей жизни составляет от 6 до 20%.

У МСМ есть свои специфические потребности, которые необходимо учитывать в медицинской практике. Так, отсутствие социальной поддержки, трудности с принятием собственной сексуальной идентичности, гетеросексуальная настроенность и гомофобия со стороны общества часто являются причиной хронического стресса, который ведет к употреблению алкоголя и психотропных средств. На этой же почве развиваются состояния тревоги, депрессии, приводящие к суициду. Гомосексуальность сама по себе не является причиной депрессии. Но неприятие со стороны общества и социальная стигматизация часто приводят к появлению у геев и лесбиянок депрессивных симптомов.

Психологические и социальные проблемы лиц с гомосексуальным поведением провоцируют более частое (примерно в 30-35%), чем среди гетеросексуалов потребление алкоголя. С другой стороны алкоголь посредством снятия запретов и снижения контроля над ситуацией оказывает существенное влияние на поведение и провоцирует рискованные сексуальные практики. Кроме того, по данным научных исследований алкоголь повышает восприимчивость клеток слизистых оболочек к вирусу иммунодефицита человека.

Важным фактором риска для здоровья среди МСМ является низкий уровень обращаемости в медицинские учреждения для регулярного обследования. В то же время риск для здоровья значительно увеличивают специфические сексуальные практики. Орально-анальный, рецептивный анальный и рецептивный оральный контакт могут послужить причиной заражения гастроинтестинальными инфекциями, вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией и ИППП.

Дискриминационное поведение медперсонала (унижающее, оскорбляющее человеческое достоинство отношение, низкое качество оказываемых услуг, желание поскорее «избавиться» от «неудобного» пациента) провоцирует МСМ к отказу от медицинских услуг, лечению у непрофессионалов и самолечению. Согласно данным зарубежной литературы, при обращении к терапевту около половины МСМ не сообщают о своей гомосексуальной ориентации и столько же – о факте заражения ВИЧ-инфекцией. Из-за распространенных среди врачей предубеждений МСМ часто получают менее качественную помощь.

Некоторые люди, особенно проживающие в небольших городах и в сельской местности, не проходят тест на ВИЧ, поскольку боятся «утечки» инфор-



мации, связанной с их сексуальными предпочтениями, что их идентифицируют как геев и они подвергнутся дискриминации. Некоторые врачи отказываются принимать во внимание нетрадиционную сексуальную ориентацию пациента, в то время как другие настаивают на обязательном тестировании на ВИЧ.

Специфические сексуальные практики среди МСМ делают эту группу очень уязвимой в отношении не только ВИЧ-инфекции и ИППП, но и гепатитов. Опасная сексуальная практика также повышает риск заражения инфекциями, передаваемыми орально-фекальным путем – дизентерия, амебиаз, криптоспоридиоз.

### **СОЗДАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ-МУЖЧИН, ПРАКТИКУЮЩИХ СЕКС С МУЖЧИНАМИ**

Разговор с пациентом на тему о его сексуальной ориентации и раскрытие его сексуальной принадлежности обычно вызывает у него состояние недоверия и тревоги. Это связано, в первую очередь, с табуированностью темы сексуальных отношений между мужчинами в обществе, стигматизацией и неприятием МСМ. В результате большинство пациентов-геев при посещении врача не сообщают ему о своей сексуальной ориентации в основном из-за боязни дискриминации. Чтобы этого избежать, необходимо создать комфортную и доверительную атмосферу.

Для этого доверенный врач может предпринять следующие шаги:

- принять участие в программах социального сопровождения, проводимых в гей-организациях; разместить рекламу своей медицинской практики в в гей-СМИ – это поможет сформировать среду, привлекательную для МСМ еще до того, как пациент открывает дверь кабинета врача;
- повесить рядом с кабинетом врача плакаты или буклеты с позитивным имиджем – поможет продемонстрировать дружественное расположение к МСМ, приходящим на прием;
- уделить внимание в оформлении кабинета и прилегающего к нему помещения символикой международного Дня борьбы со СПИДом (1 декабря) или гей-парада, что популярно среди МСМ;
- продумать вопрос о подписке на гей-журналы и размещении их рядом с кабинетом врача;
- использовать для предварительного опроса пациентов анкету с вопросом о сексуальной принадлежности.

Во время приема пациента врачу следует обращать внимание на слова и обороты, которые он использует. Например, лучше употреблять выражение «статус отношений», а не «семейный статус», использовать понятие «партнер», а не «супруг/супруга» или «муж/жена».

Опрос пациента нужно проводить, демонстрируя эмпатию, открытость и непредвзятость. При разговоре о половых партнерах желательно использовать гендерно-нейтральный язык.

При обсуждении вопросов сексуального здоровья необходимо следующее. Во-первых, сделать заявление, что сбор сексуального анамнеза является для доверенного врача рутинной практикой. Нужно стараться говорить не о сексуальной ориентации, а о сексуальном поведении. В самом начале общения необходимо оценить уровень знаний пациента о рисках заражения ИППП в зависимости от типов сексуальных практик. Нельзя проводить знак равенства между гомосексуальностью и ВИЧ-инфекцией. Желательно попросить пациента пояснить понятия или типы поведения, с которыми не знаком врач. И, наконец, необходимо дать пациенту возможность не отвечать на «щекотливые» вопросы, оставив их на потом.

Очень важным для создания дружественной атмосферы, при которой МСМ могут чувствовать себя в безопасности, является обучение персонала больниц. Оно должно включать такие темы как употребление корректных форм и определений по отношению к пациентам и их значимым знакомым, медицинские проблемы МСМ (употребление наркотиков, насилие со стороны партнера, депрессия, ВИЧ/ИППП, дискриминация в обществе и на рабочем месте), механизм направления к гей-врачам или в дружественные для МСМ медицинские учреждения. Кроме того, подобное обучение техникам общения позволяет снизить тревогу у медицинского персонала при контакте с МСМ или геями.

Чрезвычайно важным является заявление о гарантии конфиденциальности, которое предоставляется в письменной форме каждому пациенту. Это повышает мотивацию МСМ на раскрытие информации, связанной с их сексуальным здоровьем. Желательно, чтобы данный документ был подписан всеми медицинскими работниками, которые имеют общение с МСМ. Он должен подчеркивать, что полученная от пациента информация носит закрытый характер, перечислены все, кто имеет доступ к медицинской карте пациента, описано, как сохраняется конфиденциальность относительно результатов анализов и ситуации, когда конфиденциальность не сохраняется.

### **СХЕМА ОЦЕНКИ СЕКСУАЛЬНОГО РИСКА МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ СЕКС С МУЖЧИНАМИ**

1. Дайте пациенту понять, что обсуждение сексуального здоровья является необходимой частью обследования.

2. Подчеркните, что понимание сексуального поведения необходимо для предоставления ему качественной медицинской помощи.

3. Разъясните, что обсуждение особенностей его сексуального поведения носит конфиденциальный характер.

4. Обсудите с пациентом, какая информация попадет в его медицинскую карту.

#### **Наводящие вопросы:**

- Для того, чтобы оказать Вам наиболее адекватную медицинскую помощь, мне нужно понять, какова Ваша сексуальная жизнь.

- Все, что мы обсуждаем, останется в этом кабинете.

5. Старайтесь не употреблять такие термины, как «натурал», «гей», «гомосексуал», или понятия, которые не связаны со специфическими типами поведения.

6. При сборе анамнеза старайтесь избегать предположений, основанных на возрасте, семейном статусе, инвалидности или других характеристиках пациента.

7. Специфические вопросы о поведении должны быть четко сформулированы и непредвзяты.

#### **Наводящие вопросы:**

- Вы ведете половую жизнь?

- Вы занимаетесь сексом с мужчинами женщинами или и с теми, и с другими?

8. Выясните количество партнеров, частоту использования презервативов и вид сексуального контакта (оральный, анальный, вагинальный).

9. Соберите анамнез по инфекциям, передаваемым половым путем.

10. Если ответы пациента указывают на высокий уровень риска (незащищенные половые контакты, частые ИППП и др.), определите ситуации, в которых имеет место рискованное поведение.

#### **Наводящие вопросы:**

- Мне хотелось бы понять, как употребление алкоголя или наркотиков связано с Вашей сексуальной практикой?

- Как часто Вы вступаете в сексуальные отношения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Насколько и как тогда меняется Ваше поведение?

- Как часто занятия сексом предшествуют подавленность или депрессия?

11. Проанализируйте ответы пациента в конце интервью и дайте ему советы в процессе индивидуального консультирования.

### **СХЕМА СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МУЖЧИНАМИ**

1. Соберите анамнез и проведите физикальное обследование пациента хотя бы один раз в год.
2. Тестируйте пациента на ВИЧ-инфекцию.
3. Тестируйте пациента на сифилис.
4. Тестируйте пациента на гепатиты В и С согласно действующим протоколам диагностики и лечения ИППП.
5. Проводите дальнейшие исследования с учетом оценки сексуального риска пациента.

**Дальнейшие исследования, рекомендуемые для пациентов низкого риска** (имеют моногамные отношения с сексуальным партнером, постоянно используют презерватив, не практикуют принимающий анальный секс)

- Проведите микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов.
- Проведите бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию и *M.genitalium*
- Обследуйте пациента на *C.trachomatis* и герпетические инфекции одним из доступных методов – МАНК, РИФ (ПИФ) или ИФА (на антиген). При диагностике хламидийной инфекции желательно использовать 2 метода.
- Рассмотрите возможности и проведите пациенту исследования на ректальную и фарингеальную культуры гонореи, а также ректальную хламидийную инфекцию

**Дальнейшие исследования, рекомендуемые для пациентов высокого риска** (имеют множественных или анонимных сексуальных партнеров, практикуют принимающий анальный секс, не используют или непостоянно используют презерватив)

- Проводите обследования, как для пациентов низкого риска, каждые 3-6 месяцев
- Оцените риск анального рака в зависимости от типа анального контакта и проводите дальнейшие обследования с учетом данного фактора:  
Для пациентов, не практикующих принимающий анальный секс
  - Обследуйте как пациентов низкого риска
  - При обследовании учитывайте факторы риска (оральный секс, анальный секс)
  - Выясните, изменилось ли сексуальное поведение

**Для пациентов, практикующих принимающий анальный секс**

- Обследуйте пациента на анальный рак (кондиломы, ВИЧ-инфекция)
- Рассмотрите возможность проведения PAP-теста слизистой ануса:
  - проводите PAP-тест ежегодно, если пациент ВИЧ-инфицированный
  - проводите PAP-тест каждые 2-3 года, если пациент не инфицирован ВИЧ

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДОВЕРЕННОГО ВРАЧА

Для совершенствования противоэпидемических мероприятий в очаге ИППП доверенный врач может использовать специально разработанные анкеты для пациентов: приложение 1.

**1. Попросите пациента** ответить на вопросы анкеты из приложения 1, пока они ожидают своей очереди в приемной. Это даст время, чтобы обдумать «трудные» вопросы и ознакомиться с вопросами, которые он может ожидать от врача.

**2. Беседа** с пациентом, просмотрите анкету. Заполните позиции, оставшиеся без ответа.

**3. Проведите клиническое обследование** и заполните медицинскую карту амбулаторного больного ИППП (приложение 4).

**4. Для повышения качества описания клинических проявлений ИППП** используйте Протокол первичного урологического осмотра мужчины и Протокол первичного гинекологического осмотра женщины (приложение 5).

**5. Соберите образцы** для прямой микроскопии (раздел 13.1) и проведите исследование.

**6. Проведите консультирование пациента** в соответствии с Диагнозом (раздел 9).

**7. Разъясните пациенту алгоритм индивидуальной профилактики ИППП с помощью механических и антисептических средств** (раздел 10).

**8. Используйте алгоритм ведения пациента** в соответствии с симптомами заболевания (раздел 11).

**9. Проверьте, не забыли ли Вы взять материал** для проведения обязательных диагностических исследований на сифилис, гонококковую инфекцию, урогенитальную хламидийную инфекцию, трихомониаз, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С (раздел 13).

**10. Проверьте, не забыли ли Вы взять материал** для проведения диагностики других ассоциированных с половым путем передачи заболеваний, исходя из данных анамнеза, клинических проявлений и данных предварительного исследования: урогенитальный кандидоз, аногенитальный герпес, папилломавирусную инфекцию, чесотку, бактериальный вагиноз, фтириаз (раздел 13).

**11. Разъясните пациенту алгоритм выдачи результатов** при лабораторном исследовании на ИППП (раздел 13.2 – 13.10).

**12. Заполните формы отчетности при работе с пациентами из групп риска** (приложение 3).

# АЛГОРИТМЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛИЦ С РИСКОВАННЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

36

9

Консультирование по поводу инфекций, передаваемых половым путем, является неотъемлемой частью лечебно-диагностического процесса. Доверенный врач должен рассказать своим пациентам об их заболевании, должен уметь понятным и доступным языком объяснить то, что необходимо сказать о принципах лечения и профилактике. Целью консультирования является предупреждение повторного заражения ИППП и предотвращение заражения окружающих людей. Доверенному врачу необходимо придерживаться определенного алгоритма, который позволяет провести консультирование наиболее эффективно при минимальных затратах времени.

Многих пациентов с ИППП можно отнести к категории лиц с рискованным сексуальным поведением. При работе с пациентами, вовлеченными в сферу коммерческих сексуальных услуг, доверенный врач должен обращать их внимание на необходимость избегать контакта с коммерческими и некоммерческими половыми партнерами, если у них есть признаки ИППП. Если это сделать невозможно, то практиковать менее опасный секс. После контакта с таким партнером необходимо провести экстренную профилактику, даже при использовании презерватива. При первой возможности обратиться к доверенному врачу для проведения экстренной медикаментозной профилактики.

Процесс консультирования состоит из нескольких частей. Это информирование, обсуждение ситуации и принятие решения о лечении, то есть действия пациента на основе полученной информации. Очень важным является просвещение пациента, которое представляет собой часть консультирования. Просвещение не является синонимом информирования. Информирование – это предоставление информации, фактов без их комментирования и трактовки. Просвещение – более широкое понятие, которое включает разъяснение фактов, использование методов убеждения пациентов.

Просвещение позволяет привлечь пациента к сотрудничеству с врачом по очень важной для него причине – необходимости лечения имеющегося у него заболевания. С другой стороны, доверенный врач в этот момент имеет возможность научить пациента, как в будущем он сможет предотвратить повторное заражение.

Посещение медицинского учреждения является уникальной возможностью для просвещения пациента. Именно в этот момент он наиболее восприимчив, поскольку во время заболевания у него повышается потребность в информации.

Если пациент получит достоверную информацию о своей болезни, его причину и как должно проходить лечение, то лечение будет более эффективным. С другой стороны для профилактики повторного заражения нередко требуется изменение стереотипа сексуального поведения. И наиболее сильным стимулом для этого является заболевание, от которого нужно избавиться. Как раз в это время пациенту нужны просвещение, убеждение и моральная поддержка.

## 9.1. Алгоритм консультирования при гонококковой инфекции

### Причина заболевания и его распространенность

- Скажите пациенту(ке), что у него(нее) гонорея – инфекционное заболевание бактериального происхождения. Разъясните, насколько часто оно встречается.

### Диагноз

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.



## **Заражение, симптомы**

- Объясните, что он(а) заразился(лась) гонореей от партнера, с которым они имели незащищенные сексуальные контакты, и который, в свою очередь, был инфицирован кем-то еще, недавно либо давно. Таким образом инфекция была передана ему(ей).

- Скажите, что многие женщины и мужчины не замечают никаких симптомов. Однако если симптомы появляются, это обычно происходит через 2-5 дней после заражения.

## **Осложнения**

Объясните всем пациентам, что...

### **У женщин:**

- Если гонорею не лечить, могут возникнуть серьезные проблемы:
  - гонорея может распространиться на матку и маточные трубы. Это может стать причиной воспалительного заболевания органов малого таза (ВЗОМТ);
  - в результате ВЗОМТ образуются спайки, что может затруднить наступление беременности в будущем и увеличить риск внематочной беременности (беременность развивается не в матке, а в маточной трубе);
  - при ВЗОМТ может потребоваться госпитализация.

### **У мужчин:**

Гонорея может явиться причиной боли в яичках и их опухания, воспаления предстательной железы (простатит), что, в свою очередь, может привести к бесплодию.

При консультировании мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, разъясните, что простатит – это бактериальная инфекция, которая распространяется из мочеиспускательного канала, а не что-то, что можно получить в результате анального секса.

### **У женщин и мужчин:**

Если гонорею не лечить, бактерии могут попасть в кровь и распространиться по всему организму; в ряде случаев отмечается болезненность и опухание суставов.

## **Беременность**

- Спросите, не беременна ли пациентка или не исключает ли она такой возможности. Скажите, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

- В дополнение, скажите пациентам, как мужчине, так и женщине, что если гонорею не лечить, то она может:
  - стать причиной преждевременных родов;
  - передаться ребенку во время родов, вызвав поражение глаз и других органов.

## **Лечение**

- Расскажите пациенту(ке), как Вы собираетесь его(ее) лечить.
- Если Вы выписываете ему(ей) препараты, которые он(а) будет принимать самостоятельно, объясните, что для эффективности лечения очень важно принимать лекарства в соответствии с инструкцией и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли раньше.
- Предложите пациенту(ке) обратиться к Вам, если возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарств.
- При необходимости проверки эффективности лечения, договоритесь с пациентом(кой) о дате следующего визита.
- Скажите пациенту(ке), что очень важно сказать своим половым партнерам о заболевании и убедить их прийти в лечебное учреждение для получения более подробной информации и лечения, даже если у них отсутствуют какие-либо симптомы.
- Спросите, может ли пациент(ка) сказать половым партнерам о своем забо-



левании. Если не может, обсудите альтернативные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Профилактика**

#### **Скажите пациенту(ке), что...**

- Для предупреждения заражения других он(а) должен(жна) избегать половых сношений до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше.
- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов.
- Если половых сношений невозможно избежать во время лечения пациента(ки) или до того, как его(ее) партнеры пройдут курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациента(ки) другим или его(ее) повторного заражения.
- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут заразиться вновь, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем могут передать инфекцию ему(ей). Если пациент(ка) не уверен(а) в верности своих партнеров, посоветуйте ему(ей) практиковать менее опасные и безопасные виды секса.
- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.
- При консультировании мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, следует подчеркнуть, что лучший способ профилактики простатита (хронического или острого) – предотвратить проникновение бактерий в мочеиспускательный канал. Для этого необходимо использовать презервативы для орального и анального секса, отказаться от введения нестерильных предметов, включая сексуальные игрушки, в мочеиспускательный канал.
- Менее опасные виды секса включают:
  - использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);
  - оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;
  - стимуляция полового партнера рукой.
- **Безопасный секс включает:**
  - мастурбацию;
  - использование индивидуальных сексуальных игрушек;
  - длительные моногамные отношения со здоровым партнером.
- **Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.
- **Очень важно**, чтобы пациент(ка) поговорил(а) с половыми партнерами о менее опасных и безопасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своим партнерам.

#### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

#### **Ваши рекомендации пациенту(ке):**

Скажите пациенту(ке), что в будущем... если он(а) или его(ее) партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он(а) должен(а) придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

## **9.2. АЛГОРИТМ консультирования при негонококковом уретрите (НГУ)**

### **- Мужчины**

#### **Причина заболевания**

- Скажите Вашему пациенту, что у него НГУ - инфекционное заболевание, которое может вызываться различными бактериями, но наиболее частой причиной являются хламидии.

#### **Диагноз**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

#### **Заражение**

Объясните, что...

- Пациент заразился НГУ от партнерши(а), с которой(ым) он имел незащищенные половые контакты и которая(ый) в свою очередь, был(а) инфицирован(а) кем-то еще, недавно или уже давно. Таким образом, инфекция была передана ему.
- У многих мужчин симптомы не наблюдаются. Если же симптомы есть, они проявляются в виде жжения при мочеиспускании или в виде прозрачных или белых (мутных) выделений из полового члена. Эти симптомы обычно проявляются через 1-5 недель после заражения.

#### **Осложнения**

- Скажите пациенту, что если негонококковый уретрит не лечить, он может распространиться и вызвать боль и опухание яичек.

#### **Лечение**

- Расскажите пациенту, как Вы собираетесь его лечить.
- Если Вы выписываете ему препараты, которые он будет принимать самостоятельно, объясните, что для эффективности лечения очень важно принимать лекарства в соответствии с инструкцией и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли раньше.
- Предложите пациенту обратиться к Вам, если возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарств.
- При необходимости проверки эффективности лечения, договоритесь с пациентом(кой) о дате следующего визита.
- Скажите пациенту, что очень важно сказать своим половым партнерам о заболевании и убедить их прийти в лечебное учреждение для получения более подробной информации и лечения, даже если у них отсутствуют

какие-либо симптомы.

- Спросите, может ли пациент сказать половым партнерам о своем заболевании. Если не может, обсудите альтернативные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Профилактика**

#### **Скажите пациенту, что...**

- Для предупреждения заражения других он должен избегать половых сношений до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше.

- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов.

- Если половых сношений невозможно избежать во время лечения пациента или до того, как его партнеры пройдут курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациента другим или его повторного заражения.

- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут заразиться вновь, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем могут передать инфекцию ему. Если пациент не уверен в верности своих партнеров, посоветуйте ему практиковать менее опасные и безопасные виды секса.

- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);

- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член - рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот - влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- стимуляция полового партнера рукой.

- Безопасный секс включает:

- мастурбацию;

- использование индивидуальных сексуальных игрушек;

- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

- **Разъясните** пациенту алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

- **Очень важно**, чтобы пациент поговорил с половыми партнерами о менее опасных и безопасных видах секса. Спросите пациента о том, как он может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он скажет своим партнерам.

#### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента, не хотел бы он обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

#### **Ваши рекомендации пациенту:**

Скажите пациенту, что в будущем...

если он или его партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он должен прийти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту, что он получил сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него вопросы, которые он хотел бы обсудить.

### **9.3. АЛГОРИТМ консультирования при хламидийной инфекции**

#### **Причина заболевания и его распространенность**

- Скажите пациенту(ке), что у него(нее) хламидийная инфекция - инфекционное заболевание бактериального происхождения. Разъясните насколько часто оно встречается.

#### **Диагноз**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

#### **Заражение, симптомы**

- Объясните, что он(а) заразился(лась) хламидиозом от партнерши(а), с которым они имели незащищенные сексуальные контакты, и который, в свою очередь, был инфицирован кем-то еще, недавно либо давно. Таким образом инфекция была передана ему(ей).
- Скажите, что многие женщины и мужчины не замечают никаких симптомов. Однако если симптомы появляются, это обычно происходит через 1-3 недели после заражения.

#### **Осложнения:**

Объясните всем пациентам, что...

#### **У женщин:**

- Если не провести лечения, хламидиоз может вызвать серьезные проблемы:
  - хламидийная инфекция может распространиться на матку и маточные трубы и вызвать ВЗОМТ (воспалительное заболевание органов малого таза);
  - ВЗОМТ может вызвать изменения в маточных трубах, в будущем препятствующие наступлению беременности, и увеличить риск развития внематочной беременности, т.е. беременности, которая развивается в маточной трубе;
  - при ВЗОМТ может потребоваться госпитализация.

#### **У мужчин:**

- хламидиоз обычно не вызывает осложнений, но важно, чтобы мужчины прошли курс лечения, чтобы не заразить своих партнеров;
- в редких случаях инфекция может вызвать боль в яичках, их припухлость или боль в суставах, а также привести к воспалению предстательной железы (простатит) и бесплодию.

При консультировании мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, разъясните, что простатит – это бактериальная инфекция, которая рас-

пространяется из мочеиспускательного канала, а не что-то, что можно получить в результате анального секса.

### **Беременность**

- Спросите пациентку не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности. Скажите ей, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

- Скажите всем пациентам, что если не проводить лечения во время беременности, то хламидиоз может вызвать преждевременные роды, передаться ребенку во время родов и вызвать у него заболевание глаз и легких.

### **Лечение**

- Расскажите пациенту(ке), как Вы собираетесь его(ее) лечить.
- Если Вы выписываете ему(ей) препараты, которые он(а) будет принимать самостоятельно, объясните, что для эффективности лечения очень важно принимать лекарства в соответствии с инструкцией и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли раньше.

- Предложите пациенту(ке) обратиться к Вам, если возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарств.

- При необходимости проверки эффективности лечения, договоритесь с пациентом(кой) о дате следующего визита.

- Скажите пациенту(ке), что очень важно сказать своим половым партнерам о заболевании и убедить их прийти в лечебное учреждение для получения более подробной информации и лечения, даже если у них отсутствуют какие-либо симптомы.

- Спросите, может ли пациент(ка) сказать половым партнерам о своем заболевании. Если не может, обсудите альтернативные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Профилактика**

#### **Скажите пациенту(ке), что...**

- Для предупреждения заражения других он(а) должен(жна) избегать половых сношений до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше.

- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов.

- Если половых сношений невозможно избежать во время лечения пациента(ки) или до того, как его(ее) партнеры пройдут курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациента(ки) другим или его(ее) повторного заражения.

- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут заразиться вновь, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем могут передать инфекцию ему(ей). Если пациент(ка) не уверен(а) в верности своих партнеров, посоветуйте ему(ей) практиковать менее опасные и безопасные виды секса.

- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.

- При консультировании мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, следует подчеркнуть, что лучший способ профилактики простатита (хронического или острого) – предотвратить проникновение бактерий в мочеиспускательный канал. Для этого необходимо использовать презервативы для



орального и анального секса, отказаться от введения нестерильных предметов, включая сексуальные игрушки, в мочеиспускательный канал.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);

- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот – анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- стимуляция полового партнера рукой.

- **Безопасный секс включает:**

- мастурбацию;

- использование индивидуальных сексуальных игрушек;

- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

- **Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

- **Очень важно**, чтобы пациент(ка) поговорил(а) с половыми партнерами о менее опасных и безопасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своим партнерам.

#### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

#### **Ваши рекомендации пациенту(ке):**

Скажите пациенту(ке), что в будущем...

если он(а) или его(ее) партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;

- или жжение при мочеиспускании;

- зуд и раздражение половых органов;

- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;

- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;

- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он(а) должен(а) придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

## **9.4. АЛГОРИТМ консультирования при аногенитальной герпетической инфекции**

### **Причина заболевания и его распространенность**

Скажите пациенту(ке), что у него(нее) герпес -инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Разъясните, что герпес - часто встречающееся заболевание.



## Диагноз

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

## Заражение, симптомы

Объясните, что...

- Пациент(ка) заразился(лась) герпесом от полового партнера, который, в свою очередь, был инфицирован кем-то еще, недавно или уже давно. Таким образом инфекция была передана ему(ей).
- Оральный герпес (т.е. герпес в области рта) - заболевание, не обязательно передающееся половым путем. Тем не менее, оральный герпес может перейти на половые органы при орально-генитальном сексе.
- Сначала появляются пузырьки, которые затем вскрываются, а образовавшиеся язвочки вскоре покрываются корочками. Язвочки обычно заживают в течение 10—14 дней, но вирус остается в организме.
- В язвочках, которые могут появиться вне влагалища, полового члена, прямой кишки, на ягодицах, бедрах, во рту, присутствует вирус. При прямом контакте с язвочками можно заразиться.
- Можно передать инфекцию другим или заразиться от инфицированного человека, даже когда язвочки уже зажили.

## Осложнения

Объясните, что...

- Препаратов, которые лечат герпес, пока нет.
- при обострении герпеса язвочки появляются вновь через некоторое время после полного их исчезновения;
- У ВИЧ-инфицированных людей поражения могут быть более тяжелыми и более длительными.

## Беременность

- Спросите пациентку не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности. Скажите ей, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.
- Скажите, что она может заразить ребенка герпесом во время беременности и особенно во время родов через родовые пути. Зараженный ребенок может тяжело заболеть и даже умереть.
- Скажите, что нужно обязательно сообщить своему гинекологу о герпесе для того, чтобы принять соответствующие меры предосторожности для уменьшения риска заражения ребенка.

## Лечение

Объясните, что...

- Несмотря на то, что герпес не излечивается полностью, имеются противовирусные препараты, которые могут ускорить время заживления язвочек и помогают предупредить их повторное появление.
- Если у пациента(ки) возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарств, ему(ей) следует обратиться к Вам.
- Самочувствие может улучшиться, если:
  - принимать дважды в день лечебные ванночки с пищевой содой, растворенной в небольшом количестве теплой воды;
  - содержать пораженные области сухими и в чистоте; принимать болеутоляющие средства, такие как анальгин, аспирин.
- Некоторые люди отмечают обострение болезни при стрессе. Если это может относиться к пациенту, то имеет смысл обсудить способы преодоления стрессовых ситуаций. Солнечное облучение также может вызвать обострение; лучше избегать пребывания на солнце или использовать солнцезащитный крем.
- Спросите, может ли пациент(ка) сказать половым партнерам о своем забо-

левании. Если нет, обсудите альтернативные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Профилактика**

#### **Расскажите пациенту(ке), что...**

- Поскольку герпес нельзя вылечить, важно не заразить половых партнеров. Заражение может произойти даже при отсутствии язвочек.

- Для предупреждения заражения партнера(ов) важно избегать любого контакта с язвочкой до тех пор, пока она полностью не зажила, то есть от нее не осталось никаких следов. Самый легкий путь избежать контакта - это не вступать в сексуальные контакты до полного заживления язвочки. Если невозможно избежать половых контактов во время обострения, следует практиковать менее опасные и безопасные виды секса, тем самым снижая риск заражения других. Риск заражения не исчезает и при использовании презерватива, если язвочки располагаются в области, не защищенной презервативом.

- Люди часто испытывают покалывание или зуд в том месте, где должна появиться язвочка. Риск заражения максимален непосредственно перед и во время обострения. В это время желательно избегать половых контактов.

- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без использования презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);

- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член - рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот - влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- стимуляция полового партнера рукой.

- Безопасный секс включает:

- мастурбацию;

- использование индивидуальных сексуальных игрушек;

- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

**Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

**Очень важно** поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).

#### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

#### **Ваши рекомендации пациенту(ке):**

Скажите пациенту(ке), что в будущем...

если он(а) или его(ее) партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из пе-

речисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он(а) должен(а) прийти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

## **9.5. АЛГОРИТМ консультирования при аногенитальных бородавках**

### **Причина заболевания и его распространенность**

Скажите пациенту(ке), что у него(нее) обнаружены генитальные бородавки, которые вызываются вирусом папилломы человека. Генитальные бородавки широко распространены среди сексуально активных взрослых людей.

### **Диагноз**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз - у женщин исследование мазков из шейки матки на атипичные клетки иногда подтверждает наличие бородавок, и тогда требуется проведение дополнительных анализов.

### **Заражение, симптомы**

#### **Объясните, что...**

- Пациент(ка) заразился(лась) генитальными бородавками от партнера, с которым они имели незащищенные сексуальные контакты и который, в свою очередь, был инфицирован кем-то еще, недавно или уже давно. Таким образом инфекция была передана ему(ей);
- Вирус передается при прямом контакте с бородавками или с кожей, которая инфицирована вирусом;
- Возможно заражение от партнера, у которого нет никаких видимых проявлений болезни.

Если бородавки располагаются на слизистой оболочке влагалища и на шейке матки, они могут быть замечены только при осмотре влагалища.

- Обычно после заражения проходит 2-6 месяцев до появления бородавок. Появившись какое-то время назад, бородавки могли оставаться невидимыми для пациента(ки).

### **Осложнения**

- Осложнения от самих бородавок очень редки, если только они не становятся очень большими.
- Некоторые типы вируса, которые вызывают генитальные бородавки, могут привести к появлению атипичных клеток шейки матки у женщин. Эти изменения называются дисплазией, которая при отсутствии лечения, может привести к развитию рака шейки матки.

### **Беременность**

- Спросите пациентку не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности, так как некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.
- Объясните, что ребенок может заразиться ВПЧ от матери внутриутробно или во время родов. У него могут появиться бородавки на половых органах,

вокруг ануса или в горле. Однако, риск заражения очень мал.

## **Лечение**

### **Объясните, что...**

- Имеются различные виды лечения, которые позволяют удалить бородавки, но бородавки могут появляться вновь, т.к вирусы, вызывающие их, остаются в коже после удаления бородавок.

- Расскажите пациенту(ке) как Вы собираетесь его(ее) лечить.

- Объясните пациенту(ке), что он(а) обязательно должен(жна) прийти к Вам на прием еще раз, чтобы проверить эффективность лечения. Договоритесь о дате следующего визита.

- Очень важно, чтобы пациент(ка) рассказал(а) своим половым партнерам о заболевании и убедил(а) их прийти в лечебное учреждение для получения более подробной информации и лечения.

- Спросите, может ли пациент(ка) сказать половым партнерам о своем заболевании. Если не может, обсудите возможные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

## **Профилактика**

### **Скажите пациенту(ке), что...**

- Для предупреждения заражения других он(а) должен(жна) избегать половых сношений до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше.

- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов.

- Если половых сношений невозможно избежать во время лечения пациента(ки) или до того, как его(ее) партнеры пройдут курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациента(ки) другим или его(ее) повторного заражения.

- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут заразиться вновь, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем могут передать инфекцию ему(ей). Если пациент(ка) не уверен(а) в верности своих партнеров, посоветуйте ему(ей) практиковать менее опасные и безопасные виды секса.

- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);

- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- стимуляция полового партнера рукой.

- **Безопасный секс включает:**

- мастурбацию;

- использование индивидуальных сексуальных игрушек;

- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

**Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисепти-

ческих средств для индивидуальной профилактики ИППП.

Очень важно поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).

### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

### **Ваши рекомендации пациенту(ке):**

Скажите пациенту(ке), что в будущем...

если он(а) или его(ее) партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он(а) должен(а) прийти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

## **9.6. АЛГОРИТМ консультирования при сифилисе**

### **Причина заболевания и его распространенность**

- Скажите пациенту(ке), что у него(нее) сифилис - инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии, называемые бледными спирохетами и имеющие спиралевидную форму. Расскажите о распространенности данного заболевания в Вашем регионе.

### **Диагноз и необходимость противоэпидемических мероприятий**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

- Врач устанавливает Диагноз на основании характерной клинической картины, а также обнаружения спирохеты в отделяемом с поверхности язвочки при первичном сифилисе и других мокнущих высыпаний при вторичном сифилисе. Кроме того, у пациента в крови обнаруживают особые тельца (антигены), говорящие о наличии в организме спирохеты. Такое исследование называется серологическим. Серологическое исследование крови проводится обычно многократно в процессе лечения и наблюдения за больным.

- Объясните, что сифилис относится к «болезням, опасным для общества». Это обязует врача и больного к общей ответственности, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции – обследование сексуальных контактов.

### **Заражение**

- Объясните, что он(а) заразился(лась) сифилисом от партнера, с которым они имели незащищенные половые контакты и который(ая), в свою очередь, был инфицирован(а) кем-то другим недавно или давно. Таким образом инфек-



ция была передана пациенту(ке).

- Скажите, что бактерии, которые вызывают сифилис, локализуются в язвочках, которые чаще всего появляются у входа во влагалище, на половом члене, в прямой кишке, на ягодицах или слизистой оболочке рта. При прямом контакте с этими язвочками происходит заражение.

- Расскажите о других путях передачи сифилиса – бытовое заражение, переливание крови, вертикальный путь (от матери ребенку во время беременности).

### **Стадии заболевания и осложнения**

#### **Расскажите, что...**

если сифилис не лечить, он проходит три стадии развития.

**Первая стадия** (через 2–6 недель после заражения):

- безболезненная язвочка, называемая шанкром, чаще всего появляется в месте внедрения бактерий (у входа во влагалище, на половом члене или в прямой кишке, хотя может появиться на любой части тела);

- припухшие безболезненные лимфатические узлы (железы), близлежащие к месту расположения язвочки;

- если не проводить лечения, язвочка сама заживает через 3–6 недель.

**Вторая стадия** (через 8–12 недель после появления язвочки):

- сыпь по всему телу, включая ладони и подошвы;

- боли в мышцах, утомляемость;

- припухшие безболезненные лимфатические узлы (железы) по всему телу.

**Третья стадия** (нелеченый сифилис продолжительностью больше года):

- в течение многих лет нет никаких симптомов. Это латентный сифилис;

- в конечном итоге, если лечение не проводится, инфекция может поразить любую часть организма и привести к инвалидности. Чаще всего возникают заболевания сердца или нервной системы.

### **Беременность**

- Спросите пациентку не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности. Скажите ей, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

- Скажите всем пациентам, и мужчинам и женщинам, что если сифилис не лечить, он может передаться ребенку во время беременности матери. Это называется врожденным сифилисом. Врожденный сифилис может вызвать у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. Однако ребенок может родиться здоровым, если во время беременности провести лечение как можно раньше. Поэтому очень важно, чтобы беременные женщины обязательно обследовались на сифилис.

### **Лечение**

- Расскажите пациенту(ке), как Вы собираетесь его(ее) лечить: проводиться антибиотиками в инъекциях. Инфекция вылечивается, если полностью соблюдается курс лечения. После лечения проводиться контроль излеченности, для чего исследуется кровь.

- Объясните пациенту(ке), что он(а) обязательно должен(на) прийти к Вам на прием еще раз, чтобы проверить эффективность лечения. Договоритесь о дате следующего визита.

- Очень важно, чтобы пациент(ка) рассказал(а) своим половым партнерам о заболевании и убедил(а) их прийти в лечебное учреждение для получения более подробной информации и лечения.

Спросите, может ли пациент(ка) сказать половым партнерам о своем заболевании. Если нет, обсудите другие возможные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.



## Профилактика

### Скажите пациенту(ке), что:

- Для предупреждения заражения других он(а) должен(жна) избегать половых сношений до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше. Нельзя сдавать кровь в качестве донора!

- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов

- Если нельзя избежать половых сношений во время лечения пациента или до того, как его(ее) партнеры пройдут курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациента(ки) другим или его(ее) повторного заражения. Однако если шанкр расположен в месте, которое невозможно защитить презервативом, риск передачи инфекции остается высоким.

- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут вновь заразиться, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем передать инфекцию ему(ей). Если пациент(ка) не уверен(а) в верности своих партнеров, посоветуйте ему(ей) практиковать с ними менее опасные и безопасные виды секса.

- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, но полностью его исключить нельзя.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);

- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- стимуляция полового партнера рукой.

- **Безопасный секс включает:**

- мастурбацию;

- использование индивидуальных сексуальных игрушек;

- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

**Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

**Очень важно** поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).

### Обследование на ВИЧ-инфекцию

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

### Ваши рекомендации пациенту(ке):

Скажите пациенту(ке), что в будущем...

если он(а) или его(ее) партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились

ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или

вокруг них;

- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он(а) должен(а) придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации. Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

### **9.7. АЛГОРИТМ консультирования при урогенитальном кандидозе**

**Причина заболевания, распространенность и факторы предрасполагающие к заболеванию**

- Скажите Вашей пациентке, что у нее кандидоз (в обиходе - молочница). Кандидоз вызывается дрожжеподобными грибами и развивается в результате нарушения баланса микроорганизмов, обычно присутствующих во влагалище. Расскажите, что это заболевание часто встречается у женщин.

- Скажите, что кандидоз **не относится** к инфекциям, передаваемым половым путем.

- Существуют факторы, увеличивающие вероятность возникновения кандидоза, включая недавний прием антибиотиков, спринцевание и применение женских гигиенических средств, ношение слишком тесного нижнего белья, беременность, а также некоторые заболевания, например, некомпенсированный диабет, ВИЧ-инфекция, системная красная волчанка. Тем не менее, у женщины может появиться кандидоз и без наличия любого из этих факторов.



## Диагноз

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

## Осложнения

- Скажите женщине, что при кандидозе осложнений не бывает. При тяжелом его течении некоторые женщины испытывают сильный дискомфорт.

## Беременность

- Спросите женщину не беременна ли она или не исключает ли она такую возможность, так как некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

## Лечение

- Расскажите пациентке, как Вы собираетесь ее лечить.
- Если Вы назначаете ей препараты, которые она будет принимать самостоятельно, объясните, что для эффективного лечения, очень важно принимать лекарства, как рекомендовано и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли до его завершения.
- Скажите пациентке, что если у нее возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарств, ей следует обратиться к Вам.
- Скажите женщине, что в течение лечения рекомендуется использовать презерватив при половом контакте: половой член - влагалище.

## Профилактика

### Объясните, что...

- Для предотвращения повторных случаев возникновения кандидоза следует избегать ношения слишком тесной одежды, не применять спринцевание и женские гигиенические средства, рекомендуется носить хлопчатобумажное нижнее белье.
- Если кандидоз часто повторяется, возможно, имеет смысл пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и диабет.

## Снижение риска ИППП и ВИЧ-инфекции

Несмотря на то, что кандидоз и не является инфекцией, передаваемой половым путем, воспользуйтесь случаем обсудить с пациенткой возможный риск заражения ИППП или ВИЧ-инфекцией. Если Вы считаете, что поведение женщины может или могло привести к заражению ИППП или ВИЧ-инфекцией, **расскажите ей следующее...**

- Заражения ИППП или ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, можно избежать практикуя менее опасные и безопасные виды секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без использования презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.
- Менее опасные виды секса включают:
  - использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);
  - оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;
  - стимуляция полового партнера рукой.
- **Безопасный секс включает:**
  - мастурбацию;
  - использование индивидуальных сексуальных игрушек;
  - длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

**Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

**Очень важно** поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).

- Объясните женщине, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем, и спросите, не хочет ли она обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

**Ваши рекомендации пациентке:**

**Скажите пациентке, что в будущем...**

если она или ее партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что она должна придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациентке, что она получила сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у нее вопросы, которые она хотела бы обсудить.

## **9.8. АЛГОРИТМ консультирования при бактериальном вагинозе**

**Причина заболевания и факторы предрасполагающие к заболеванию :**

- Скажите пациентке, что у нее бактериальный вагиноз (БВ) - заболевание, которое вызывается бактериями, обычно присутствующими во влагалище у здоровых женщин. БВ возникает, когда нарушается нормальное соотношение этих бактерий во влагалище.

- БВ не относится к инфекциям, передаваемым половым путем, однако чаще встречается у сексуально активных женщин.

- Секс без использования презерватива может вызвать БВ или усилить его симптомы из-за влияния спермы на бактерии, присутствующие во влагалище.

- Существуют факторы, предрасполагающие к развитию БВ, такие как спринцевание, использование пены для ванн и использование женских гигиенических средств. К тому же, БВ чаще встречается у женщин, имеющих новых половых партнеров.

**Диагноз**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

**Осложнения :**

- **Объясните всем пациенткам**, что БВ может увеличить риск развития инфекционных осложнений после хирургических вмешательств в области половых органов, после аборта или родов.

**Беременность**

- Спросите женщину не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности. Скажите ей, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

- Если не лечить БВ во время беременности, то он может вызвать преждевременные роды.

### **Лечение**

- Расскажите женщине, как Вы собираетесь ее лечить.
- Объясните, что для эффективности лечения очень важно принимать лекарства так, как рекомендовано и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли до его завершения.
- Если Вы назначаете метронидазол (трихопол) или тинидазол, скажите пациентке, что она может почувствовать себя очень плохо, если во время лечения будет употреблять алкоголь. Чтобы избежать этого, нельзя употреблять алкогольные напитки за сутки до начала и в течение суток после окончания лечения.
- Объясните, что рекомендуется избегать половых контактов «половой член – влагалище» без презерватива до окончания лечения.
- Объясните, что если у нее возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарств, ей следует обратиться к Вам.

### **Профилактика:**

- Скажите пациентке, что уменьшение частоты спринцеваний или отказ от них, отказ от применения женских гигиенических средств и использование презерватива при вагинальном сексе могут предотвратить повторное развитие БВ.

### **Снижение риска ИППП и ВИЧ-инфекции**

Несмотря на то, что БВ и не является ИППП, обсудите с пациенткой возможный риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией. Если Вы считаете, что поведение женщины может или могло привести к заражению, **скажите ей, что...**

- Хотя БВ и не передается половым путем, избежать заражения ИППП или ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу можно, практикуя менее опасные и безопасные виды секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без использования презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, хотя полностью его исключить нельзя.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);
- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;
- стимуляция полового партнера рукой.

- **Безопасный секс включает:**

- мастурбацию;
- использование индивидуальных сексуальных игрушек;
- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

Разъясните пациентке алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

Очень важно поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациентку о том, как она может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите ее попрактиковаться, рассказав Вам, что и как она скажет своему(им) партнеру(ам).

### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

Объясните женщине, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем, и спросите, не хочет ли она обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

### **Ваши рекомендации пациенту(ке):**

Скажите пациентке, что в будущем...

если она или ее партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что она должна придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациентке, что она получила сегодня много информации, и что у посетителей обычно возникают вопросы. Спросите, есть ли у нее вопросы, которые она хотела бы обсудить.

## **9.9. АЛГОРИТМ консультирования при трихомониазе**

### **Причина заболевания, распространенность**

- Скажите Вашему пациенту(ке), что у него(нее) трихомониаз – весьма распространенное инфекционное заболевание, которое вызывается простейшими одноклеточными паразитами - трихомонадами.

### **Диагноз**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

### **Заражение:**

- Объясните, что он(а) заразился(лась) трихомониазом от партнера, с которым они имели незащищенные половые контакты и который(ая), в свою очередь был инфицирован(а) кем-то, недавно или давно. Таким образом инфекция была передана ему(ей).
- Скажите, что у многих людей, зараженных трихомониазом, нет никаких симптомов. Если симптомы появляются, это обычно происходит через 1-3 недели после заражения.

### **Осложнения**

#### **Объясните, что...**

- Если не проводить лечения, то трихомониаз может вызвать преждевременные роды.
- Другие осложнения встречаются редко.

### **Беременность**

- Спросите пациентку, не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности.
- Скажите ей, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

### **Лечение**

- Расскажите пациенту(ке), как Вы собираетесь его(ее) лечить.
- Если Вы выписываете ему(ей) препараты, которые он(а) будет принимать самостоятельно, объясните, что для эффективного лечения очень важно принимать лекарства так, как рекомендовано, и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли до завершения курса лечения.
- Если Вы назначаете метронидазол или тинидазол, скажите пациенту(ке), что он(а) может почувствовать себя очень плохо, если во время лечения будет употреблять алкоголь. Чтобы избежать этого, нельзя пить алкогольные напитки за сутки до начала и в течение суток после окончания лечения.
- Если у пациента(ки) возникнут какие-то проблемы во время приема лекарства, попросите его(ее) обратиться к Вам.



- Объясните пациенту(ке), что очень важно сказать своим половым партнерам о заболевании и убедить их прийти в лечебное учреждение для получения более подробной информации и лечения, даже если у них отсутствуют какие-либо симптомы.

- Спросите, может ли пациент(ка) сказать половому(ым) партнеру(ам) о своем заболевании. Если нет, обсудите другие возможные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Профилактика**

#### **Скажите пациенту(ке), что...**

- Для предупреждения заражения других он(а) должен(жна) избегать половых сношений до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше.

- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов.

- Если нельзя избежать сексуальных контактов во время лечения самого(ой) пациента(ки) или до того, как его(ее) партнеры пройдут курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациента(ки) другим или его(ее) повторного заражения.

- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут вновь заразиться, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем могут передать инфекцию ему(ей). Если пациент(ка) не уверен(а) в верности своих партнеров, посоветуйте ему(ей) практиковать менее опасные и безопасные виды секса.

- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, но полностью его исключить нельзя.

- Менее опасные виды секса включают:

- использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);

- оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- стимуляция полового партнера рукой.

- Безопасный секс включает:

- мастурбацию;

- использование индивидуальных сексуальных игрушек;

- длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

**Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

**Очень важно** поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).

#### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше, чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возмож-

ность обследования на ВИЧ-инфекцию?

**Ваши рекомендации пациенту(ке):**

Скажите пациенту(ке), что в будущем...

если он(а) или его(ее) партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что он(а) должен(а) придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что у посетителей обычно возникают вопросы. Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые она хотела бы обсудить.

## **9.10. АЛГОРИТМ консультирования по поводу воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ)**

### **Причина заболевания**

- Скажите пациентке, что у нее ВЗОМТ, и что это инфекция матки или маточных труб. Обычно причиной ВЗОМТ являются две инфекции, передаваемые половым путем: гонорея и (или) хламидиоз.

- Объясните женщине, что ВЗОМТ развилось после заражения гонореей и(или) хламидиозом, которые передаются половым путем. Она заразилась от полового партнера, с которым у нее был незащищенный секс и который, в свою очередь, был инфицирован кем-то еще, скорее всего, уже какое-то время назад. Таким образом, инфекция была передана ей.

### **Диагноз**

Объясните простыми словами, как ставится Диагноз.

### **Осложнения**

#### **Объясните, что...**

- ВЗОМТ может вызвать изменения в маточных трубах, что в будущем может препятствовать наступлению беременности и увеличить риск развития внематочной беременности, т.е. беременности, которая развивается в маточной трубе.

- Нарушения, которые вызывает ВЗОМТ, могут быть причиной хронических болей в области живота.

- При ВЗОМТ может потребоваться госпитализация.

### **Беременность**

- Спросите пациентку, не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности.

- Скажите ей, что это важно знать, т.к. некоторые препараты не безопасны для приема во время беременности.

### **Лечение**

- Расскажите женщине, как Вы собираетесь ее лечить.

- Объясните, что для эффективности лечения очень важно принимать лекарства так, как рекомендовано, и провести полный курс лечения, даже если симптомы исчезли до его окончания.

- Скажите женщине, что если у нее возникнут какие-либо проблемы во время приема лекарства, ей следует обратиться к Вам.

- Подчеркните, что женщине следует избегать сексуальных контактов до следующего визита к Вам.
- Скажите, что очень важно сказать половым партнерам о том, что она больна гонореей и(или) хламидиозом, и убедить их прийти к врачу для получения более подробной информации и лечения.
- Спросите, может ли пациентка сказать половым партнерам о своем заболевании. Если нет, обсудите альтернативные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования и лечения. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры для того, чтобы пригласить партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Профилактика :**

Скажите пациентке, что...

- Для предупреждения заражения других она должна избегать сексуальных контактов до окончания лечения, даже если симптомы исчезли раньше.
- Для предупреждения повторного заражения не следует вступать в сексуальные контакты до того, как все партнеры не пройдут курс лечения, даже если у них нет симптомов.
- Если нельзя избежать сексуальных контактов во время лечения самой пациентки или до того, как ее партнеры прошли курс лечения, практика менее опасных и безопасных видов секса уменьшит риск передачи инфекции от пациентки другим или ее повторного заражения.
- Даже если партнеры прошли курс лечения, они могут вновь заразиться, если вступают в сексуальные контакты с другими партнерами, а затем передать инфекцию ей. Если пациентка не уверена в верности своих партнеров, посоветуйте ей практиковать менее опасные виды секса.
- Риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией, приводящей к СПИДу, зависит от практикуемых видов секса. При генитально-анальном и генитально-вагинальном видах секса без использования презерватива риск передачи ИППП очень высок, а при оральном сексе без презерватива или другого механического барьерного средства риск заражения меньше, но полностью его исключить нельзя.
- Менее опасные виды секса включают:
  - использование презерватива при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности (половой член - влагалище или половой член - прямая кишка);
  - оральный секс менее опасен, если при контакте: «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;
  - стимуляция полового партнера рукой.
- **Безопасный секс включает:**
  - мастурбацию;
  - использование индивидуальных сексуальных игрушек;
  - длительные моногамные отношения со здоровым партнером.

**Разъясните** пациентке алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

**Очень важно** поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациентку о том, как она может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите ее попрактиковаться, рассказав Вам, что и как она скажет своему(им) партнеру(ам).

### **Обследование на ВИЧ-инфекцию**

- Объясните, что ВИЧ-инфекция также передается половым путем. Скажите, что у людей, заразившихся ИППП, риск заражения ВИЧ-инфекцией выше,

чем у лиц без ИППП.

- Спросите у Вашего пациента(ки), не хотел(а) бы он(а) обсудить возможность обследования на ВИЧ-инфекцию?

Ваши рекомендации пациентке:

Скажите пациентке, что в будущем...

если она или ее партнеры когда-нибудь обнаружат у себя один из перечисленных ниже симптомов, это может указывать на то, что они заразились ИППП, и им надо обратиться к врачу:

- необычные выделения из влагалища или пениса;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- зуд и раздражение половых органов;
- язвочки или уплотнения на половых органах, анальном отверстии или вокруг них;
- сыпь, включая сыпь на ладонях и стопах;
- у женщин: боль внизу живота.

**Подчеркните, что не следует заниматься самолечением!**

**Сообщите, что она должна придти на повторное исследование или/и лечение в согласованное с врачом время.**

**В заключение** скажите пациентке, что она получила сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у нее вопросы, которые она хотела бы обсудить.

## **9.11. АЛГОРИТМ консультирования по вопросу ВИЧ-инфекции**

### **А. Консультирование перед обследованием на ВИЧ-инфекцию**

#### **О чем важно помнить**

Правильный подход к консультированию по ВИЧ-инфекции заключается не в том, чтобы требовать от пациента рассказать о подробностях своего поведения, а в том, чтобы, не унижая и не осуждая его, объективно обсудить типы поведения, которые увеличивают риск заражения ВИЧ-инфекцией. При этом пациент не должен чувствовать неловкость, рассказывая о своем поведении, а также то, что его поведение может восприниматься обществом как неприемлемое.

**Помните:** Нет четких границ в определениях «не виновен» и «заслуживающий наказания» в разговоре о ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что некоторые люди принимают наркотики или практикуют опасные в отношении заражения виды секса, они делают это не с намерением заразиться ВИЧ-инфекцией. Информация о лечении и обсуждение ВИЧ-инфекции должны быть объективными и беспристрастными.

Заканчивая предтестовое консультирование оцените, насколько пациент(ка) понял(а) суть информации о ВИЧ-инфекции и СПИДе, дополните пробелы в знаниях и исправьте неверные представления.

#### **Вопросы и ответы**

- Вы когда-либо обследовались на ВИЧ-инфекцию?
- Не припомните ли Вы, когда это было и каковы были результаты?
- Почему Вы решили обследоваться в прошлый раз?
- Кто в прошлый раз решил, что Вам нужно обследоваться?

#### **Что такое ВИЧ?**

- ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Он вызывает ВИЧ-инфекцию, конечной стадией которой является СПИД.
- ВИЧ разрушает определенные клетки крови, борющиеся с инфекцией.
- Человек может быть заражен вирусом в течение многих лет и не подозревать об этом, пока не появятся первые симптомы заболевания, связанные с ВИЧ-инфекцией.
- Большинство людей ведут здоровый и продуктивный образ жизни после

заражения ВИЧ-инфекцией. Фактически, многие люди и не знают, что инфицированы, потому что чувствуют себя здоровыми.

### **Что такое СПИД?**

- СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита. Это последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает, когда иммунная система, ослабленная вирусом иммунодефицита человека, не может бороться с инфекциями так же эффективно, как ранее.

Поскольку препаратов для лечения СПИДа пока нет, обычно это заболевание приводит к смертельному исходу. Тем не менее, существуют лекарства, которые позволяют ВИЧ-инфицированным людям поддерживать их состояние здоровья в течение определенного времени.

### **Заражение**

- Заражение вирусом происходит через кровь и другие биологические жидкости инфицированных людей (сперму, вагинальные выделения и грудное молоко).

- Одним из наиболее распространенных путей передачи ВИЧ-инфекции является половой. Заражение происходит, в основном, при вагинальном или анальном сексе без использования презерватива. Хотя заражение может произойти и при оральном сексе, риск такого заражения гораздо ниже.

- Другой распространенный путь - использование общих игл, шприцев и других приспособлений для приема наркотиков через кровь.

- ВИЧ-инфицированная женщина может заразить своего ребенка во время родов или грудного вскармливания.

- При несоблюдении надлежащих мер профилактики возможно заражение лиц, чья работа связана с контактом с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированных людей. Это могут быть врачи, медсестры, лабораторные работники.

- ВИЧ не передается при обычных социальных контактах: совместном проживании или работе с ВИЧ-инфицированным человеком, при прикосновениях, принятии пищи, совместном пользовании посудой, при поцелуях и объятиях, рукопожатии, через туалетные сидения, укусы насекомых, слезы, слюну, пот, общую одежду.

### **Почему нужно обследоваться?**

- Лучше узнать о том, что Вы инфицированы как можно раньше, т.к. есть препараты, которые позволяют продлить период полноценной жизни и предотвращают заболевания, обусловленные наличием ВИЧ-инфекции.

- Вы можете предотвратить заражение других, если знаете, что инфицированы сами.

- Помните, что ВИЧ-инфицированная женщина может заразить своего ребенка во время беременности, родов или последующего грудного вскармливания. Приблизительно каждая третья-пятая мать, не прошедшая курс лечения, передаст своим новорожденным детям ВИЧ-инфекцию. Зная, что Вы инфицированы, Вы сможете сделать осознанный выбор в отношении планирования семьи и беременности. В настоящее время лечение беременных матерей позволяет снизить риск передачи инфекции от матери ребенку.

- Так как ВИЧ-инфекция может передаваться с грудным молоком, ВИЧ-инфицированным

матерям не рекомендуется кормить грудью своих младенцев, если имеются другие безопасные источники детского питания.

### **Анализ на ВИЧ-инфекцию**

- Наличие ВИЧ-инфекции определяется по анализу крови.
- Обнаружить антитела к ВИЧ в крови можно при помощи иммуноферментного анализа. Антитела - это клетки, которые наш организм вырабатывает в



ответ на инфекцию.

- Если первый анализ крови положительный, то проводится повторный анализ с той же или другой пробой крови. Если второй анализ крови положительный, то для подтверждения инфицированности проводится анализ, определяющий наличие белковых частиц вируса в крови.

#### **Что означают результаты анализа на ВИЧ-инфекцию?**

- Если результат первого анализа крови отрицательный (в крови нет антител к вирусу), то человек, вероятно, не инфицирован. Тем не менее, из-за того, что анализ определяет антитела к вирусу, а не сам вирус, не исключено, что от момента заражения до момента, когда количество антител достаточно, чтобы быть обнаруженными, анализ на ВИЧ-инфекцию будет отрицательным, даже если человек заражен. Поэтому если нельзя исключить, что Вы могли заразиться, следует обследоваться через 3 месяца после последнего возможного заражения.

- Если результат всех описанных выше анализов положительный, у человека - ВИЧ-инфекция.

- Иногда результат анализа не ясен. Это может означать, что Вы заразились недавно, и процесс выработки антител продолжается. В таком случае Вам следует сдать кровь на анализ повторно через 3 месяца после последнего раза, когда могло произойти заражение.

#### **Что увеличивает риск заражения ВИЧ-инфекцией?**

- Незащищенный вагинальный или анальный секс, особенно если у Вас больше одного партнера. Заражение может произойти и при оральном сексе, но риск гораздо ниже.

- Инъекционный способ приема наркотиков: использование общих инструментов и приспособлений для приготовления и употребления наркотиков и совместное употребление самих наркотиков.

- ИППП в настоящее время или в прошлом.
- Переливание крови, продуктов крови или пересадка донорских органов.
- Контакт на рабочем месте с кровью или биологическими жидкостями организма.
- Рождение от ВИЧ-инфицированной женщины или грудное вскармливание ею.

#### **Существуют пути снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией**

##### **ЗАПОМНИТЕ!**

**Нельзя определить по внешнему виду, заражен или нет человек ВИЧ-инфекцией.**

**Вы можете уменьшить риск заражения ВИЧ-инфекцией, избегая опасных видов поведения:**

##### **Сексуальное поведение**

Безопасными являются:

- Воздержание от половых контактов;
- Мастурбация;
- Использование индивидуальных сексуальных игрушек;
- Длительные моногамные отношения с неинфицированным человеком.

Если не известно заражен или нет Ваш половой партнер, менее опасные виды секса снижают риск заражения и передачи ВИЧ-инфекции так же, как и других ИППП.

Менее опасные виды секса:

- Использование латексных или полиуретановых презервативов при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности («половой член – влагалище» или «половой член - прямая кишка»);
- Оральный секс менее опасен, особенно если при контакте «половой член — рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагали-



ще» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;

- Стимуляция полового партнера рукой.

**Разъясните** пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

**Очень важно**, чтобы пациент(ка) поговорил(а) с половым(и) партнером(ами) о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).



### **Инъекционное введение наркотических средств**

Внутривенное, внутримышечное или подкожное введение - высоко рискованно в плане заражения ВИЧ-инфекцией. Состав вводимого средства не имеет значения.

- Чтобы снизить риск заражения при употреблении наркотиков, ...
- Нужно пользоваться индивидуальными инструментами для приготовления и употребления наркотиков (иглы, шприцы и приспособления для смешивания и очистки наркотиков).
- Нельзя одалживать чужие и использовать одни и те же инструменты с другими людьми.
- Расскажите пациенту(ке) о программах по замене шприцев, если они существуют в вашем регионе.

### **Ваши рекомендации пациенту(ке)**

- Тщательно очищайте Ваши инструменты для приготовления и употребления наркотических средств или следите за тем, чтобы это делали другие.

- Осознайте и запомните, что под воздействием наркотических средств или алкоголя Вы неадекватно оцениваете риск заражения, связанный с сексом или употреблением наркотиков.

- Не задумывались ли Вы над тем, чтобы прекратить употребление наркотиков? Если Вы хотите, я могу направить Вас к специалисту, который поможет Вам избавиться от пристрастия к наркотикам.

### **Риск, связанный с профессией**

• Если на рабочем месте Вы подвергаетесь риску заражения из-за контакта с кровью или другими биологическими жидкостями, то строго соблюдайте стандартные меры предосторожности, которые уменьшают риск заражения при контакте с инфицированным материалом.

#### **• Стандартные меры предосторожности включают:**

- мытье рук;
- ношение перчаток и защитных очков;
- правильную обработку инструментов и других предметов;
- предотвращение порезов острыми предметами;
- предотвращение попадания инфицированных материалов в окружающую среду и правильное обращение с использованным материалом;
- безопасное изъятие, доставку и обработку использованных материалов.

### **Обсудите возможные результаты обследования пациента(ки) и скажите...**

• Люди по-разному реагируют, когда слышат результаты своих анализов. Как бы Вы отреагировали, если бы результат оказался положительным?

- Смогли бы Вы рассказать кому-то (друзьям, партнеру, членам семьи) о результатах обследования?
- Как бы Вы отреагировали, если бы результат оказался отрицательным?
- Если учесть то, что мы обсудили, и если Вы считаете, что могли заразиться ВИЧ-инфекцией в течение последних трех месяцев, важно подумать о повторном обследовании. Как Вам кажется, Вам нужно сделать повторный анализ крови через какое-то время?

#### **Конфиденциальность**

Скажите пациенту(ке), где будут зафиксированы результаты анализа, и кто может иметь доступ к ним.

#### **Повторный визит**

- Предоставьте пациенту(ке) направления к другим специалистам, если необходимо.

- Если пациент(ка) согласится на анализ крови, договоритесь о дне и времени визита для ознакомления с результатами анализа и послетестового консультирования. Не назначайте повторный визит непосредственно перед выходными днями или праздником. Если результат анализа окажется положительным, пациент(ка) должен(жна) иметь возможность получить консультирование у психолога или обратиться в кризисный центр (если он есть), что может стать невозможным в выходной или праздничный день.

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

Дайте пациенту(ке) имеющуюся у Вас литературу по ВИЧ-инфекции и СПИДу.

### **9.12. АЛГОРИТМ консультирования по вопросу ВИЧ-инфекции**

#### **Б. Послетестовое консультирование: отрицательный результат**

##### **Результаты анализа**

- Сообщите результаты анализа немедленно: **Ваш анализ на ВИЧ-инфекцию -отрицателен. Это означает, что в момент, когда у Вас была взята кровь на анализ, у Вас не было антител к ВИЧ.**

Лишние разговоры неуместны, когда Ваш пациент(ка) здесь только по одной причине.

- После сообщения результата дайте пациенту(ке) время осмыслить информацию.

##### **Скажите пациенту(ке):**

- Поскольку анализ определяет антитела к вирусу, а не сам вирус, возможно, что анализ на ВИЧ-инфекцию отрицательный, но Вы инфицированы. Это возможно, если Вы сдавали кровь на анализ в промежуток времени между заражением и моментом, когда количество антител стало достаточным для их определения.

- Если Вы не исключаете, что подвергали себя риску заразиться ВИЧ-инфекцией в последние 3 месяца, возможно, что Вы действительно заразились, но Ваш организм еще не выработал антитела к ВИЧ. Чтобы определить это достоверно, Вам следует повторно сдать кровь на анализ.

- Несмотря на то, что результат Вашего анализа сейчас отрицательный. Вы, тем не менее, можете заразиться ВИЧ-инфекцией в будущем, т.к. иммунитета к ВИЧ-инфекции не существует.

##### **Повторите еще раз, как передается ВИЧ-инфекция:**

- Заражение вирусом происходит через кровь и другие биологические жидкости инфицированных людей (сперму, вагинальные выделения и грудное молоко).

- Одним из наиболее распространенных путей передачи ВИЧ-инфекции является половой. Заражение происходит, в основном, при вагинальном или

анальном сексе без использования презерватива. Хотя заражение может произойти и при оральном сексе, риск такого заражения гораздо ниже.

- Другой распространенный путь - использование общих игл, шприцев и других приспособлений для приема наркотиков через кровь.

- ВИЧ-инфицированная женщина может заразить своего ребенка во время родов или грудного вскармливания.

- При несоблюдении надлежащих мер профилактики возможно заражение лиц, чья работа связана с контактом с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированных людей. Это могут быть врачи, медсестры, лабораторные работники.

- ВИЧ не передается при обычных социальных контактах: совместном проживании или работе с ВИЧ-инфицированным человеком, при прикосновениях, принятии пищи, совместном пользовании посудой, при поцелуях и объятиях, рукопожатии, через туалетные сидения, укусы насекомых, слезы, слюну, пот, общую одежду.

### **Существуют пути снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией**

Запомните:

**Нельзя определить по внешнему виду заражен или нет человек ВИЧ-инфекцией.**

Скажите пациенту(ке), что он(а) может уменьшить риск заражения ВИЧ-инфекцией, избегая опасных видов сексуального поведения.

#### **Сексуальное поведение**

Безопасными являются:

- Воздержание от половых контактов;
- Мастурбация;
- Использование индивидуальных сексуальных игрушек;
- Длительные моногамные отношения с неинфицированным человеком.

Если не известно заражен или нет Ваш половой партнер, менее опасные виды секса снижают риск заражения и передачи ВИЧ-инфекции так же, как и других ИППП.

Менее опасные виды секса:

- Использование латексных или полиуретановых презервативов при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности («половой член – влагалище» или «половой член - прямая кишка»);
- Оральный секс менее опасен, особенно если при контакте «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот - анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;
- Стимуляция полового партнера рукой.

Разъясните пациенту(ке) алгоритмы применения механических и антисептических средств для индивидуальной профилактики ИППП.

Очень важно, чтобы пациент(ка) поговорил(а) с половым(и) партнером(ами) о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) о том, как он(а) может затронуть эту тему при разговоре с ними. Попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам, что и как он(а) скажет своему(им) партнеру(ам).

#### **Инъекционное введение наркотических средств**

Внутривенное, внутримышечное или подкожное введение - высоко рискованно в плане заражения ВИЧ-инфекцией. Состав вводимого средства не имеет значения.

- Чтобы снизить риск заражения при употреблении наркотиков, ...
- Нужно пользоваться индивидуальными инструментами для приготовления и употребления наркотиков (иглы, шприцы и приспособления для смешивания и очистки наркотиков).

- Нельзя одалживать чужие и использовать одни и те же инструменты с другими людьми.

- Расскажите пациенту(ке) о программах по замене шприцев, если они существуют в вашем регионе.

#### **Ваши рекомендации пациенту(ке)**

- Тщательно очищайте Ваши инструменты для приготовления и употребления наркотических средств или следите за тем, чтобы это делали другие.

- Осознайте и запомните, что под воздействием наркотических средств или алкоголя Вы неадекватно оцениваете риск заражения, связанный с сексом или употреблением наркотиков.

- Не задумывались ли Вы над тем, чтобы прекратить употребление наркотиков? Если Вы хотите, я могу направить Вас к специалисту, который поможет Вам избавиться от пристрастия к наркотикам.

#### **Риск, связанный с профессией**

- Если на рабочем месте Вы подвергаетесь риску заражения из-за контакта с кровью или другими биологическими жидкостями, то строго соблюдайте стандартные меры предосторожности, которые уменьшают риск заражения при контакте с инфицированным материалом.

- Стандартные меры предосторожности включают:

- мытье рук;

- ношение перчаток и защитных очков;

- правильную обработку инструментов и других предметов;

- предотвращение порезов острыми предметами;

- предотвращение попадания инфицированных материалов в окружающую среду и правильное обращение с использованным материалом;

- безопасное изъятие, доставку и обработку использованных материалов.

#### **Повторный визит**

- Скажите пациенту(ке), что если учесть то, что мы обсудили, и если он(она) считает, что мог(ла) заразиться ВИЧ-инфекцией в течение последних 3-х месяцев, то важно подумать о повторном обследовании. Как Вам кажется, Вам нужно сделать повторный анализ крови через 3 месяца?

- Направьте пациента(ку) к другим специалистам, если необходимо

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы.

Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить.

Дайте пациенту(ке) имеющуюся у Вас литературу по ВИЧ-инфекции и СПИДу.

### **9.13. АЛГОРИТМ консультирования по вопросу ВИЧ-инфекции**

#### **Послетестовое консультирование: положительный результат**

##### **Результаты анализа:**

- Сообщите результаты анализа немедленно. Лишние разговоры неуместны, когда Ваш пациент(ка) находится здесь только по одной причине. Скажите что анализ на ВИЧ-инфекцию положителен. Это значит, что в крови обнаружены как антитела к ВИЧ, так и белковые частицы вируса, подтверждающие его наличие в крови.

- Сообщив результат, дайте пациенту(ке) время осознать полученную информацию. Ему(ей) потребуется какое-то время для этого, а от Вас потребуется сочувствие и понимание. Пациент(ка) может не услышать многое из того, что Вы ему(ей) будете говорить, из-за шока от полученной информации о положительном результате анализа крови.

- Важно сообщить пациенту(ке), что ВИЧ-инфицированные люди продолжают жить полноценной жизнью, что быть ВИЧ-инфицированным не означа-

ет быть больным СПИДом, и что симптомы и заболевания, связанные с ВИЧ-инфекцией, могут не появляться в течение многих лет после заражения.

### **Скажите пациенту(ке), что...**

- Большинство людей живут здоровой и полноценной жизнью после заражения ВИЧ-инфекцией. Многие люди и не подозревают, что инфицированы, т.к. чувствуют себя здоровыми.

- Хотя в настоящее время нельзя вылечить от ВИЧ-инфекции, есть лекарственные препараты, которые поддерживают состояние здоровья и предотвращают развитие заболеваний, обусловленных ВИЧ-инфекцией.

- Поскольку Вы уже знаете, что заражены ВИЧ-инфекцией, важно, чтобы Вы следовали следующим рекомендациям для поддержания состояния Вашего здоровья более длительное время:

- Важно, чтобы Вы постоянно наблюдались у врача, специализирующегося по ВИЧ-инфекции. Я дам Вам направление к нему;

- постарайтесь полноценно питаться и достаточно спать;

- если Вы курите, постарайтесь снизить количество выкуриваемых сигарет или бросить курить совсем;

- если Вы употребляете наркотики, подумайте о том, чтобы прекратить их прием.

- Очень важно практиковать менее опасные виды секса и выполнять определенные требования при применении наркотиков. Это не только обезопасит Ваших половых партнеров и партнеров по совместному употреблению наркотиков от заражения от Вас, но и защитит Вас от заражения другими инфекциями от них, что могло бы ухудшить состояние Вашего здоровья.

### **Расскажите пациенту(ке), кому он(а) должен(жна) сообщить о том, что ВИЧ-инфицирован(а):**

- Необходимо сообщить, что Вы ВИЧ-инфицированы тем, кто оказывает Вам медицинскую помощь;

- несмотря на то, что может быть нелегко сообщить Вашим бывшим, настоящим или будущим половым партнерам или партнерам по совместному употреблению наркотиков результаты Вашего обследования, это чрезвычайно важно сделать. Им важно знать об этом, чтобы своевременно обследоваться, и если они также ВИЧ-инфицированы, получить необходимую помощь и рекомендации. Кроме того, легче практиковать менее опасные виды секса, если Ваши партнеры понимают необходимость этого.

Спросите, может ли пациент(ка) сказать половым партнерам или партнерам по совместному употреблению наркотиков о том, что он(а) инфицирован(а). Если не может, обсудите альтернативные варианты привлечения их в лечебное учреждение для обследования. Например, предложите свою помощь или помощь медицинской сестры в приглашении партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность.

### **Обсудите еще раз менее опасные виды секса и употребление наркотиков:**

#### **Безопасными являются:**

- Воздержание от половых контактов;
- Мастурбация;
- Использование индивидуальных сексуальных игрушек;

#### **Менее опасные виды секса:**

- Использование латексных или полиуретановых презервативов при каждом половом контакте и на протяжении всей его длительности («половой член – влагалище» или «половой член – прямая кишка»);

- Оральный секс менее опасен, особенно если при контакте «половой член – рот», на половой член надет презерватив, а при контакте «рот – влагалище» или «рот – анальное отверстие», вход во влагалище или анальное отверстие прикрыты разрезанным презервативом или пищевой пленкой;



- Стимуляция полового партнера рукой.

- Очень важно поговорить с половыми партнерами о менее опасных видах секса. Спросите пациента(ку) обсуждал(а) ли он(а) менее опасные виды секса со своими партнерами и практиковал(а) ли их. Если да, то что именно? Если нет, попросите его(ее) попрактиковаться, рассказав Вам что и как он(а) скажет своим партнерам.

### **Инъекционное введение наркотических средств включает:**

Внутривенное, внутримышечное или подкожное введение вне зависимости от того, что представляет из себя вводимое средство. Скажите пациенту(ке), что для его(ее) здоровья будет лучше, если он(а) попытается прекратить употребление наркотиков, за исключением тех, которые назначает врач. Если он(а) продолжает употреблять наркотики, то предложите следовать менее опасным способам введения наркотиков.

- Менее опасные способы употребления наркотиков:

- Использование индивидуальных инструментов для приготовления и употребления наркотиков (иглы, шприцы и приспособления для смешивания и очистки наркотиков). Расскажите о программах по замене игл, если они существуют в вашем регионе;

- необходимо тщательно очищать инструменты для приготовления и употребления наркотических средств или следить за тем, как это делают другие;

- подчеркните, что под воздействием наркотических средств или алкоголя люди неадекватно оценивают риск передачи инфекции, связанный с сексом или употреблением наркотиков;

- спросите, не задумывался(лась) ли пациент(ка) над тем, чтобы прекратить употребление наркотиков? Предложите ему(ей) направление к специалисту, который поможет избавиться от пристрастия к наркотикам.

- Поскольку ВИЧ передается с кровью и другими биологическими жидкостями организма, подчеркните, что пациент(ка) не может быть донором крови или органов.

### **Напомните пациенту(ке), что...**

ВИЧ не передается при обычных социальных контактах: совместном проживании или работе с ВИЧ-инфицированным человеком, при прикосновениях, принятии пищи, совместном пользовании посудой, при поцелуях и объятиях, рукопожатии, через туалетные сидения, укусы насекомых, слезы, слюну, пот, общую одежду.

### **Беременность:**

- Спросите пациентку не беременна ли она или не исключает ли она такой возможности.

- Напомните ей, что ВИЧ-инфицированная женщина может заразить своего ребенка во время беременности, родов или грудного вскармливания. Приблизительно, каждая третья-пятая беременная женщина заражает своего ребенка ВИЧ-инфекцией, если она не прошла необходимого курса лечения.

- В настоящее время лечение беременных женщин позволяет снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

### **Для небеременных женщин**

Спросите пациентку нуждается ли она в информации об эффективных методах контрацепции для предупреждения беременности? Если да, направьте ее в центр планирования семьи или женскую консультацию.

### **Для беременных женщин**

- Скажите женщине, что у нее есть право как сохранить беременность, так и прервать ее. Поинтересуйтесь, не возражает ли она обсудить эту тему?

- Скажите, что если малыш окажется инфицирован, ему(ей) потребуются интенсивная медицинская помощь.



• Поскольку ВИЧ передается с грудным молоком, ВИЧ-инфицированным матерям рекомендуется отказаться от кормления грудью при наличии других безопасных источников детского питания.

(ВИЧ-инфицированные беременные женщины должны получить исчерпывающее консультирование по вопросам возможностей лечения, доступных во время беременности и о грудном вскармливании).

**Конфиденциальность и следующие этапы**

- Скажите пациенту(ке), где будут зафиксированы результаты его(ее) обследования на ВИЧ-инфекцию, и кто будет иметь к ним доступ.

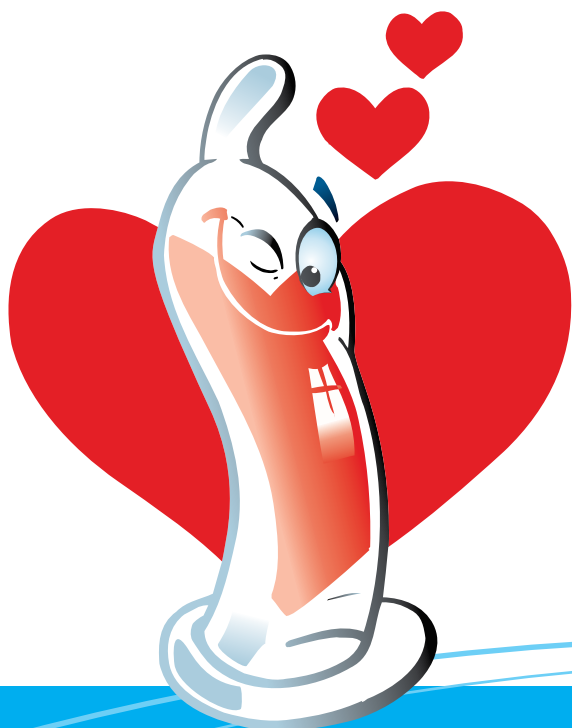
- Спросите, не задумывался(лась) ли он(а) о том, с кем сможет поговорить о сложившейся ситуации?

- Спросите, что Ваш(а) пациент(ка) будет делать, когда уйдет от Вас?

- Предложите прийти еще раз, если у него(нее) возникнет такое желание.

- Посоветуйте обратиться или дайте необходимые направления в другие учреждения, где помогут решить проблемы Вашего(ей) пациента(ки), связанные с ВИЧ-инфекцией, беременностью, наркоманией, психологическим консультированием, и.т.д.

**В заключение** скажите пациенту(ке), что он(а) получил(а) сегодня много информации, и что обычно у посетителей возникают вопросы. Спросите, есть ли у него(нее) вопросы, которые он(а) хотел(а) бы обсудить. Дайте пациенту(ке) имеющуюся у Вас литературу по ВИЧ-инфекции и СПИДу.



# АЛГОРИТМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП С ПОМОЩЬЮ БАРЬЕРНЫХ И АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Доверенному врачу приходится оказывать не только лечебно-диагностическую помощь, но и проводить профилактику, разъяснять технику ее выполнения. Пациентам следует рассказать о всех методах индивидуальной профилактики и особенностях применения каждого из них. Большинство женщин, вовлеченных в секс-бизнес, а также мужчин, имеющих секс с мужчинами, время от времени по тем либо другим причинам соглашаются на незащищенный секс. Поэтому главной задачей в работе доверенного врача является формирование внутренней установки пациента на постоянное применение в ежедневной практике мер личной профилактики. Это весьма непросто, но именно это должно быть приоритетной задачей доверенного врача.

Доверенный специалист должен всесторонне обосновывать и особо настаивать на плановом использовании барьерных методов профилактики. С другой стороны рассказывать о ситуациях, когда понадобится использование методов экстренной профилактики, что может существенно снизить риск заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией. Это особенно важно для тех, кто оказывает платные сексуальные услуги.

Индивидуальные меры защиты от ИППП могут использоваться как во время полового акта, так и после него.

## БАРЬЕРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Защита от ИППП во время полового акта чаще всего основана на использовании барьерных (механических) средств (мужской и женский презервативы). Наиболее используемым средством является мужской презерватив.

Подавляющее большинство презервативов производится из натурального латекса, который представляет собой сок пальмы гевеи (каучуковое дерево). Очень незначительная часть презервативов производится из натуральной кожи и естественных мембран (кишки и др.). Они оказываются слишком дорогими и чаще всего не обеспечивают необходимый уровень защиты от ИППП. Производимые небольшими партиями мужские презервативы из полимерных материалов пока широко не используются, так как не имеют удовлетворительных показателей по растяжимости и прочности. Женские презервативы, изготовленные из полиуретана, также не нашли широкого распространения, несмотря на то, что имеют положительную оценку со стороны потребительниц. Вероятно, это связано с более высокой стоимостью в сравнении с мужскими презервативами.



Желательно использование презервативов, изготовленных из латекса и фабрично обработанных смазочными средствами (лубрикантами). Латексный презерватив более, чем на 92% состоит из натурального латекса. Оставшаяся часть составляют различные добавки – вулканизаторы, стабилизаторы и др., которые и придают латексу такие важные качества, как прочность и тягучесть. Презервативы, изготовленные из латекса, обладают наибольшей эффективностью и способны преграждать путь наиболее мелким микроорганизмам (например, вирусы), что не всегда достигается при использовании низкокачественных презервативов, сделанных из других материалов.

Согласно стандарту Евросоюза, длина презерватива должна быть не менее 170 мм, номинальная ширина (это половина длины его окружности) должна находиться в пределах 44-56 мм, относительное удлинение на разрыв – минимум 650%, объем на разрыв – минимум 18 л, прочность – минимум 18 МПа. Обычно презервативы, продаваемые в Европе, имеют длину 172 мм и ширину 52 мм. Согласно стандарту, действующему в некоторых странах постсоветского пространства (ГОСТ 4645-81 с исправлениями от 15.04.94 г.), длина презерватива должна быть более 178 мм, ширина – 54 мм, относительное удлинение на разрыв – минимум 700%, прочность – минимум 20 МПа, другие характеристики не оговорены.

Кроме стандарта Евросоюза (CEN) наиболее часто используются стандарты – ISO (Международная организация стандартов), WHO (Всемирная Организация Здравоохранения), DIN (национальный стандарт Германии), NF (национальный стандарт Франции), BS (национальный стандарт Великобритании). Если буквы национального стандарта сочетаются с буквами EN, например, DIN, то это означает, что изделие соответствует стандарту, согласованному с общеевропейским.

Большинство презервативов производится в ареале произрастания гевеи – страны Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Корея, Вьетнам, Китай, Индия) и основные европейские производители располагают свои заводы именно в этом регионе.

Сроки хранения презервативов в разных национальных стандартах колеблются от 2 до 5 лет. Но большинство фирм-изготовителей гарантируют пригодность своих изделий в течение 5 лет при отсутствии воздействия высоких температур, солнечного света и веществ, разрушающих латекс (например, масло). Продукция предприятий, производящих презервативы, очень разнообразна. Можно выделить следующие характеристики презервативов.

### 1. Качество ткани презерватива

- Гладкие. Обычные презервативы без какой-либо специальной структуры.
- Контурированные (Contoured), плотноприлегающие (form fitting).

Имеют анатомическую форму.



- Текстурированные. Презервативы с различной специальной текстурой (выделкой) – с ребрышками, пупырышками или их сочетанием.



71

## 2. Наличие и качество смазки (смазки)

- Без смазки.
- Обычное количество смазки – используется силиконовое масло или монопропиленгликоль.



- Обильное количество смазки – используется удвоенное количество смазки.
- Ароматизированный смазка – в смазку добавлен ароматизатор.



- Спермицидный смазка – такие презервативы называют презервативами с «двойной защитой» (double protection condom). В смазку добавлено вещество, чаще всего монооксинол-9, понижающее подвижность или разрушающее сперматозоиды. Такой смазка снижает риск незапланированной беременности, если презерватив порвался.

- Смазка, продлевающий половой акт (Long love). В смазку входит анестетик, который отдалает семяизвержение, при этом, не ухудшая качество эрекции.

### 3. Другие характеристики

- Увеличенный размер – ширина увеличена до 54-56 мм, а длина составляет до 190 мм и более.



- Особо прочные. Отличаются увеличенной толщиной латекса. Их можно рекомендовать при травматичных видах секса - анальный секс.



- Сверхтонкие (Ultrathin). Минимизируют ощущения использования презерватива. Не рекомендуются при травматичных видах секса – обеспечивающий высокую чувствительность презерватив с ароматизатором).
- Светящиеся. В смазку или в ткань презерватива входит фосфоресцирующее вещество, светящееся в темноте.
- Самонадевающиеся (One Touch). Ускоряют процесс надевания презерватива. В свернутое кольцо презерватива встроена эластичная лента. Для надевания презерватив прикладывают к головке полового члена и тянут за ленту.



### 4. Насадки или «презервативы-игрушки»

Имеют разнообразную причудливую форму, например, «дед мороз», «снегурочка», «с рожками» и др.. Отличаются более толстой тканью и тем, что являются не средством контрацепции и защиты от ИППП, а сувениром.



Помогают разнообразить секс, придать ему характер приятной игры, но не защищают в должной степени от ВИЧ/ИППП.



Долгое время идут поиски научных доказательств эффективности презервативов. Американскими учеными составлен обзор опубликованных в мире научных исследований по данному вопросу. Они свидетельствуют, что наиболее весомым использованием мужских презервативов является для профилактики ВИЧ-инфекции. Среди мужчин и женщин, которые всегда практикуют пользование презервативом, риск заражения ВИЧ-инфекцией значительно сокращается. Так, по данным Davis K.R., Weller S.C., 1999, при постоянном использовании презервативов в сравнении с отказом от использования, суммарный показатель новых случаев СПИДа составил всего 0,9 на 100 человеко-лет против 6,7 случая среди тех, кто не пользовался данным средством защиты.

В целом по данным Дэвиса и Веллера, презервативы снижают риск заражения ВИЧ-инфекцией на 85%. Эти данные являются надежным доказательством эффективности презервативов в снижении сексуальной передачи ВИЧ-инфекции.

Главной причиной того, что презервативы не всегда могут предотвратить ИППП/ВИЧ – неправильное или непостоянное их использование. Смазочные вещества на масляной основе, которые иногда используются при отсутствии специально предназначенных для этих целей лубрикантов,



разрушают латекс, что приводит к разрыву презерватива. Латекс также может быть поврежден высокой температурой или солнечными лучами. Качество презервативов снижается ввиду длительного срока хранения. Часто возникают механические разрывы в момент вскрытия упаковки, если используются зубы или ногти (около 2 случаев повреждений на 100 вскрытий). Неэффективность презервативов может быть связана также с соскальзыванием с полового члена во время вагинального полового акта (1-5%) и с частичным сползанием при анальных половых контактах (3-13% случаев использования).



**При использовании презерватива следует руководствоваться следующими правилами.**

1. Обсудить с сексуальным партнером возможность использования презерватива, чтобы не было «сюрпризов», обид и объяснений в последний момент до начала полового акта.

2. Следует избегать контакта между пенисом, влагалищем или анусом до того, как будет надет презерватив. Биологические жидкости, выделяющиеся из половых органов при сексуальном возбуждении, могут содержать возбудителей ИППП и ВИЧ-инфекции.

3. Нельзя разворачивать презерватив заранее.

4. Надевать презерватив нужно лишь при полной эрекции и до начала полового акта.

5. Открывая упаковку презерватива, нужно остерегаться его прокола острыми кончиками ногтей, зубами или ювелирными украшениями.

6. Вначале необходимо сжать верхушку презерватива (спермоприемник) большим и указательным пальцами, чтобы в ней не осталось воздуха. Это обеспечивает место для спермы и не позволяет презервативу порваться во время эякуляции.

7. Перед раскатыванием презерватива нужно убедиться, что его ободок находится снаружи.

8. Затем приложить свернутый презерватив к головке полового члена и развернуть 2-3 пальцами другой руки по всей длине полового члена.

9. Если презерватив не снабжен смазкой, его необходимо смазать специальным лубрикантом, либо контрацептивным (спермицидным) кремом или глицерином. Можно использовать также любой крем только на водной основе. Масло, вазелин, жирные кремы очень быстро разрушают латекс, приводят к его разрыву или соскальзыванию!

10. При скатывании презерватива нужно немедленно вернуть его на прежнее место.

11. Если презерватив полностью соскользнул или порвался, то необходимо сразу извлечь половой член и надеть новый презерватив.

12. После эякуляции извлекать половой член нужно сразу, одновременно придерживая на нем презерватив.

13. Презерватив можно использовать только один раз.

14. Нельзя надевать два презерватива один на другой, при трении они могут порваться, либо один из них соскользнет и останется во влагалище (прямой кишке).

15. После использования презерватив нужно завязать на узелок и, «спрятать» в комок бумаги, выбросить в мусорное ведро.

16. Презерватив должен использоваться при всех видах половых контактов (вагинальный, оральный, анальный).

17. Необходимо взять другой презерватив если:

- упаковка презерватива повреждена;
- по дате выпуска видно, что презерватив был изготовлен более пяти лет тому назад;
- презерватив имеет неравномерную окраску или цвет его изменился;
- стал ломким, сухим или клейким на ощупь.

18. Желательно покупать презервативы, изготовленные хорошо известными фирмами.

19. Хранить презерватив нужно в прохладном и сухом месте. Нельзя хранить презерватив под подушкой или в кармане рубашки на груди (в постоянном тепле). Это ведет к снижению эластических качеств латекса и разрыву во время использования.

К числу женских средств для защиты во время полового акта относится

также средство «Фарматекс» (вагинальные таблетки, свечи, крем). Оно содержит микробицид хлористый бензалкониум и обладает двойным действием – контрацептивным и антисептическим. Вагинальный крем, свеча или таблетка вводится женщиной во влагалище незадолго до полового акта. Применение после полового акта неэффективно. Фарматекс обладает умеренным противовирусным и бактерицидным действием, но не защищает от заражения влагалищными трихомонадами. Не рекомендуется использовать одновременно с презервативом.

### ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Экстренная (посткоитальная) профилактика ИППП/ВИЧ-инфекции – это мероприятия, предпринимаемые в случае аварийной ситуации и/или незащищенного полового контакта.

Аварийная ситуация – это разрыв презерватива во время любого полового акта. Разрыв может произойти по разным причинам. Самая частая – низкое качество. Поэтому желательно использовать презервативы известных фирм-производителей. Другой причиной может быть неправильное использование презерватива.

Разрыв презерватива или незащищенный половой акт представляют высокую степень риска заражения ИППП/ВИЧ. В таких случаях необходимо осуществить действия по снижению риска заражения, то есть применить антисептики.



Необходимо помнить, что нельзя использовать антисептики систематически. Это может привести к различным осложнениям (аллергические реакции, дисбактериоз).

Выбор антисептика осуществляется индивидуально, с учетом сведений о лекарственной непереносимости. Его лучше подобрать заранее во время консультирования пациента.

#### Преимущества антисептиков:

- возможность снизить риск заражения уже после полового акта;
- возможность обрабатывать не только половые органы, но и местные повреждения кожи;
- антисептики продаются без рецепта; их удобно носить с собой.

#### Недостатки:

- антисептики не защищают от беременности;
- женщинам обработку половых органов лучше проводить в положении лежа, что не всегда возможно;
- применение раствора может вызвать чувство дискомфорта;
- иногда (очень редко) бывают аллергические реакции в виде зуда кожи

или слизистой после обработки;

- после использования нужно убедиться, что флакон плотно закрыт, чтобы раствор не вылился;

- антисептики не эффективны, если прошло более 2 часов после полового акта.

Экстренная профилактика гонореи лицом, подвергшимся опасности заражения инфекцией, передаваемой половым путем, в результате случайной половой связи, может осуществляться как самостоятельно, так и в пунктах индивидуальной профилактики венерических болезней.

Аутопрофилактика производится с помощью индивидуальных портативных устройств (флаконов), содержащих профилактические средства, в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. К числу таких средств относятся 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата, 0,01% раствор мирамистина или другие, зарегистрированные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Круглосуточная профилактика ИППП как мужчинам, так и женщинам проводится в кожно-венерологических диспансерах медицинским персоналом пунктов индивидуальной профилактики. Мужчинам ее проводят с использованием 2-3 % водного раствора протаргола и вышеупомянутых 0,05% раствора хлоргексидина биглюконата, 0,01% раствора мирамистина, либо других антисептиков, а для женщин используют 1-2 % раствор азотнокислого серебра, 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата, 0,01% раствор мирамистина.

#### **Методика экстренной профилактики у мужчин:**

- 1) выпустить мочу и вымыть руки водой с мылом;
- 2) тщательно обмыть теплой водой с мылом половой член, мошонку, лобок, бедра, промежность;
- 3) после обсушивания все эти места протереть влажным тампоном, пропитанным 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата (или раствором мирамистина 0,01%);
- 4) ввести в уретру 2-5 мл (1 нажатие на флакон) 0,05 % раствора хлоргексидина биглюконата (или раствор мирамистина 0,01%) и задержать его в уретре не менее 2-3 минут, зажимая наружное отверстие мочеиспускательного канала; после этой процедуры рекомендуется воздержаться от мочеиспускания не менее 2-3 часов;
- 5) половые органы защитить от загрязненного белья чистыми марлевой салфеткой или носовым платком с рекомендацией сменить белье по возвращению домой;

#### **Методика экстренной профилактики у женщин:**

- 1) сразу после полового акта с помощью насадки оросить мочеиспускательный канал 2-3 мл (1 нажатие на флакон) антисептика;
- 2) опорожнить мочевой пузырь и вымыть руки водой с мылом;
- 3) обмыть теплой водой с мылом гениталии и аногенитальную область;
- 4) после обсушивания обтереть половые органы, промежность, лобок, бедра ватным тампоном, пропитанным 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата или 0,01% раствором мирамистина;
- 5) произвести спринцевание влагалища 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата или 0,01% раствором мирамистина (желательно в лежачем положении): ввести насадку во влагалище, нажать на флакон 2-3 раза, задержать содержимое на 2-3 минуты; после процедуры не рекомендуется мочиться в течение 2-х часов.

6) половые органы защитить от загрязненного белья чистыми марлевой салфеткой или носовым платком с рекомендацией сменить белье по возвращению домой;

**Что делать, если был опасный секс, и не удалось провести экстренную профилактику?**

- Женщинам: принять меры аварийной или посткоитальной контрацепции, чтобы не забеременеть. Это можно сделать не позже 2-х суток после полового акта, приняв 1 таблетку препаратов Эскапел или Постинор.
- Обязательно обратиться к врачу. Не надо стесняться говорить о том, что был незащищенный секс. Существуют способы предотвращения болезней при помощи лекарств, но назначить их может только врач.
- Принимать антибиотики до полового акта бесполезно.
- Принимать лекарства по совету друзей, подруг или работников аптеки бесполезно, даже опасно, так как побочные действия могут угрожать здоровью и жизни.
- В случае заражения ИППП нужно обязательно как можно быстрее обратиться к врачу-дерматовенерологу, гинекологу или урологу.



# АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С СИМПТОМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

При обследовании пациентов доверенный врач должен учитывать, что у большинства из них при углубленном обследовании выявляются несколько инфекций!

78

11

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Мужчина с выделениями и/или болями при мочеиспускании | <p><b>Предполагаемый диагноз:</b> гонококковая или хламидийная инфекция, трихомониаз, негонококковый уретрит (связанный с инфекцией <i>M.genitalium</i>, герпетической инфекцией, другими причинами), уrogenитальный кандидоз</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соберите анамнез</li> <li>2. Проведите полный осмотр кожи и слизистых оболочек, пальпацию периферических лимфатических узлов</li> <li>3. Возьмите материал из уретры (раздел 13.1).</li> <li>4. Соберите материал для лабораторного исследования на <i>C.trachomatis</i>, <i>Trichomonas vaginalis</i>, <i>N.gonorrhoeae</i> (разделы 13.2, 13.7 и 13.3), а также для серологического исследования на сифилис и ВИЧ (раздел 13.5, 13.6). Для исследования на гонококковую инфекцию дополнительно возьмите материал из прямой кишки и ротовой полости (раздел 13.3).</li> <li>5. Проведите при наличии возможностей микроскопию нативного мазка для обнаружения подвижных <i>Trichomonas vaginalis</i> (см. раздел 13.1).</li> <li>6. Проведите при наличии возможностей микроскопию мазка, окрашенного метиленовой синькой (раздел 13.1)</li> </ol> |
| Диагноз уретрита                                         | <p>- устанавливается при обнаружении 4 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения при просмотре более, чем 5 полей зрения при 1000-кратном увеличении микроскопа.</p> <p><b>При получении лабораторного подтверждения диагноза на гонококковую инфекцию</b> (раздел 13.3) <b>заполните и отправьте в КВД Извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, микроспории, трихофитии, фавуса, чесотки по форме №089/у.</b></p> <p><b>Лечение гонококковой инфекции проводится в КВД.</b> Порядок направления см. в разделе 16.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Диагноз негонококкового уретрита                         | <p>-может быть установлен при отсутствии в отделяемом уретры гонококков (раздел 12.2)</p> <p>При отсутствии уретрита лечение не назначается. Попросите пациента придти на следующее утро, не мочиться 3-4 часа перед визитом, и проведите повторное исследование мазка. При повторном отрицательном результате лечение назначать не следует.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Дальнейшая тактика ведения пациента зависит от результатов лабораторного исследования на гонококки, хламидии, трихомонады и микоплазмы.</p> <p>7. Если у пациента имеется ИППП, то обязательному обследованию и, при необходимости, лечению подлежат все выявленные лица, находившиеся в контакте с больным.</p> <p>8. Проведите специфическое лечение пациента согласно установленному диагнозу (раздел 12).</p> <p>9. Проведите контроль излеченности в установленные сроки (см. раздел 12).</p> <p>10. При неустановленном источнике инфицирования необходимо обследовать пациента на сифилис и ВИЧ/СПИД повторно дважды с интервалом в три месяца</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Б. Женщина с выделениями</b>        | <p><b>Вероятные диагнозы:</b> гонококковая или хламидийная инфекция, трихомониаз, кандидоз, бактериальный вагиноз, негонококковый цервицит (связанный с инфекцией <i>M.genitalium</i>) .</p> <p>1. Соберите анамнез.</p> <p>2. Проведите полный осмотр кожи и слизистых оболочек, пальпацию периферических лимфатических узлов.</p> <p>3. Возьмите материал с передней или боковой стенки влагалища для нативного мазка (раздел 13.7). При возможности определите pH влагалищного секрета, используя индикаторные тест-системы.</p> <p>4. Возьмите материал из цервикального канала и уретры для прямой микроскопии (раздел 13.1).</p> <p>5. Возьмите материал из цервикального канала и уретры для лабораторного исследования на хламидии и гонококки (см. раздел 13.2, 13.3). Для исследования на гонококковую инфекцию дополнительно возьмите материал из прямой кишки и ротовой полости (раздел 13.3).</p> <p>6. Возьмите кровь для серологического исследования на сифилис и ВИЧ/СПИД (раздел 13.5, 13.6).</p> <p>7. Проведите при наличии возможностей микроскопию нативного влагалищного мазка для обнаружения <i>Trichomonas vaginalis</i>.</p> |
| <b>Диагноз трихомониаза</b>            | - может быть установлен при обнаружении трихомонад (раздел 13.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Диагноз кандидоза</b>               | - может быть установлен при обнаружении мицелия и спор дрожжеподобных грибов (раздел 13.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Диагноз бактериального вагиноза</b> | <p>- может быть установлен (раздел 13.9) при выявлении "ключевых" клеток и отсутствии лактобацилл</p> <p>1. Проведите при наличии возможностей микроскопию мазка, окрашенного метиленовой синькой (раздел 13.1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Диагноз уретрита</b>                | - устанавливается при обнаружении 10 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения при просмотре более, чем 5 полей зрения при 1000-кратном увеличении микроскопа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Диагноз<br/>цервицита</b>                                                              | <p>- устанавливается при обнаружении 10 полиморфно-ядерных лейкоцитов в поле зрения при просмотре более, чем 5 полей зрения при 1000-кратном увеличении микроскопа и наличии слизисто-гнойных выделений из цервикального канала.</p> <p>Если лабораторией установлен диагноз гонококковой инфекции (раздел 13.3) заполните и отправьте в КВД Извещение по форме №089/у (приложение 7)</p> <p>Лечение гонококковой инфекции проводится в КВД. Порядок направления см. в разделе 16.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Диагноз негонококкового<br/>цервицита</b>                                              | <p>- может быть установлен при отсутствии гонококков в отделяемом цервикального канала (раздел 13.3).</p> <p>1. Если у пациента имеется ИППП, то обязательно обследованию и, при необходимости, лечению подлежат все выявленные лица, находившиеся в контакте с больным.</p> <p>2. Проведите специфическое лечение пациентки согласно установленному диагнозу (раздел 12).</p> <p>3. Проведите контроль излеченности в установленные сроки (раздел 12).</p> <p>4. При неустановленном источнике инфицирования следует повторно обследовать пациентку на сифилис и ВИЧ/СПИД дважды с интервалом в три месяца.</p> <p>13. При наличии микроскопических данных за уретрит, цервицит, кольпит лечение не назначается до получения результатов лабораторного исследования на хламидийную и гонококковую инфекцию, сифилис, ВИЧ/СПИД.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>В. Пациенты<br/>с эрозивно-язвенными поражениями<br/>гениталий (мужчины и женщины)</b> | <p><b>Возможные причины:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сифилис и герпетическая инфекция,</li> <li>- травмы, гонококковая, трихомонадная, хламидийная инфекции,</li> <li>- ряд инфекционных дерматозов (пиодермии, чесотка, кандидоз, папилломавирусная инфекция,</li> <li>- шанкроид, хламидийная лимфогранулема (венерическая).</li> </ul> <p>1. Соберите анамнез.</p> <p>2. Проведите полный осмотр кожи и слизистых оболочек, пальпацию периферических лимфатических узлов.</p> <p>При невозможности выполнения нижеперечисленных рекомендаций направьте пациента в КВД. Порядок направления см. в разделе 16.</p> <p>3. При эрозивно-язвенном процессе на гениталиях возьмите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на <i>T. pallidum</i> - материал из эрозии или язвы для темнопольной микроскопии (раздел 13.5)</li> <li>- для диагностики сифилиса и ВИЧ/СПИД - кровь (раздел 13.5, 13.6)</li> <li>- Если совокупность данных анамнеза и клинической картины при отрицательных результатах лабораторных исследований не исключают возможность заражения сифилисом, рекомендуется повторное исследование,</li> </ul> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>включая подтверждающие реакции (см. раздел 12.7), а также обследование партнера (ов).</p> <p>Диагностика и лечение сифилиса проводится в КВД. Порядок направления см. в разделе 16.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Возьмите материал из эрозии или язвы для исследования на вирус герпеса (раздел 13.4)</li> <li>- Если совокупность данных анамнеза, клинической картины заболевания и лабораторных тестов указывают на первичный аногенитальный герпес, рекомендуется противовирусное лечение (раздел 12.6) и назначается повторный визит через 2 недели.</li> <li>- Если анамнез и данные клинико-лабораторных исследований указывают на рецидивирующий аногенитальный герпес, то антивирусная терапия проводится по соответствующей схеме (раздел 12.6) с возможным назначением иммунотерапии (желательна консультация врача-иммунолога).</li> </ul> <p>4. Возьмите материал из эрозии или язвы, а также уретры и/или цервикального канала, влагалища для выявления гонококков, трихомонад и хламидий.</p> <p>5. Если у пациента имеется ИППП, то обязательному обследованию и при необходимости лечению, подлежат все выявленные лица, находившиеся в контакте с больным.</p> <p>6. Проведите специфическое лечение больного согласно установленному диагнозу (раздел 12).</p> <p>7. Проведите контроль излеченности в установленные сроки (раздел 12).</p> <p>8. При неустановленном источнике инфицирования следует повторно обследовать пациента на сифилис и ВИЧ/СПИД дважды с интервалом в три месяца.</p> <p>При необходимости следует обследовать пациента с целью исключения других возможных причин эрозивно-язвенного поражения гениталий.</p> |
| <b>Г. Пациент с аногенитальными бородавками</b> | <p>Вероятные диагнозы: папилломавирусная инфекция человека, сифилис</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соберите анамнез</li> <li>2. Проведите полный осмотр кожи и слизистых оболочек, пальпацию периферических лимфатических узлов.</li> <li>3. Возьмите кровь для проведения серологических исследований на сифилис, ВИЧ/СПИД (раздел 13.5, 13.6).</li> <li>4. При наличии мокнущей поверхности измененной кожи или слизистых необходимо провести исследование отделяемого на <i>T. pallidum</i> (раздел 13.5).</li> <li>5. При невозможности выполнения этого исследования направьте пациента в КВД. Порядок направления смотрите в разделе 16.</li> <li>6. У женщины проведите кольпоскопию и кольпоцитологическое исследование. При невозможности выполнения этого исследования направьте пациентку к гинекологу. При выявлении предрака и рака шейки матки направьте пациентку к онкологу.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 7. Постоянный половой партнер выявленного пациента с аногенитальными бородавками должен быть приглашен на обследование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Д. Пациенты без клинических симптомов, желающие обследоваться на наличие ИППП</b> | <p>Причиной обращения может быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-появление нового сексуального партнера,</li> <li>-большое количество сексуальных партнеров,</li> <li>-рискованный сексуальный контакт.</li> </ul> <p>Пациенту следует объяснить, что заражение ИППП может происходить и от партнеров, не имеющих явных клинических признаков.</p> <p>Обследование обязательно должно включать исследования на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сифилис,</li> <li>-хламидийную инфекцию,</li> <li>-гонококковую инфекцию,</li> <li>-трихомониаз,</li> <li>-гепатиты,</li> <li>-ВИЧ/СПИД</li> </ul> <p>(см. соответствующие разделы).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Е. Партнер пациента с установленным диагнозом ИППП</b>                            | <p>Хламидийная инфекция и трихомониаз</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-возьмите мазок для прямой микроскопии и материал для исследования на хламидии, трихомонады и возбудителей других ИППП (раздел 13)</li> <li>-начните лечение хламидийной инфекции, трихомониаза, не дожидаясь результатов лабораторных тестов</li> <li>-скорректируйте лечение после получения результатов лабораторных исследований</li> <li>-выявите и обследуйте половых партнеров</li> </ul> <p>Гонококковая инфекция, сифилис, аногенитальный герпес</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-направьте партнера пациента с установленным диагнозом гонококковой инфекции, сифилиса к дерматовенерологу (раздел 13)</li> <li>-при наличии клинических проявлений возьмите материал для исследования на герпетическую инфекцию и другие ИППП (раздел 13)</li> <li>- проведите лечение герпетической инфекции при наличии клинических проявлений</li> </ul> |

# АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИППП И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

83

12

**ВНИМАНИЕ!** При назначении объема диагностических исследований и лечения доверенный врач должен, в первую очередь, руководствоваться действующими Клиническими протоколами диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

## 12.1. ГОНОКОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Обследованию на гонококковую инфекцию подлежат</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Мужчины с гнойными или слизисто-гнойными выделениями из уретры; симптомами дизурии; признаками воспаления придатка яичка, предстательной железы</li><li>• Женщины со слизисто-гнойными выделениями из цервикального канала, симптомами аднексита</li><li>• Лица, вступавшие в половой контакт с больным гонореей</li><li>• Лица, проходящие обследование на другие ИППП</li><li>• Новорожденные с гнойным конъюнктивитом, при выявлении гонорейной этиологии конъюнктивита обследуются родители</li></ul> |
| <b>Возбудитель</b>                                    | <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (грам-отрицательный диплококк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Передача</b>                                       | Половой контакт; от матери к ребенку во время родов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Инкубационный период</b>                           | От нескольких дней до недели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Бессимптомная инфекция</b>                         | У мужчин - до 10%, у женщин - до 50%<br>Диагностика требует обязательного посева на гонококки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Клиническая картина</b>                            | Уретрит, цервицит, проктит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Осложнения</b>                                     | Воспаление придатков яичек, эндометрит, сальпингит, конъюнктивит, фарингит, бактериемия и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Диагностика</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Возьмите мазок из уретры и/или шейки матки и микроскопируйте (при наличии возможностей), покрасив метиленовой синькой</li><li>• При подозрении на гонорею для подтверждения диагноза направьте пациента к дерматовенерологу</li><li>• Пробы берутся из уретры, прямой кишки и ротоглотки, у женщин дополнительно из цервикального канала</li></ul>                                                                                                                                                        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Прямая микроскопия</b><br>(проводится доверенным врачом при наличии возможностей) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У мужчин определяет до 90% инфицированных лиц</li> <li>• У женщин определяет до 30-40% инфицированных лиц</li> </ul>                                               |
| <b>Стратегия в отношении партнера</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Партнеры всегда должны быть осмотрены и обследованы</li> <li>• Партнеры лечатся всегда, вне зависимости от симптомов, после взятия проб на исследование</li> </ul> |

### АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10                                                                                | Минимальный объем диагностических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез (A54.0)</b> | Физикальный осмотр<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>Иммуноферментный анализ на антитела к вирусу иммунодефицита человека (далее-ИФА-ВИЧ)<br>Иммуноферментный анализ на антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (далее - ИФА-Hbs антиген)<br>Иммуноферментный анализ на антитела к антигену вируса гепатита С на областном и республиканском уровне (далее ИФА-HCV)<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов<br>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae<br>Исследование секрета предстательной железы | Цефтриаксон в/м 1,0 однократно<br>или<br>Ципрофлоксацин внутрь 500 мг однократно<br>или<br>Цефиксим внутрь 400 мг однократно<br>или<br>Спектиномицин в/м 2,0 г однократно, у женщин – 4 г (в каждую ягодицу по 2 г)<br>или<br>Офлоксацин внутрь 400 мг однократно<br>или<br>Ломефлоксацин внутрь 800 мг однократно |
| <b>Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных или придаточных желез (A54.1)</b>  | Физикальный осмотр<br>Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>ИФА-ВИЧ<br>ИФА-Hbs антиген<br>ИФА-HCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цефтриаксон в/м или в/в 1,0 г каждые 24 часа 7 дней<br>или<br>Ципрофлоксацин в/в 500 мг каждые 12 часов 7-14 дней<br>или                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на <i>N.gonorrhoeae</i></p> <p>Исследование секрета предстательной железы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Спектиномицин в/м 2,0 г каждые 12 часов 7 дней</p> <p>или</p> <p>Офлоксацин внутрь 200 мг каждые 12 часов 7-14 дней</p> <p>или</p> <p>Ломефлоксацин внутрь 400 мг каждые 24 часа 7-14 дней</p> <p>Патогенетическая терапия:</p> <p>Диклофенак – внутрь или ректально или в/м 100 мг 2 раза в день 5 дней</p> <p>или</p> <p>Индометацин – внутрь или ректально 25-50 мг 2 раза в день 5 дней</p> <p>Вскрытие абсцесса проводится гинекологом или урологом</p> |
|                                                                                                        | <p>Больным, относящимся к категории коммерческих секс-работников, с целью лечения возможной сопутствующей хламидийной инфекции одновременно назначают лечение, используя схемы, как и при неосложненной хламидийной инфекции</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов (A54.2)</b></p> | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к <i>T.pallidum</i></p> <p>ИФА-ВИЧ</p> <p>ИФА-Hbs антиген</p> <p>ИФА-HCV</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на <i>N.gonorrhoeae</i></p> <p>Биохимическое исследование крови: определение общего билирубина, общего белка, аланинаминотрансферазы (далее-АлАТ), аспартатаминотрансферазы (далее-АсАТ), ревматоидного фактора, С-реактивного белка</p> | <p>Лечение пельвиоперитонита проводится в условиях стационара.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Гонококковая инфекция глаз (A54.3)</b>                  | Физикальный осмотр<br>Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>ИФА-ВИЧ<br>ИФА-Hbs антиген<br>ИФА-HCV<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов<br>Бактериологическое исследование из глаз и мочеполовых органов на N.gonorrhoeae<br>Консультация врача-офтальмолога         | Цефтриаксон в/м 1,0 г однократно                                                                                                                                              |
| <b>Гонококковый фарингит (A54.5)</b>                       | Физикальный осмотр<br>Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>ИФА-ВИЧ<br>ИФА-Hbs антиген<br>ИФА-HCV<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов<br>Бактериологическое исследование из глотки и мочеполовых органов на N.gonorrhoeae<br>Консультация врача-оториноларинголога | Цефтриаксон в/м 1,0 г однократно<br>или<br>Офлоксацин внутрь 400 мг однократно<br>или<br>Ципрофлоксацин внутрь 500 мг однократно                                              |
| <b>Гонококковая инфекция аноректальной области (A54.6)</b> | Физикальный осмотр<br>Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>ИФА-ВИЧ<br>ИФА-Hbs антиген<br>ИФА-HCV<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов<br>Бактериологическое исследование из прямой кишки и мочеполовых органов на N.gonorrhoeae                                    | Цефтриаксон в/м 1,0 г однократно<br>или<br>Ципрофлоксацин внутрь 500 мг однократно<br>или<br>Цефутоксим в/м 1,5 г однократно<br>или<br>Ломефлоксацин внутрь 800 мг однократно |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Показания к стационарному лечению</b> | Осложненное течение гонококковой инфекции (эндометрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, простатит, эпидидимит, конъюнктивит, гонорея у беременных, поражение сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и т.п.). Продолжительность стационарного лечения определяется характером клинических проявлений и степенью тяжести воспалительного процесса и составляет 2-4 недели. |
| <b>Контроль излеченности</b>             | Культуральное и микроскопическое исследование по Граму через 7-10 дней, а затем через 1 месяц после лечения. Дальнейшие исследования проводятся по показаниям                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Регистрация Выявление контактов</b>   | Направляется Извещение в КВД по форме №089/у. Является обязательным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ВНИМАНИЕ!</b>                         | <b>Лечение гонореи проводится только в специализированных учреждениях дерматовенерологического профиля.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 12.2. НЕГОНОКОККОВЫЙ УРЕТРИТ И ЦЕРВИЦИТ

Этот диагноз устанавливается методом исключения гонококковой инфекции.

Негонококковым уретритом (НГУ) называют уретрит, не связанный с *N.gonorrhoeae*. Это наиболее распространенный синдром, выявляемый в клиниках ИППП (регистрируется у 20% и более обратившихся мужчин). Термин «неспецифический уретрит» - не очень удачный. Он создает ложное впечатление, что НГУ не имеет причины или его причина неизвестна. В настоящее время считается, что 20-30% НГУ приходится на долю *C.trachomatis*. Причина остальных НГУ окончательно не выяснена. У 20-40% больных НГУ выявляют *Ureaplasma urealiticum*. Однако данные об этиологической роли этого микроорганизма противоречивы и, на сегодняшний день, большинство ученых не принимают его в качестве причины НГУ. Примерно у трети больных не обнаруживают ни *C.trachomatis*, ни *Ureaplasma urealiticum*. В то же время все больше исследований подтверждают участие *Mycoplasma genitalium* в этиологии НГУ.

Ассоциация НГУ с оральным сексом у мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ) и бисексуальных мужчин свидетельствует о том, что часть НГУ обусловлена нормальной микрофлорой ротоглотки. Менее 5% случаев НГУ приходится на *Trichomonas vaginalis* и вирус простого герпеса (ВПГ). У МСМ и бисексуальных мужчин, практикующих активные анальные половые контакты, иногда вызывают уретрит энтеробактерии.

**ВНИМАНИЕ! Шифрование диагнозов больных в официальной медицинской документации проводится согласно установленной этиологии НГУ и основано на действующей «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (раздел 1).**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Симптомы</b>                   | <p>Мужчины: выделения из уретры, болезненность при мочеиспускании, зуд и раздражение в уретре; симптомы могут отсутствовать.</p> <p>Уретрит, вызванный ВПГ, часто сочетается с высыпаниями на половых органах и выраженной болью при мочеиспускании. Для герпетического уретрита также характерна болезненность при пальпации по ходу мочеиспускательного канала.</p> <p>Женщины: выделения из половых путей, симптомы дизурии, симптомы могут отсутствовать</p>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Диагностика</b>                | <p>Микроскопическое исследование мазка из уретры и цервикального канала, окрашенного метиленовой синькой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• уретрит у мужчин: более чем 4 полиморфноядерных лейкоцита в поле зрения микроскопа при 1000-кратном увеличении при просмотре не менее 5 полей зрения</li> <li>• цервицит у женщин: в поле зрения микроскопа при 1000-кратном увеличении более чем 10 полиморфноядерных лейкоцитов в сочетании со слизисто-гнойными выделениями из цервикального канала</li> </ul> <p>Провести лабораторное исследование для определения этиологии. Исследование следует повторить, если симптомы сохраняются.</p> |
| <b>Этиология</b>                  | <p>Хламидии, трихомонады, дрожжеподобные грибы, микоплазмы, вирусы герпеса, папилломавирусы, а также факультативные и анаэробные бактерии.</p> <p>Важно исключить гонококковую инфекции как у пациента, так и у партнера.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Пути заражения</b>             | <p>Первый эпизод НГУ почти всегда связан с половыми контактами, в том числе при отсутствии хламидий – с оральным сексом. Рецидивирующий нехламидийный НГУ чаще всего является обострением хронической инфекции, а не повторным заражением.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Эпидемиологический анамнез</b> | <p>Нередко выявляются сведения о новом или случайном половом контакте.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Пол</b>                        | <p>НГУ по определению бывает только у мужчин. У женщин – половых партнеров мужчин с НГУ – возможен цервицит со слизисто-гнойными выделениями.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Сексуальная ориентация</b>     | <p>Встречается как у гетеросексуальных мужчин, так и у мужчин-гомосексуалистов и бисексуальных мужчин. Среди двух последних категорий на долю <i>C.trachomatis</i> приходится менее 10% случаев НГУ. Многие случаи НГУ в этой группе ассоциируются с оральным сексом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Инкубационный период</b>       | <p>Обычно составляет 1-3 недели. НГУ часто протекает бессимптомно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Осложнения</b>                 | <p>Основные осложнения – это осложнения хламидийной инфекции (острый эпидидимит и синдром Рейтера). Ни одно из этих осложнений не бывает при нехламидийном НГУ. Доказательств, что НГУ приводит к стриктурам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | уретры нет. В отсутствие <i>C.trachomatis</i> ни острый, ни рецидивирующий НГУ не ассоциируется с тяжелыми осложнениями ни у мужчин, ни у женщин - их половых партнеров.                     |
| <b>Лечение</b>                  | Согласно этиологическому и топическому диагнозу, чаще всего с использованием антибиотиков. Вопрос о целесообразности антибиотикотерапии в отсутствие <i>C.trachomatis</i> остается открытым. |
| <b>Контроль излеченности</b>    | В зависимости от этиологии заболевания                                                                                                                                                       |
| <b>Дифференциальный диагноз</b> | Инородные тела мочеиспускательного канала и периуретральная фистула.                                                                                                                         |
| <b>Регистрация</b>              | Проводится по месту выявления больного                                                                                                                                                       |
| <b>Выявление контактов</b>      | Партнеры всегда должны быть осмотрены и обследованы                                                                                                                                          |

### 12.3. БАЛАНИТ/БАЛАНОПОСТИТ, ВУЛЬВОВАГИНИТ (КОЛЬПИТ)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жалобы</b>                       | Зуд, раздражение, жжение кожи головки полового члена и крайней плоти у мужчин и области преддверия влагалища у женщин                                                                                                                                              |
| <b>Клиническая картина</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У мужчин - покраснение, отек, выделения, эрозии, трещины, шелушение, сухая и истонченная кожа головки и крайней плоти</li> <li>• У женщин - выделения из влагалища, при осмотре в зеркалах признаки воспаления</li> </ul> |
| <b>Этиология:</b>                   | Многофакторная                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>сифилис</b>                      | Как осложнение первичной сифиломы, а также атипичный шанкр-баланит Фолльмана                                                                                                                                                                                       |
| <b>вирусная</b>                     | Папилломавирусная инфекция, генитальный герпес, контагиозный моллюск                                                                                                                                                                                               |
| <b>бактериальная</b>                | Вызванные стрептококками, стафилококками, грамотрицательными палочками, анаэробными кокками, генитальными микоплазмами и др.                                                                                                                                       |
| <b>грибковая</b>                    | Вызванные дрожжеподобными грибами рода <i>Candida</i>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>трихомониаз</b>                  | Вызванные <i>Trichomonas vaginalis</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>другие ИППП</b>                  | Хламидийная инфекция                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>паразитарные заболевания</b>     | Чесотка и лобковая вшивость                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>побочное действие препаратов</b> | Фиксированная эритема                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>токсические воздействия</b>      | Чрезмерная обработка мылом и водой, местными поверхностно-активными препаратами наружных и внутренних половых органов                                                                                                                                              |
| <b>дерматозы</b>                    | Псориаз<br>Красный плоский лишай<br>Аллергический дерматит                                                                                                                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>системные заболевания</b>     | Сахарный диабет<br>Синдром Рейтера<br>Синдром Бехчета                                                                                                                                                                         |
| <b>доброкачественные опухоли</b> | Папилломы, пигментированные пороки развития, ангиомы.                                                                                                                                                                         |
| <b>злокачественные опухоли</b>   | Плоскоклеточный рак, меланома, Экстрамаммарная болезнь Педжета, эритроплазия Кейра                                                                                                                                            |
| <b>Диагностика</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анамнез</li> <li>• Осмотр кожных покровов, придатков кожи, видимых слизистых</li> <li>• Лабораторная диагностика в зависимости от предполагаемого этиологического фактора</li> </ul> |
| <b>Лечение</b>                   | Этиологическое, патогенетическое и симптоматическое лечение в зависимости от установленного диагноза у соответствующего специалиста                                                                                           |
| <b>Лечение партнера</b>          | Обследование и лечение партнера проводится при выявлении ИППП                                                                                                                                                                 |

#### 12.4. ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Возбудитель</b>                     | Обследование и лечение партнера проводится при выявлении ИППП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Передача</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Половой контакт</li> <li>• От матери ребенку при родах</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Инкубационный период</b>            | 5-7 дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Бессимптомная инфекция</b>          | В зависимости от локализации до 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Основные клинические проявления</b> | <p><b>У женщин</b> - слизистые или слизисто-гнойные выделения из половых путей, межменструальные или посткоитальные кровянистые выделения, боли внизу живота</p> <p><b>У мужчин</b> - симптомы уретрита</p>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Осложнения</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эпидидимит, простатит</li> <li>• Воспалительные заболевания органов малого таза (эндометрит, сальпингит, сальпингоофорит)</li> <li>• Внематочная беременность</li> <li>• Бесплодие</li> <li>• Синдром тазовых болей</li> <li>• Перигепатит (синдром Фитц-Хью-Куртиса)</li> <li>• Конъюнктивит взрослых</li> <li>• Реактивный артрит (синдром Рейтера)</li> </ul> |
| <b>Взятие образцов</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У женщин пробы берутся из цервикального канала (методы диагностики: культуральный, ПИФ, ПЦР, ИФА на антиген) и/или уретры (методы диагностики: культуральный, ПИФ, ПЦР, ИФА на антиген) и/или влагалища (методы диагностики: ПЦР)</li> </ul>                                                                                                                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>У мужчин пробы берутся из уретры (методы диагностики: культуральный, ПИФ, ПЦР, ИФА на антиген) или исследуется первая порция мочи (методы диагностики: ПЦР, ЛЦР).</li> </ul> <p>Пациент должен воздержаться от мочеиспускания в течение 2-х часов до взятия образца</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Техника взятия материала зависит от применяемых методов (раздел 13.2)</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Лабораторная диагностика</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прямая иммунофлюоресценция (ПИФ)</li> <li>Посев на клеточные культуры</li> <li>Иммуноферментный анализ (ИФА на антиген)</li> <li>Полимеразная цепная реакция (ПЦР)</li> <li>Лигазная цепная реакция (ЛЦР)</li> <li>ДНК-гибридизация</li> <li>Серологическое исследование не имеет диагностического значения и используется для проведения эпидемиологических исследований</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Прямая микроскопия</b><br>(проводится при наличии возможностей доверенным врачом) | <p>Мазки, окрашиваемые метиленовой синью, берутся из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Мужской уретры:</b> хламидии часто вызывают уретрит, при котором в мазке имеется 5 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения микроскопа (x1000);</li> <li><b>Женской уретры:</b> хламидии вызывают уретрит, при котором в мазке имеется 10 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения микроскопа (x1000);</li> <li><b>Цервикального канала:</b> хламидии вызывают цервицит, при котором в мазке имеется 10 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения микроскопа (x1000);</li> </ul> |
|                                                                                      | <b>Важно:</b> не у всех лиц, инфицированных хламидиями, при микроскопии выявляют признаки воспаления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10                      | Минимальный объем диагностических исследований                                                                                                                                                                                                                                                 | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта (A56.0)</b> | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к T.pallidum</p> <p>ИФА-ВИЧ</p> <p>ИФА-Hbs антиген</p> <p>ИФА-HCV</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae</p> | <p>Доксициклин внутрь по 100 мг 2 раза в сутки 7 дней или</p> <p>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно</p> <p>или</p> <p>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 7 дней</p> <p>или</p> <p>Кларитромицин внутрь 250-500 мг 2 раза в день 10 дней</p> <p>или</p> <p>Офлоксацин внутрь 200 мг 2 раза в день 10 дней</p> |



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>МАНК (на областном и республиканском уровнях, беременным на всех уровнях) на хламидии, РИФ (ПИФ) или ИФА на хламидийный антиген</p> <p>Исследование секрета предстательной железы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>или</p> <p>Ломефлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 10 дней</p> <p>или</p> <p>Моксифлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 10 дней</p> <p>или</p> <p>Левифлоксацин внутрь 500 мг 1 раз в день 14 дней</p> <p>Лечение беременных:</p> <p>Эритромицин внутрь 500 мг 4 раза в день 7-14 дней</p> <p>или</p> <p>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 7 дней</p> <p>или</p> <p>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов (A56.1)</b></p> | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к T.pallidum</p> <p>ИФА-ВИЧ</p> <p>ИФА-Hbs антиген</p> <p>ИФА-НСV</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae</p> <p>МАНК (на областном и республиканском уровнях, беременным - на всех уровнях) на хламидии, РИФ (ПИФ) или ИФА на хламидийный антиген</p> <p>Исследование секрета предстательной железы</p> | <p>Доксициклин внутрь по 100 мг 2 раза в сутки 14 дней или в/в по 100 мг 2 раза в сутки 7 дней</p> <p>или</p> <p>Азитромицин внутрь по 500 мг 1 раз в день 10 дней или в/в по 500 мг 1 раз в день 7 дней</p> <p>или</p> <p>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 10 дней</p> <p>или</p> <p>Кларитромицин внутрь 250-500 мг 2 раза в день 14 дней</p> <p>или</p> <p>Офлоксацин внутрь 200 мг 2 раза в день 14 дней</p> <p>или</p> <p>Ломефлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 14 дней</p> <p>или</p> <p>Моксифлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 14 дней</p> <p>или</p> <p>Левифлоксацин внутрь 500 мг 1 раз в день 14 дней</p> <p>Патогенетическая терапия:</p> <p>Диклофенак – внутрь или ректально или в/м 100 мг в день 5 дней</p> <p>или</p> <p>Индометацин – внутрь или ректально 25-50 мг 2 раза в день 5 дней</p> <p>Лечение беременных:</p> <p>Эритромицин внутрь 500 мг 4 раза в день 21 день</p> <p>или</p> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 14 дней или</p> <p>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно, затем по 500 мг 1 раз в день 10 дней или</p> <p>Спирамицин внутрь 3 млн ЕД 3 раза в день 14 дней</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Хламидийная инфекция аноректальной области (A56.3)</b> | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к T.pallidum</p> <p>ИФА-ВИЧ</p> <p>ИФА-Hbs антиген</p> <p>ИФА-HCV</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae</p> <p>МАНК (на областном и республиканском уровнях, беременным - на всех уровнях) на хламидии, РИФ (ПИФ) или ИФА на хламидийный антиген</p> <p>Исследование секрета предстательной железы</p> | <p>Доксициклин внутрь по 100 мг 2 раза в сутки 7 дней или</p> <p>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно или</p> <p>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 7 дней или</p> <p>Кларитромицин внутрь 250-500 мг 2 раза в день 10 дней или</p> <p>Офлоксацин внутрь 200 мг 2 раза в день 7 дней или</p> <p>Ломефлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 10 дней или</p> <p>Моксифлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 10 дней или</p> <p>Левифлоксацин внутрь 500 мг 1 раз в день 7 дней</p> <p>Лечение беременных:</p> <p>Эритромицин внутрь 500 мг 4 раза в день 10 дней или</p> <p>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 10 дней или</p> <p>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно, затем по 500 мг 1 раз в день 7 дней или</p> <p>Спирамицин внутрь 3 млн ЕД 3 раза в день 10 дней</p> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Хламидийный фарингит (A56.4)</b> | Физикальный осмотр<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>ИФА-ВИЧ<br>ИФА-Hbs антиген<br>ИФА-НСV<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых<br>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae<br>МАНК (на областном и республиканском уровнях, беременным - на всех уровнях) на хламидии, РИФ (ПИФ) или ИФА на хламидийный антиген | Доксициклин внутрь по 100 мг 2 раза в сутки (первый прием – 200 мг) 10 дней<br>или<br>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно<br>или<br>Джозамицин внутрь 1 г однократно, затем по 500 мг 3 раза в день 10 дней<br>или<br>Кларитромицин внутрь 250-500 мг 2 раза в день 10 дней<br>или<br>Офлоксацин внутрь 200 мг 2 раза в день 10 дней<br>или<br>Ломефлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 10 дней<br>или<br>Моксифлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в день 10 дней<br>или<br>Левофлоксацин внутрь 500 мг 1 раз в день 10 дней<br>Лечение беременных:<br>Эритромицин внутрь 500 мг 4 раза в день 10 дней<br>или<br>Джозамицин внутрь по 500 мг 3 раза в день 10 дней<br>или<br>Азитромицин внутрь 1,0 г однократно<br>или |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

При развитии осложнений (воспалительный процесс органов малого таза, болезнь Рейтера и т.п.) лечение рекомендуется проводить в специализированных стационарах дерматовенерологического и акушерско-гинекологического профиля. Продолжительность стационарного лечения определяется характером клинических проявлений и степенью выраженности воспалительного процесса и составляет от 2 до 6 недель.

|                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стратегия в отношении партнера</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• партнеры всегда должны быть осмотрены и обследованы</li> <li>• партнеры лечатся всегда, вне зависимости от симптомов, после взятия проб на исследование</li> </ul> |
| <b>Контроль излеченности</b>          | Рекомендуется через 4-6 недель после лечения                                                                                                                                                                |
| <b>Регистрация</b>                    | Проводится по месту выявления больного                                                                                                                                                                      |
| <b>Выявление контактов</b>            | Является обязательным                                                                                                                                                                                       |

## 12.5. ТРИХОМОНИАЗ

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Возбудитель</b>                                                                   | <i>Trichomonas vaginalis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Передача</b>                                                                      | При половом контакте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Клинические проявления</b>                                                        | <p><b>У женщин:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выделения желто-зеленые пенистые с неприятным запахом</li> <li>• Зуд</li> <li>• Кольпит и цервицит</li> <li>• Иногда явления уретрита</li> </ul> <p>У 10-50% женщин заболевание протекает бессимптомно</p> <p><b>У мужчин:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протекает бессимптомно у 15-50%</li> <li>• Иногда явления уретрита, редко – простатита</li> </ul> |
| <b>Взятие материала</b>                                                              | С передней и боковой стенки влагалища у женщин<br>Из уретры у мужчин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Диагностика</b>                                                                   | В основном, при микроскопии нативного препарата (обнаружение подвижных форм трихомонад). В некоторых случаях проводится посев на специальные питательные среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Прямая микроскопия</b><br>(проводится доверенным врачом при наличии возможностей) | Нативный препарат:<br>- повышенное количество лейкоцитов<br>- подвижные трихомонады<br>У мужчин выявить <i>Trichomonas vaginalis</i> в нативном препарате трудно, поэтому предпочтительно использовать культуральный метод диагностики                                                                                                                                                                                                         |

### АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10 | Минимальный объем диагностических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Урогенитальный трихомониаз (A59.0)</b>         | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к <i>T.pallidum</i></p> <p>ИФА-ВИЧ</p> <p>ИФА-Hbs антиген</p> <p>ИФА-HCV</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов</p> <p>Микроскопическое исследование нативного мазка отделяемого мочеполовых органов</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на <i>N.gonorrhoeae</i></p> | <p>Неосложненные формы:</p> <p>Метронидазол внутрь 500 мг 3 раза в сутки 7 дней</p> <p>Или</p> <p>Тинидазол внутрь 2 г однократно перед сном</p> <p>или</p> <p>Орнидазол внутрь 500 мг внутрь каждые 12 часов 5 дней</p> <p>Осложненные формы:</p> <p>Метронидазол внутрь 500 мг 4 раза в сутки 7 дней или в/в 500 мг 3 раза в сутки 7 дней</p> <p>или</p> |

|  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>МАНК (на областном и республиканском уровнях) на <i>Tr.vaginalis</i></p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на <i>Tr.vaginalis</i></p> | <p>Тинидазол внутрь 2 г 1 раз в сутки 3 дня</p> <p>или</p> <p>Орнидазол внутрь 500 мг каждые 12 часов 10 дней</p> <p>Местное лечение:</p> <p>Метронидазол 100-500 мг интравагинально 1 раз в сутки 6-7 дней</p> <p>Лечение беременных (со второго триместра):</p> <p>Метронидазол внутрь 500 мг 3 раза в сутки 7 дней</p> <p>или</p> <p>Тинидазол внутрь 2 г однократно перед сном</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p><b>ВАЖНО:</b> Следует с осторожностью назначать метронидазол и тинидазол на последних сроках беременности, непосредственно перед родами и в период лактации в связи с возможностью проявления мутагенных и канцерогенных эффектов.</p> |
| <b>Контроль излеченности</b> | Через 10-14 дней после окончания лечения, далее по показаниям                                                                                                                                                                             |
| <b>Лечение партнера</b>      | Партнер обследуется на трихомонады и на другие ИППП и лечится, даже если <i>Trichomonas vaginalis</i> у него не обнаружены                                                                                                                |
| <b>Выявление контактов</b>   | Необходимо                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Регистрация</b>           | Обязательна                                                                                                                                                                                                                               |

## 12.6. АНОГЕНИТАЛЬНАЯ ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ [HERPES SIMPLEX]

Вирусная инфекция, характеризующаяся пожизненным носительством вируса и периодическим его размножением, приводящим к развитию клинического рецидива, или протекающая бессимптомно.

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Возбудитель</b>            | Вirus Herpes simplex типа 1 и 2 (HSV-1 и HSV-2)                                                                                                                                |
| <b>Передача</b>               | При половом контакте. Около 50 % первичного генитального герпеса вызывается HSV-1 и передается при оральных контактах. Вирус может передаваться от матери к ребенку при родах. |
| <b>Инкубационный период</b>   | От 1 до 26 дней, обычно около 7 дней                                                                                                                                           |
| <b>Бессимптомная инфекция</b> | 75% серопозитивных людей считают, что у них никогда не было никаких симптомов                                                                                                  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Риск инфицирования во время однократного незащищенного полового контакта</b> | Неизвестен. Поскольку бессимптомные носители распространяют вирус не постоянно (прерывисто, кратковременно), то риск инфицирования установить невозможно. Необходимо использовать презерватив.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Клиника:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>-первичная инфекция</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие явления: лихорадка, симптомы, напоминающие грипп, иногда с менингеальной симптоматикой.</li> <li>• Клинические проявления на коже и слизистых: эритема, пузырьки, эрозивные и язвенные дефекты на гениталиях, образованию которых предшествует зуд, жжение, болезненность.</li> <li>• Почти всегда увеличиваются регионарные лимфатические узлы: тестоватой консистенции, болезненные.</li> <li>• Длительность течения заболевания приблизительно 16 дней.</li> </ul> |
| <b>-рецидив заболевания</b>                                                     | Рецидивы протекают в более мягкой форме и с меньшей длительностью, около 7-9 дней. Генитальная HSV-2 инфекция рецидивирует значительно чаще по сравнению с HSV-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>-бессимптомная инфекция</b>                                                  | Обычно происходит бессимптомное выделение вируса. Оно играет важную роль для распространения инфекции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>-неонатальный герпес</b>                                                     | Редкая, но серьезная угроза для здоровья ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Взятие образцов и диагностика</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал для исследования - содержимое пузырьков и/или отделяемое с эрозивно-язвенной поверхности проявлений на коже и слизистых. При бессимптомных формах - соскоб эпителия уретры и/или цервикального канала</li> <li>• Взятие материала необходимо осуществлять в период выделения вируса: при первичном инфицировании оно продолжается около 12 дней, при рецидивах - около 5 дней.</li> </ul>                                                                          |
| <b>Лабораторная диагностика</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПИФ</li> <li>• ПЦР</li> <li>• выделение в культуре клеток</li> <li>• серологическая диагностика не имеет решающего значения (около 90% населения серопозитивно).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10                            | Минимальный объем диагностических исследований                                                                                                                                                                                                | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex] (A60)</b> | Физикальный осмотр<br>Исследование крови на антитела к T.pallidum<br>Микроскопическое исследование отделяемого эрозий на T.pallidum<br>ИФА-ВИЧ<br>ИФА-Hbs антиген<br>ИФА-HCV<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | Первичная инфекция:<br>Ацикловир – внутрь 200 мг 5 раз в день 5-10 дней или 400 мг 3 раза в день 5-10 дней или<br>Валацикловир – внутрь по 500 мг 2 раза в день 5 дней<br>Местное лечение: ацикловир 2,5-5% крем (мазь) до 5 раз в день 5-10 дней<br>Рецидивирующая инфекция (обострение):<br>Ацикловир – внутрь 200 мг 5 раз в день 5-10 дней или 400 мг 3 раза в день 5-10 дней или<br>Валацикловир – внутрь по 500 мг 2 раза в день 5 дней<br>Супрессивная терапия: ацикловир внутрь 400 мг 2 раза в день 12 месяцев или Валацикловир – внутрь по 500 мг 1 раз в день 12 месяцев<br>Лечение беременных: при первичных формах герпетической инфекции у беременных лечение проводится по схемам, указанным выше. |

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Регистрация</b>         | Проводится по месту выявления больного                                                           |
| <b>Выявление контактов</b> | Партнеры должны быть осмотрены и обследованы и при наличии у них проявлений герпеса – пролечены. |

## 12.7. СИФИЛИС

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Возбудитель</b>          | <i>Treponema pallidum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Клиническая картина:</b> | Болезнь развивается с типичными стадиями и симптомами, но может протекать скрыто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>первичный сифилис</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Первый симптом - первичная сифилома (ПС) - это эрозия или язва (шанкр) с уплотнением в основании, как правило, безболезненная, возникает в месте внедрения бледной трепонемы</li><li>• Наиболее частые локализации ПС - пенис, вульва, влагалище, шейка матки, язык, губы и т.д.</li><li>• ПС обычно появляется через 2-6 недель (иногда до 3-х месяцев) после заражения</li><li>• ПС, как правило, сопутствует регионарный склераденит</li><li>• ПС может проходить незамеченной при локализации в прямой кишке, на шейке матки</li><li>• Существуют атипичные варианты ПС: шанкр-панариций, шанкр-амигдалит, индуративный отек, баланит Фолльмана.</li><li>• ПС может осложняться вторичной инфекцией</li><li>• ПС регрессирует в течение 2-5 недель без лечения с образованием рубца или без него</li><li>• Общая длительность первичного периода 6-8 недель</li></ul>                                                                                                                                 |
| <b>вторичный сифилис</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Распространенные высыпания на коже и слизистых: розеолезный, папулезный, везикулезный, пустулезный варианты сифилидов.</li><li>• Сыпь появляется на любой части тела через 3-6 недель после появления ПС.</li><li>• Элементы сыпи заразны. Любой физический контакт здорового человека с сифилидами вторичного периода может приводить к заражению, если у контактирующего имеется повреждение кожи или слизистых оболочек. Сыпь обычно проходит без лечения через несколько недель или месяцев.</li><li>• Другие симптомы: слабая лихорадка, утомляемость, головная боль, ангина, выпадение волос (очаговое или диффузное), пигментная лейкодерма, увеличение всех групп лимфатических узлов. Эти симптомы могут быть очень слабыми и, подобно ПС первичного сифилиса, исчезают без лечения.</li><li>• Признаки вторичного сифилиса могут проявляться и проходить в течение одного-двух лет.</li><li>• При вторичном сифилисе могут появляться признаки раннего висцерального и нейросифилиса.</li></ul> |
| <b>латентный сифилис</b>    | Периоды активности заболевания (наличие высыпаний) чередуются с латентными периодами. Будучи нелеченным, сифилис может перейти в поздний скрытый период, во время которого болезнь менее заразна и нет никаких клинических симптомов, но серологические реакции остаются положительными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>третичный сифилис</b> | Третичный период сифилиса, морфологической основой которого является гранулематозное воспаление, наступает через 3-6 и более лет после заражения. Помимо кожи и слизистых может поражаться сердце, печень, нервная система, органы чувств, опорно-двигательный аппарат, что приводит к психическому расстройству, слепоте, неврологическим проблемам, болезням сердца и внутренних органов. Болезнь может заканчиваться летально.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Нейросифилис</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эта стадия может длиться несколько лет или десятилетий</li> <li>• У 3-7% лиц с нелеченным сифилисом развивается нейросифилис во время ранних стадий инфекции</li> <li>• У некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно</li> <li>• Варианты поражения нервной системы разнообразны. Для ранних стадий заболевания характерен менингеальный и менигговаскулярный характер поражения, а для поздних - паренхиматозный нейросифилис с соответствующей симптоматикой</li> <li>• Воспаление мягкой мозговой оболочки вызывает головную боль, ригидность затылочных мышц и лихорадку</li> <li>• Поражение кровеносных сосудов может привести к развитию симптомов паралича с потерей чувствительности, мышечной слабости, ухудшению зрения и т.д.</li> </ul> |
| <b>Передача инфекции</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заражение возможно при половых и тесных бытовых контактах</li> <li>• В большинстве случаев передается при половом контакте, редко - трансфузионное или внутриутробное заражение</li> <li>• При бытовых контактах кожи, слизистых оболочек гениталий, полости рта и ануса с заразными элементами сыпи больного или их отделяемым</li> <li>• Через повреждения на коже и, возможно, через неповрежденную слизистую оболочку</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Диагностика</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клинические проявления</li> <li>• Темнопольная микроскопия отделяемого заразных элементов</li> <li>• Серологическое исследование: <ul style="list-style-type: none"> <li>- скрининговые (отборочные) реакции (МРП или RPR или VDRL или комплекс серологических реакций с определением титра антител)</li> <li>- подтверждающие реакции: РПГА, ИФА, РИФ, РИТ</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Взятие пробы</b>      | раздел 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10                                                                                                            | Минимальный объем диагностических исследований                                                                      | Лечение и препараты выбора                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Первичный сифилис половых органов (A51.0)</b><br><b>Первичный сифилис анальной области (A51.1)</b><br><b>Первичный сифилис других локализаций (A51.2)</b> | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу | Лечение проводит врач-сифилидолог                  |
| <b>Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек (A51.3)</b><br><b>Ранний сифилис скрытый (A51.5)</b>                                                          | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу | Лечение проводит врач-сифилидолог                  |
| <b>Другие формы вторичного сифилиса (ранние формы сифилиса с висцеральными поражениями и нейросифилиса) (A51.4)</b>                                          | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу | Лечение проводится в специализированном стационаре |
| <b>Сифилис сердечно-сосудистой системы (A52.0)</b><br><b>Другие симптомы позднего сифилиса висцерального (A52.7)</b>                                         | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу | Лечение проводится в специализированном стационаре |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нейросифилис с симптомами (A52.1)<br/>Асимптомный нейросифилис (A52.2)<br/>Нейросифилис неуточненный (A52.3)</b> | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу                                                                                                                                                                                | Лечение проводится в специализированном стационаре                                                                                                                                                            |
| <b>Поздний сифилис скрытый (A52.8)</b>                                                                              | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу                                                                                                                                                                                | Лечение проводится в специализированном стационаре                                                                                                                                                            |
| <b>Другие симптомы позднего сифилиса (сифилис третичный без висцеральных поражений) (A52.7)</b>                     | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу                                                                                                                                                                                | Лечение проводится в специализированном стационаре                                                                                                                                                            |
| <b>Серорезистентный сифилис (A53.1)</b>                                                                             | Для продолжения обследования и окончательного установления диагноза пациента следует направить к врачу-сифилидологу                                                                                                                                                                                | Лечение у врача-сифилидолога.<br>Лечение беременных проводится стационарно                                                                                                                                    |
| <b>Другой вид профилактической химиотерапии (превентивное лечение сифилиса) (Z29.2)</b>                             | Физикальный осмотр<br>Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи<br>МРП или RPR<br>ИФА на антитела к T. Pallidum, РПГА или РИФ-абс., РИФ-200 (на областном и республиканском уровнях)<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов<br>ИФА-ВИЧ<br>При беременности – глюкоза крови | Превентивному лечению подлежат лица, имевшие половой или тесный бытовой контакт с больными ранними формами сифилиса, если с момента контакта прошло не более 3 месяцев.<br>Лечение проводит врач-сифилидолог. |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Другой вид профилактической химиотерапии (профилактическое лечение сифилиса) (Z29.2)</b> | Физикальный осмотр<br>Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи<br>МРП или RPR<br>ИФА на антитела к T. Pallidum, РПГА или РИФ-абс., РИФ-200 (на областном и республиканском уровнях)<br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов<br>ИФА-ВИЧ<br>При беременности – глюкоза крови<br>Флюорография<br>Консультация врача-акушера-гинеколога | Профилактическое лечение беременных проводится женщинам, болевшим сифилисом, у которых к началу беременности не произошла полная негативация МРП или RPR, а также женщинам, начавшим лечение сифилиса во время беременности.<br>Лечение проводит врач-сифилидолог. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Первичное лечение сифилиса у беременных проводится сразу после установления диагноза независимо от срока беременности.</li> <li>• Профилактика врожденного сифилиса проводится, начиная с 20 недели беременности.</li> <li>• Пациент незаразен уже через 24 часа после начала лечения</li> <li>• Некоторые, к примеру ВИЧ-положительные, не реагируют на обычные дозы пенициллина, что может потребовать изменения схем лечения.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВНИМАНИЕ!</b> | Диагностика и лечение сифилиса проводятся только в специализированных учреждениях дерматовенерогического профиля |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сифилис у беременных</b> | При нелеченном сифилисе у беременных инфекция может передаваться плоду:<br>- в 25% случаев беременность заканчивается мертворождением или гибелью новорожденного<br>- в 40-70% случаев рождаются дети с врожденным сифилисом |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Врожденный сифилис</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• подразделяется на ранний и поздний.</li> <li>• Некоторые дети с ранним врожденным сифилисом могут иметь клинические проявления заболевания при рождении, но у большинства они развиваются в сроки от двух недель до трех месяцев после рождения</li> <li>• Клинические проявления: кожа морщинистая серо-желтой окраски со специфическими высыпаниями, в том числе, характерными только для врожденного сифилиса (сифилитическая пузырьчатка, диффузные папулезные инфильтрации); поражения опорно-двигательного аппарата; лихорадка, увеличение печени и селезенки, анемия и различные пороки развития</li> <li>• Возможно скрытое течение</li> <li>• В дальнейшем (после 2 лет) могут развиваться симптомы позднего врожденного сифилиса, включающие повреждение костей, зубов, глаз, органа слуха и мозга</li> </ul> |
| <b>Контроль излеченности</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пациентам, получающим лечение по поводу сифилиса, необходимо периодически проводить клинико-серологическое контрольное исследование</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лечение партнера</b>      | Обязательно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Выявление контактов</b>   | Обязательно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Регистрация</b>           | Направляется Извещение в КВД по форме №089/у.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 12.8. КАНДИДОЗНЫЙ ВУЛЬВОВАГИНИТ

Кандидоз встречается часто, и около 75% всех женщин переносят в своей жизни хотя бы один эпизод этого заболевания. Кандидоз не является ИППП, но может свидетельствовать об изменениях иммунного и/или гормонального статуса.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Инфекционный агент</b>     | Candida albicans в 80-92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Состояние носительства</b> | Около 20% здоровых женщин являются носителями дрожжеподобных грибов во влагалище, что не требует лечения                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Клиническая картина</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Интенсивно выраженное раздражение и зуд во влагалище</li> <li>• Типичные белые творожистые выделения</li> <li>• Жжение вульвы при мочеиспускании и болезненность при половом контакте</li> <li>• При хронически рецидивирующем заболевании часто наблюдается обострение перед началом менструации</li> </ul> |
| <b>Осложнения</b>             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Взятие образцов</b>        | Из свода и боковой стенки влагалища (раздел 13.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Диагностика</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клинические симптомы</li> <li>• Микроскопия нативного мазка и/или мазка окрашенного метиленовой синькой и обнаружение мицелия</li> <li>• Культуральное исследование с выделением дрожжеподобных грибов проводится при рецидивирующем кандидозе или при необходимости провести исследование на антибиотикочувствительность</li> </ul> |
| <b>Прямая микроскопия</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• В нативном мазке обнаруживается мицелий, иногда споры грибов.</li> <li>• Лактобациллы, представляющие нормальную флору влагалища, часто сохранены</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

### АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| <b>Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10</b> | <b>Минимальный объем диагностических исследований</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Лечение и препараты выбора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кандидоз вульвы и вагины (B37.3)</b>                  | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к T.pallidum ИФА-ВИЧ</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae</p> <p>Микроскопическое исследование нативного мазка отделяемого мочеполовых органов</p> | <p>Местное лечение:</p> <p>Миконазол – суппозитории вагинальные 100 мг или крем вагинальный 2% 1 раз в день 7 дней</p> <p>или</p> <p>Клотримазол – таблетки вагинальные 100 мг или крем вагинальный 1% 1 раз в день 6 дней</p> <p>Системная терапия:</p> <p>Флуконазол – внутрь 150 мг однократно</p> <p>или</p> <p>Итраконазол – внутрь 200 мг 2 раза в день 1 день</p> <p>Хронический рецидивирующий кандидоз:</p> <p>Флуконазол – внутрь 150 мг 2 раза с интервалом в 3 дня или</p> <p>Итраконазол – внутрь 200 мг 1 раз в день 3 дня</p> <p>Местное лечение:</p> <p>Миконазол – суппозитории вагинальные 100 мг или крем вагинальный 2% 1 раз в день 14 дней</p> <p>или</p> <p>Клотримазол – таблетки вагинальные 100 мг или крем вагинальный 1% 1</p> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>раз в день 14 дней</p> <p>Поддерживающая терапия хронического рецидивирующего кандидоза:</p> <p>Флуконазол – внутрь 150 мг 1 раз в неделю 6 месяцев</p> <p>или</p> <p>Итраконазол – внутрь 400 мг 1 раз в месяц 6 месяцев</p> <p>или</p> <p>Клотримазол – таблетки вагинальные 100 мг или крем вагинальный 1% 1 раз в неделю 6 месяцев</p> <p>Лечение беременных: применяется только местное лечение:</p> <p>Клотримазол – таблетки вагинальные 100 мг или крем вагинальный 1% 1 раз в день 6 дней</p> |
| <b>Кандидоз других урогенитальных локализаций (B37.4): уретрит, баланит, баланопостит</b> | <p>Физикальный осмотр</p> <p>Исследование крови на антитела к T.pallidum</p> <p>ИФА-ВИЧ</p> <p>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых</p> <p>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на N.gonorrhoeae</p> <p>Микроскопическое исследование нативного мазка отделяемого мочеполовых органов</p> | <p>Флуконазол – внутрь 150 мг однократно и/или</p> <p>Местное лечение (по выбору): кремы, мази, содержащие клотримазол, кетоконазол, 2% миконазол, 1% бифоназол, натамицин; 2% раствор йода спиртовой (на очаги поражения кожи); при наличии мокнущих, везикулярных, выраженных воспалительных явлений – примочки с борной кислотой и танином, 0,05% калия перманганатом, 2% раствором протаргола, обработка растворами анилиновых красителей (1% раствор метиленового синего, раствор Кастеллани)</p>    |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль излеченности</b> | <p>Не требуется.</p> <p>Инфекция считается излеченной, если у пациентки нет клинических проявлений</p> |
| <b>Лечение партнера</b>      | Только в том случае, если у партнера имеется кандидозный баланит/баланопостит                          |
| <b>Выявление контактов</b>   | Не требуется                                                                                           |
| <b>Регистрация</b>           | Не требуется                                                                                           |

## 12.9. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ

Бактериальный вагиноз - это клиническое состояние, при котором нормальная вагинальная микрофлора, состоящая из лактобацилл, замещается анаэробными бактериями, такими как *Bacteroides*, *Mobiluncus*, *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis* и анаэробные кокки. Причина этого экологического изменения микрофлоры влагалища полностью не изучена.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Инфекционный агент</b>        | Состояние вызывается изменением вагинальной флоры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Передача</b>                  | Бактериальный вагиноз не передается половым путем, хотя имеется статистическая корреляция частоты его возникновения с половой активностью и числом половых партнеров                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Клинические проявления</b>    | Выделения жидкие гомогенные серовато-белые, имеющие неприятный "рыбный запах". Примерно у 50% женщин протекает бессимптомно.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Осложнения</b>                | Возможно развитие эндометрита, сальпингита, особенно после инвазивных гинекологических процедур                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Взятие образцов</b>           | С передней или боковой стенки влагалища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Диагностика:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>микроскопия</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствие лактобацилл и</li><li>• наличие "ключевых" клеток</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>критерий Amsel</b>            | <b>Для подтверждения диагноза обязательно присутствие трех из четырех критериев:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• серые гомогенные выделения</li><li>• pH влагалищного отделяемого более 4,5</li><li>• наличие "ключевых" клеток</li><li>• положительный аминный тест (появление "рыбного запаха" при добавлении к капле влагалищных выделений 10% раствора KOH)</li></ul> |
| <b>культуральная диагностика</b> | не проводится, так как одного определенного возбудителя нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10                                | Минимальный объем диагностических исследований                                                                                                                                                                               | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Другие невоспалительные болезни влагалища (N 89.8): Бактериальный вагиноз</b> | Физикальный осмотр<br>Исследование крови на антитела к <i>T.pallidum</i><br>Микроскопическое исследование отделяемого мочеполювых<br>Бактериологическое исследование отделяемого мочеполювых органов на <i>N.gonorrhoeae</i> | Метронидазол – внутрь 500 мг 2 раза в день 7 дней<br>или<br>Орнидазол внутрь 500 мг 2 раза в день 5 дней<br><br>Лечение беременных:<br>Метронидазол (со второго триместра) внутрь 500 мг |

|  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Микроскопическое исследование нативного мазка отделяемого мочеполовых органов<br>Определение уровня pH отделяемого влагалища<br>Аминный тест | 3 раза в сутки 7 дней<br>или<br>Клиндамицин интравагинально 5 г (разовая доза) 2% крема вводится с помощью прилагаемого аппликатора 1 раз в сутки перед сном в течение 3 дней<br>или<br>Орнидазол (со второй половины беременности) внутрь 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней<br>или<br>Тержинан интравагинально 1 таб. перед сном 10 дней |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

В первой половине беременности проводится исключительно местная терапия. Системная терапия противопоказана !

После завершения терапии одним из выше перечисленных препаратов показано лечение, направленное на нормализацию микробиоценоза влагалища и повышения местного иммунитета с помощью эубиотиков (бифидум-бактерин, ацилакт, глицирризиновая кислота).

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль излеченности</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не требуется.</li> <li>• Бактериальный вагиноз считается излеченным, когда исчезают клинические проявления.</li> </ul> |
| <b>Выявление контактов</b>   | Не требуется                                                                                                                                                    |
| <b>Лечение партнера</b>      | Не требуется                                                                                                                                                    |
| <b>Регистрация</b>           | Проводится по месту выявления больной                                                                                                                           |

## 12.10. БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

ВИЧ- инфекция может проявляться широким спектром последовательно развивающихся этапов клинического течения: от первичной инфекции, латентной (бессимптомной) инфекции до стадии развернутых клинических проявлений - СПИДа.

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Возбудитель</b>          | Вирус иммунодефицита человека из семейства ретровирусов (ВИЧ-1 или, значительно реже, ВИЧ-2)                                                                                       |
| <b>Пути передачи</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гемоконтактный, трансфузионный</li> <li>• Половой</li> <li>• Вертикальный - внутриутробно, в родах, при грудном вскармливании.</li> </ul> |
| <b>Инкубационный период</b> | Острая (первичная) ВИЧ инфекция может развиваться в период от 2-4 недель до 5-6 месяцев после заражения                                                                            |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Опасность инфицирования при разовом незащищенном половом контакте</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При незащищенных вагинальном и анальном контакте риск от 0,1 до 10%</li> <li>• При наличии других ИППП риск повышается во много раз</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Клиническая картина</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Острая ретровирусная инфекция проявляется у половины больных: фарингит, лихорадка, утомляемость, головная боль, кожная сыпь, потливость, увеличение лимфатических узлов, диарея, миалгии и артралгии</li> <li>• Бессимптомная инфекция в течение многих лет</li> <li>• Персистирующая генерализованная лимфоаденопатия (ПГЛ)</li> <li>• СПИД: развитие неврологических поражений, оппортунистических инфекций, опухолей и иммунопатологических феноменов вследствие иммунодефицита</li> <li>• Клинические маркеры СПИД (поражение кожи и слизистых оболочек): саркома Капоши, распространенный кандидоз (орофарингеальный, ороэзофагальный, аногенитальный), себорейный дерматит, вирусные дерматозы (простой и опоясывающий лишай, "волосатая лейкоплакия" языка, ромбовидный глоссит, контагиозный моллюск и вульгарные бородавки). Данные заболевания возникают в необычных возрастных группах, имеют тяжелое течение, проявляются атипично, плохо поддаются терапии.</li> </ul> |
| <b>Длительность заразного периода</b>                                    | Пожизненно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Взятие пробы</b>                                                      | Раздел 13.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Лабораторная диагностика</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Скрининговые методы:</b> обнаружение антител к ВИЧ методом ИФА.<br/>У большинства инфицированных лиц сероконверсия происходит в течение 6-8 недель.</li> <li>• <b>Чтобы надежно исключить ВИЧ инфекцию,</b> образцы крови следует брать каждые три месяца после возникшего подозрения на инфекцию.</li> <li>• <b>Ложноположительные результаты</b> могут возникать при любых скрининговых тестах.</li> <li>• <b>Все положительные результаты серологического исследования должны быть подтверждены</b></li> <li>• <b>Подтверждающие методы:</b> иммуноблот, PCR, RT-PCR</li> <li>• <b>С пациентами, имеющими положительный ответ,</b> обязательно проведение послетестового консультирования врачом. Обратитесь за помощью к врачу-инфекционисту или в отдел по профилактике СПИД регионального центра гигиены и эпидемиологии.</li> </ul>                                                                                                                                       |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лечение</b>                                | <b>Пациента с подозрением на первичную ВИЧ инфекцию следует немедленно направить к инфекционисту.</b><br>• Все ВИЧ-позитивные лица направляются в специализированную клинику/центр для обследования, лечения и последующего наблюдения |
| <b>Защита партнера с помощью презерватива</b> | Эффективна, если презерватив целый и им пользуются в течение всего полового контакта.                                                                                                                                                  |
| <b>Необходимость сообщения</b>                | Регистрация обязательна                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Выявление контактов</b>                    | В обязательном порядке                                                                                                                                                                                                                 |

### 12.11. ПАРАЗИТАРНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Пациенты с чесоткой и лобковыми вшами обычно приходят на прием из-за раздражения и зуда кожи. Реже пациенты сами замечают лобковую вошь и/или ее яйца в зоне роста волос на половых органах.

#### ЧЕСОТКА

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Инфекционный агент</b>   | <i>Sarcoptes scabiei</i> , var. <i>hominis</i> . Клещ-самка имеет размер около 0,4 мм.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Путь заражения</b>       | Телесный контакт, контактно-бытовой                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Инкубационный период</b> | До 1,5 месяцев.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Симптомы</b>             | Зуд, обычно усиливающийся в ночное время суток.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Анамнез</b>              | Важен для диагностики. Обратите внимание на наличие кожного зуда у партнера, членов семьи, других тесных бытовых контактов.                                                                                                                                                                |
| <b>Клиническая картина</b>  | Парные папулезные и папуло-пузырьковые элементы; редкий, но характерный (патогномоничный) признак - чесоточные ходы.<br>Локализация: различная - межпальцевые складки кистей, сгибательные поверхности конечностей, генитальная и ягодичные области, живот и боковые поверхности туловища. |
| <b>Диагностика</b>          | Исследование соскоба с поверхности кожи на наличие клеща при световой микроскопии (см. раздел 13.10)                                                                                                                                                                                       |

#### АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Лечение чесотки проводится в специализированных организациях здравоохранения дерматовенерологического профиля.

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10 | Минимальный объем диагностических исследований | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Чесотка (B86)</b>                              | Визуальный осмотр                              | <p>Бензилбензоат (эмульсию или мазь применяют наружно) согласно следующему алгоритму: 1-й день - вымыться под душем теплой водой с мылом, вытереться полотенцем; 200 мл 20% эмульсии или мази бензилбензоата (для детей 10%) тщательно рукой втереть в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы, исключая лицо и волосистую часть головы. Руки после обработки не мыть в течение 3 часов, в последующем втирать препарат в кожу кистей после каждого их мытья. На смазанную кожу надеть чистое нательное белье, сменить постельное белье. 2-й и 3-й дни – не мазаться, не мыться, не менять нательное и постельное белье. 4-й день - вечером принять душ, вымыться с мылом, вытереться полотенцем, обработку повторить, на смазанную кожу надеть чистое постельное белье, сменить постельное белье. 5-й день - смыть остатки препарата теплой водой с мылом без растирания кожи, сменить нательное и постельное белье.</p> <p>Или серная мазь простая (33%), для женщин – 20%, для детей 10-15%. Применяют наружно согласно следующему алгоритму: 1-й день - вымыться под душем теплой водой с мылом, вытереться полотенцем, втереть мазь в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. Руки после обработки не мыть в течение 3 часов, в последующем втирать препарат в кожу кистей после каждого их мытья, сменить нательное и постельное белье.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2-5-й дни - ежедневно 1 раз в день втирают мазь в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы, исключая лицо и волосистую часть головы.</p> <p>6-й день: смыть под душем с мылом остатки препарата, сменить нательное и постельное белье.</p> <p>или</p> <p>аэрозоль, содержащий эсдепалетрин и пиперонила бутоксид (СПРЕГАЛЬ). Применяют наружно согласно следующему алгоритму: вымыться под душем теплой водой с мылом, вытереться полотенцем, аэрозоль нанести на все тело, за исключением лица и головы, опрыскивая кожу с расстояния 20-30 см от ее поверхности в направлении сверху вниз, сменить нательное и постельное белье. Утром не мыться, не менять белье, вечером следующего дня принять душ, сменить нательное и постельное белье (не рекомендуется для беременных и кормящих женщин или детей моложе 2 лет).</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>ВНИМАНИЕ!</b> Обязательна дезинфекция одежды, постельных принадлежностей!                                                 |
| <b>Выявление контактов</b> | Необходимо обследование и профилактическое лечение половых партнеров и лиц, находившихся в тесном бытовом контакте с больным |
| <b>Регистрация</b>         | В КВД направляется Извещение по форме №089/у                                                                                 |

### ФТИРИАЗ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Инфекционный агент</b>   | Phthirus pubis. Лобковая вошь имеет длину около 1,2 мм.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Путь заражения</b>       | Телесный контакт                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Инкубационный период</b> | Зуд и раздражение возникают через 2-3 недели после заражения                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Анамнез</b>              | Важен для диагностики. Обратите внимание на наличие кожного зуда у партнера                                                                                                                                                                                             |
| <b>Диагностика</b>          | Вши и яйца могут быть видны без увеличения или с помощью увеличительного стекла. Может происходить распространение вшей на другие волосистые части тела: ноги, грудь, брови, ресницы (особенно у детей). Типичны мелкие голубовато-серые пятна на коже в местах укусов. |

## АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

| Нозологическая форма заболевания и шифр по МКБ-10 | Минимальный объем диагностических исследований                                                                                                 | Лечение и препараты выбора                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фтириаз (B85.3)</b>                            | Визуальный осмотр                                                                                                                              | Инсектициды растительного происхождения: перметрин в форме шампуня для мытья головы или концентрата 5% для приготовления эмульсии для наружного применения, или лосьона 0,5% для наружного применения, или геля 0,5%. |
|                                                   | <b>Не рекомендуется для беременных и кормящих женщин или детей моложе 2 лет</b><br>Обязательна дезинфекция одежды, постельных принадлежностей. |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Выявление контактов</b>                        | Необходимо обследование и лечение половых партнеров и лиц, находившихся в тесном бытовом контакте с больным                                    |                                                                                                                                                                                                                       |

# ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

## 13.1. ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРЯМОЙ МИКРОСКОПИИ

Материал из уретры у мужчин:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1.1. Для окраски метиленовой синью (МС)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• используйте инокуляционную петлю в 1 мкл.</li><li>• введите петлю на 2-3 см в уретру и возьмите материал движением петли к отверстию уретры.</li><li>• поместите полученный материал на предметное стекло, нажав на него петлей.</li><li>• подсушите материал на воздухе или над пламенем горелки и окрасьте МС в течение 10-30 сек.</li><li>• избыток МС смойте водой из-под крана.</li><li>• просмотрите мазок при увеличении микроскопа x100.</li><li>• при обнаружении повышенного количества лейкоцитов используйте увеличение x1000.</li><li>• обратите внимание на наличие полиморфноядерных лейкоцитов.</li><li>• проведите оценку препарата согласно описанию в разделе 3.</li><li>• исследуйте материал на наличие диплококков.</li><li>• зафиксируйте результаты в амбулаторной карте/истории болезни и протоколе осмотра.</li></ul> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Материал для исследования у женщин:

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1.2. Из влагалища для приготовления нативного влажного мазка - (ВМ)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• используйте инокуляционную петлю в 10 мкл.</li><li>• материал возьмите с боковой или передней стенки влагалища.</li><li>• смешайте полученный материал на предметном стекле с каплей физиологического 0,9% раствора.</li><li>• накройте суспензию покровным стеклом</li><li>• просмотрите при увеличении x100, а затем x400.</li><li>• обратите внимание на полиморфноядерные лейкоциты, дрожжеподобные грибы, трихомонады, ключевые клетки, лактобациллы.</li><li>• зафиксируйте свои результаты в амбулаторной карте/истории болезни и протоколе осмотра.</li></ul> |
| <b>5.1.3. Из цервикального канала для окраски МС</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• используйте ватный тампон, предварительно удалив слизь из области наружного зева.</li><li>• введите тампон на 1-2 см в цервикальный канал и поворачивайте его несколько раз.</li><li>• прокатайте извлеченный тампон по поверхности предметного стекла.</li><li>• высушите мазок на воздухе или над пламенем горелки и окрасьте МС в течение 10-30 сек.</li><li>• избыток МС смойте проточной водой.</li><li>• исследование проводится при увеличении микроскопа x100, а затем x1000.</li></ul>                                                                       |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• обратите внимание на наличие полиморфноядерных лейкоцитов и диплококков. Оцените картину мазка согласно описанию в разделе 3.</li> <li>• зафиксируйте результаты в амбулаторной карте/истории болезни и протоколе осмотра.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.1.4. Из уретры для окрашивания метиленовой синью</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• используйте инокуляционную петлю в 1 мкл.</li> <li>• введите петлю на 2-3 см в уретру и соберите материал движением петли к отверстию уретры.</li> <li>• поместите полученный материал на предметное стекло.</li> <li>• высушите мазок на воздухе или над пламенем горелки и в течение 10-30 сек окрасьте МС.</li> <li>• избыток МС смойте проточной водой.</li> <li>• исследуйте материал на наличие полиморфноядерных лейкоцитов и диплококков. Применяйте увеличение микроскопа x100, и при обнаружении повышенного количества лейкоцитов, то используйте увеличение x1000.</li> <li>• оцените картину мазка согласно описанию в разделе 3.</li> <li>• зафиксируйте результаты в амбулаторной карте/истории болезни и протоколе осмотра.</li> </ul> |

### 13.2. ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Культуральное исследование</b> | <p><b>Информацию об оптимальном взятии и транспортировке проб получите в своей лаборатории.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• используйте специально предназначенные тампоны</li> <li>• существуют разные тампоны для цервикального канала и уретры.</li> <li>• для транспортировки пользуйтесь транспортным буфером, налитым в специальные пробирки.</li> <li>• пробирки и среды, не предназначенные для транспортировки хламидийных образцов, могут быть токсичными для клеток, что приводит к ложноотрицательному результату исследования.</li> <li>• буфер может храниться при комнатной температуре 1 день, в холодильнике при 4°C четыре недели и в морозильной камере (-20°C) 4 месяца.</li> <li>• для надежности исследования пробирки с транспортной средой и тампоны запрашивайте из той лаборатории, которая будет проводить культуральное исследование.</li> </ul> |
| <b>ПИФ</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• используйте дакроновый тампон или специальную щеточку. Используйте специальные стекла для иммунофлюоресценции с лункой в середине стекла для качественного окрашивания препарата.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ! При нанесении материала тампоны должны прокатываться, а не растираться по стеклу.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ИФА и ПЦР</b>                  | Тампоны и специальные транспортные пробирки поставляются производителями наборов и доставляются из лаборатории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Взятие мочи у мужчин</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наилучшие результаты дает первая порция свободно выпущенной утренней мочи.</li> <li>• Обычно берется 5-10 мл мочи в специальную стерильную посуду.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Исследование мочи у женщин</b> | Не рекомендуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Уретра</b>                     | Введите уретральный тампон на 1,5-2 см в уретру женщины и на 3-4 см в уретру мужчины. Осторожно вращайте тампон в уретре в течение 5-10 сек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Цервикальный канал</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал берется при исследовании в зеркалах.</li> <li>• Для взятия соскоба из цервикального канала очистите наружную часть шейки матки, пользуясь пинцетом с марлей или большим ватным тампоном, чтобы удалить наружные выделения.</li> <li>• Затем введите тампон для взятия образца на 2 см в цервикальный канал и вращайте его в течение 10 сек, осторожно получая соскоб эпителиальных клеток.</li> <li>• Выньте тампон, не касаясь поверхностей вагинальной стенки.</li> </ul> |
| <b>Влагалище</b>                  | Специальный вагинальный тампон, введенный во влагалище, проворачивается несколько раз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Конъюнктив</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Процедура иногда бывает болезненной, поэтому можно применять местные анестетики.</li> <li>• Приподнимите, а лучше выверните веко.</li> <li>• Соберите эпителиальные клетки, протерев слизистую тампоном (можно использовать уретральный тампон) нижнего, а затем верхнего века.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Прямая кишка</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проба берется при помощи ректоскопа.</li> <li>• Перед взятием материала очистите слизистую прямой кишки, пользуясь ватным тампоном.</li> <li>• Возьмите материал, используя цервикальный или уретральный тампон.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Носоглотка</b>                 | При пневмонии у новорожденного введите тампон через носовые ходы до стенки глотки (лучшими образцами являются трахеобронхиальные аспираты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Гортань</b>                    | Тампоном (уретральным) возьмите образец из углублений в миндалинах (тонзиллярные крипты) и с задней стенки глотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Транспортировка:</b>           | Перед взятием материала ВСЕГДА проконсультируйтесь с вашей лабораторией. Обычно с собранными образцами поступают следующим образом:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>- для клеточной культуры</b>   | Сохранять в холодильнике при 4-6 С° и в течение 24 часов доставить в лабораторию, обложив пробу льдом. Исследование требует сохранения живых хламидий, и изменение температуры при транспортировке может быть решающими для получения достоверного результата.                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- для ПЦР</b> | Образцы с тампонами могут храниться максимально в течение 3-х дней до отправки в лабораторию при С, а образцы мочи должны быть доставлены в лабораторию не позднее 24 ч после сбора. При необходимости эти образцы могут храниться в течение месяца при С. |
| <b>- для ИФА</b> | Образцы должны быть доставлены в лабораторию в течение 48 часов и транспортироваться на холоде. Перед транспортировкой хранить при С. Образцы нельзя замораживать до исследования, иначе чувствительность теста снизится.                                  |
| <b>- для ПИФ</b> | Препарат должен быть доставлен в лабораторию в тот же день. В случае необходимости фиксированные в течение 1-2 минут холодным ацетоном препараты можно хранить при С в течение 3 дней, при С - в течение 1 месяца.                                         |

#### ВЫДАЧА ОТВЕТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Культуральная диагностика</b> | <p>Ответ выдается через 5-7 дней.</p> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Культуральным методом выделены <i>C. trachomatis</i></li> <li>2. Культуральным методом <i>C. trachomatis</i> не выделены</li> <li>3. Исследование повторить из-за цитопатического действия. (Этот вариант ответа может быть получен уже на 2-й день).</li> </ol> |
| <b>ИФА</b>                       | <p>Ответ выдается через 1-3 дня.</p> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методом ИФА обнаружены <i>C. trachomatis</i></li> <li>2. Методом ИФА <i>C. trachomatis</i> не обнаружены.</li> </ol>                                                                                                                                              |
| <b>ПЦР</b>                       | <p>Ответ выдается через 1-3 дня.</p> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методом ПЦР обнаружены <i>C. trachomatis</i></li> <li>2. Методом ПЦР <i>C. trachomatis</i> не обнаружены.</li> </ol>                                                                                                                                              |
| <b>ПИФ</b>                       | <p>Обычно ответ выдается через 2 дня.</p> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методом ПИФ обнаружены <i>C. trachomatis</i>.</li> <li>2. Методом ПИФ <i>C. trachomatis</i> не обнаружены.</li> <li>3. Рекомендуются исследование повторить (из-за отсутствия клеток в препарате или неспецифической флюоресценции).</li> </ol>              |

### 13.3. ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Техника взятия материала</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для взятия материала используются хлопковые или дакроновые тампоны, специальные щеточки, ложечки Фолькмана.</li> <li>• Пациента следует предупредить, чтобы он не мочился в течение 3 часов до взятия материала.</li> <li>• Места взятия образцов зависят от пола, возраста и сексуальной практики пациента, а также от клинических проявлений инфекции.</li> <li>• <b>У женщин</b> материал берется чаще из цервикального канала, уретры, реже из влагалища, прямой кишки и ротоглотки.</li> <li>• <b>У мужчин</b> - из уретры, прямой кишки, ротоглотки.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Посев на специальную питательную среду для выделения гонококков должен проводиться в момент взятия материала.</p> |
| <b>Цервикальный канал</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед взятием образцов следует избегать применения антисептиков, анальгетиков и мазей, т.к. они могут подавить гонококки, имеющиеся в цервикальном канале.</li> <li>• Материал берется при исследовании в зеркалах.</li> <li>• Очистите наружный зев при помощи марли или ватного шарика для удаления слизи.</li> <li>• Инструмент вводится на глубину 1-2 см в цервикальный канал и берется соскоб эпителия или отделяемое.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Уретра</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистите область наружного отверстия мочеиспускательного канала с помощью марлевого тампона или шарика.</li> <li>• <b>У мужчин:</b> при отсутствии явных выделений, слегка помассируйте уретру в направлении к наружному отверстию, чтобы получить экссудат. Если экссудат не получен, введите уретральный тампон на 1-2 см, осторожно поворачивайте и дайте тампону побыть в уретре в течение 5-10 сек.</li> <li>• <b>У женщин:</b> при отсутствии явных выделений помассируйте уретру, прижимая ее к лонному сочленению, и используйте ту же технику, что и для мужчин.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>Прямая кишка</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Введите ватный тампон на 3 см в прямую кишку и вращайте его в течение 10 сек, чтобы взять экссудат из крипт прямо внутри анального кольца.</li> <li>• Если происходит фекальное загрязнение, выбросьте тампон и возьмите другой для получения пробы.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Конъюнктура</b>              | <p>Проведите тампоном по внутренней поверхности конъюнктивы нижнего века</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Влагалище</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вагинальные пробы следует брать у женщин, перенесших экстирпацию матки и у девочек (virgo)</li> <li>• У девочек материал берется тампоном из преддверия влагалища</li> <li>• У женщин материал берется при осмотре в зеркалах с передней или боковой стенки</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ротоглотка</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал возьмите тампоном из тонзиллярных крипт и задней стенки глотки</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Предстательная железа</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пациент должен помочиться перед взятием образца</li> <li>• Проведите ректальный массаж предстательной железы от периферии к центру</li> <li>• Соберите на тампон экссудат из отверстия уретры</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Транспортировка</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Образцы следует направлять в лабораторию как можно быстрее (сразу после посева).</li> <li>• Материал необходимо транспортировать в лабораторию при температуре не ниже 18°C.</li> <li>• При нарушении правил транспортировки вероятность выделения гонококков резко снижается.</li> </ul>   |
| <b>ВЫДАЧА ОТВЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>    | <p>Ответ по результатам посева выдается через 2-3 дня после взятия пробы. Культивирование материала из ротоглотки может проходить на один день дольше.</p> <p>Варианты ответа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Neisseria gonorrhoeae</i> выделены.</li> <li>2. <i>Neisseria gonorrhoeae</i> не выделены.</li> </ol> |
| <b>Ответ при окраске по Граму</b>    | <p>Варианты ответа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Грам-положительные диплококки обнаружены</li> <li>2. Грам-положительные диплококки не обнаружены</li> </ol>                                                                                                                                                        |
| <b>Оформление бланка направления</b> | <p>В направлении указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• место(а) взятия материала,</li> <li>• время взятия,</li> <li>• предполагаемый диагноз и</li> <li>• необходимость определения антибиотикочувствительности</li> </ul>                                                                                       |

#### 13.4. ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Техника взятия материала:</b> | Для получения надежных результатов требуется большое количество материала, содержащего эпителиальные клетки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ПИФ</b>                       | <p>Для получения надежных результатов требуется большое количество материала, содержащего эпителиальные клетки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Берется содержимое пузырьков или мазок-отпечаток с поверхности эрозии.</li> <li>• Вскройте пузырек иглой и аспирируйте жидкость шприцем.</li> <li>• Обезжиренным предметным стеклом сделайте мазок-отпечаток с поверхности эрозии.</li> <li>• Материал следует брать в таком количестве, чтобы его было достаточно для двух стекол, предпочтительно иметь по 2-3 мазка на стекле.</li> <li>• Высушите материал на воздухе, прежде, чем направлять в лабораторию.</li> </ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Культуральная диагностика ПЦР</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальным уретральным тампоном возьмите жидкость из пузырьков или эпителиальные клетки с поверхности эрозии и поместите материал в пробирку с транспортной средой.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Транспортировка</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал для исследования следует доставлять в лабораторию как можно быстрее, предпочтительно, в течение первых 4 часов после взятия. В ожидании транспортировки образцы должны храниться в холодильнике при 4-6° С.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ВЫДАЧА ОТВЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>    | <p><b>ПИФ:</b><br/> <b>Обычно ответ выдается через 2 дня.</b><br/>         Варианты ответов -<br/>         1. Методом ПИФ обнаружены HSV 1/2 типа.<br/>         2. Методом ПИФ HSV не обнаружены.</p> <p><b>Культуральная диагностика:</b><br/> <b>Обычно ответ выдается через 3-4 дня.</b><br/>         Варианты ответов -<br/>         1. Культуральным методом выделены HSV.<br/>         2. Культуральным методом HSV не выделены.</p> <p><b>ПЦР:</b><br/> <b>Обычно ответ выдается через 1-3 дня.</b><br/>         Варианты ответов -<br/>         1. Методом ПЦР HSV обнаружены<br/>         2. Методом ПЦР HSV не обнаружены.</p> |

### 13.5. ВЗЯТИЕ ПРОБ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА

**Темнопольная микроскопия для обнаружения бледной трепонемы - обязательное исследование при диагностике заразных форм сифилиса (первичный, вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек).**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Техника взятия материала (тканевого отделяемого) для темнопольной микроскопии</b> | <p>ость из высыпаний первичного или вторичного сифилиса, которые сопровождаются мацерацией, эрозированием или изъязвлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхность эрозии или язвы осторожно, чтобы не вызвать кровотечение, очистите от загрязнения ватным тампоном, смоченным изотоническим раствором хлорида натрия.</li> <li>• Затем промокните поверхность сухим тампоном.</li> <li>• <b>Для получения отделяемого</b> на поверхности эрозии чаще пользуются методом отсоса. Для этого используйте стеклянные трубочки, соединенные с резиновой грушей.</li> <li>• Возьмите отделяемое петлей или капиллярным концом пастеровской пипетки и перенесите на поверхность предметного стекла (при недостаточном количестве, материал смешивается с каплей изотонического раствора хлорида натрия).</li> <li>• Для исследования необходимо получить тканевую жидк</li> <li>• Каплю отделяемого накройте покровным стеклом и исследуйте нативный препарат (раздавленная капля)</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>с использованием микроскопа (объектив х40) и специальным конденсором темного поля. Предварительно между линзой конденсора и нижней поверхностью предметного стекла нанесите каплю иммерсионного масла.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Для исследования на наличие возбудителя</b> может быть также использована жидкость, полученная при пункции регионарного лимфатического узла.</li> <li>• <b>К пункции лимфатического узла</b> прибегают лишь в том случае, когда шанкр недоступен исследованию (фимоз, внутриуретральный шанкр), или если не удастся найти трепонему вследствие самолечения.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Техника взятия материала (крови) для серологического исследования</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• На плечо выше локтевого сгиба наложить резиновый жгут, чтобы сдавить вены, но не нарушить притока крови по артериям; пульс должен хорошо прощупываться. Больному предлагается несколько раз сжать и разжать кулак, что способствует лучшему наполнению вены.</li> <li>• Дважды обработать кожу в проксимальном направлении по ходу вены спиртовой салфеткой или ватным шариком, смоченным этиловым спиртом, пальцами левой руки зафиксировать вену.</li> <li>• Шприцем одноразового использования проколоть кожу и стенку вены. Произвести забор крови (не менее 5 мл), снять жгут, прижать к месту прокола кожи ватный шарик с этиловым спиртом, поместить пробу крови в сухую чистую помеченную пробирку, закрыв ее ватной пробкой.</li> <li>• При постановке реакции микропреципитации возможно взятие крови из пальца. Перед взятием крови в центрифужную пробирку внести 5% раствор цитрата натрия, взятого капилляром аппарата Панченкова до метки «50». Далее тем же капилляром набрать кровь дважды до метки «0» и внести в ту же пробирку, перемешивая с раствором цитрата натрия.</li> </ul> |
| <b>Транспортировка</b>                                                   | Пробирки с кровью осторожно транспортируются в специальном закрытом контейнере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



### 13.6. ВЗЯТИЕ ПРОБ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ГЕПАТИТОВ

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Техника взятия материала (крови) для серологического исследования</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Больной сидит или лежит. Его рука должна быть максимально разогнута в локтевом суставе, под локтевой сгиб подложить плотную клеенчатую подушку.</li> <li>• На плечо выше локтевого сгиба наложить резиновый жгут, чтобы сдавить вены, но не нарушить притока крови по артериям; пульс должен хорошо прощупываться. Больному предлагается несколько раз сжать и разжать кулак, что способствует лучшему наполнению вены.</li> <li>• Дважды обработать кожу в проксимальном направлении по ходу вены спиртовой салфеткой или ватным шариком, смоченным этиловым спиртом, пальцами левой руки зафиксировать вену.</li> <li>• Приготовленным шприцем одноразового использования проколоть кожу и стенку вены. Произвести забор крови в шприц (не менее 5 мл для одного исследования), снять жгут, прижать к месту прокола кожи ватный шарик с этиловым спиртом, поместить каждую пробу крови в сухую чистую промаркированную пробирку, закрыв пробкой.</li> </ul> |
| <b>Транспортировка</b>                                                   | Пробирки с кровью осторожно транспортируются в специальном закрытом контейнере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 13.7 ВЗЯТИЕ ПРОБ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРИХОМОНИАЗА

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уретра мужчин</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• используйте инокуляционную петлю в 1 мкл.</li> <li>• введите петлю на 2-3 см в уретру, движением петли к отверстию уретры соберите материал и поместите на два предметных стекла, смешайте с каплей 0,9% физиологического раствора.</li> <li>• одно стекло оставьте для высыхания на воздухе, на втором накройте каплю покровным стеклом.</li> <li>• микроскопию производите при увеличении x100, затем на x400</li> <li>• высушенный мазок окрасьте метиленовой синью в течение 30 с, промойте водой и высушите. См. раздел 13.1</li> </ul> |
| <b>Влагалище</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• на стекло добавьте каплю 0,9% физиологического раствора</li> <li>• инокуляционной петлей в 10 мкл возьмите выделения с передней и боковой стенок влагалища, смешайте с физраствором на предметном стекле</li> <li>• накройте покровным стеклом. См. раздел 13.1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Микроскопическая диагностика нативного влажного мазка</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• используйте увеличение микроскопа x100, затем x400.</li> <li>• трихомонады в нативном препарате видны как грушевидные подвижные клетки, при увеличении x400 иногда видны жгутики трихомонад.</li> <li>• большое количество полиморфноядерных лейкоцитов (более 10 в поле зрения при увеличении x100).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Культуральная диагностика</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отделяемое уретры или влагалища внесите в пробирки, содержащие специальную среду.</li> <li>• перед посевом среда должна быть согрета.</li> <li>• инкубация посевов при + 35-37°C 24-72 часа.</li> <li>• каждые 24 часа из пробирок отбирайте по 1 капле содержимого, готовьте нативный и окрашенный препараты и микроскопируйте при увеличении x100.</li> <li>• трихомонады видны как подвижные грушевидные клетки в нативном препарате.</li> <li>• в окрашенном препарате у трихомонад различаются ядро и протоплазма.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Посев на специальную среду для выделения трихомонад должен проводиться в момент взятия материала.</p> |
| <b>Транспортировка</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для культуральной диагностики образцы должны направляться в лабораторию как можно быстрее (сразу после посева).</li> <li>• Материал необходимо транспортировать в лабораторию при температуре не ниже 18°C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ВЫДАЧА ОТВЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b><br><b>Прямая микроскопия</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При проведении прямой микроскопии нативных влажных мазков ответ выдается сразу.</li> <li>• При микроскопии препаратов, окрашенных МС, ответ выдается через 1 день.</li> </ul> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методом прямой микроскопии обнаружены <i>Trichomonas vaginalis</i>.</li> <li>2. Методом микроскопии окрашенных метиленовой синью мазков обнаружены <i>Trichomonas vaginalis</i>.</li> <li>3. Методом микроскопии <i>Trichomonas vaginalis</i> не обнаружены.</li> </ol>                                                                                                                                     |
| <b>Культуральная диагностика</b>                               | <p>Ответ выдается через 24-72 часа.</p> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Культуральным методом выделены <i>Trichomonas vaginalis</i>.</li> <li>2. Культуральным методом <i>Trichomonas vaginalis</i> не выделены.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ВНИМАНИЕ!</b>                                               | <p>Для получения достоверного ответа при исследовании мужской уретры микроскопический метод не всегда успешен. Рекомендуется проводить культуральную диагностику.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 13.8 ВЗЯТИЕ ПРОБ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО КАНДИДОЗА

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВЛАГАЛИЩЕ</b>                                     | <p>Вагинальным тампоном или инокуляционной петлей в 10 мкл возьмите отделяемое из влагалищного свода и боковой стенки влагалища.</p> <p>Приготовьте нативный влажный препарат, используя 0,9% физиологический раствор или 10%-ный раствор КОН. Накройте суспензию покровным стеклом и просматривайте в световом микроскопе. На втором стекле приготовьте препарат для окраски метиленовой синью. См. раздел 19.1</p> <p>Для культуральной диагностики материал помещается в специальную транспортную среду.</p> |
| <b>Прямая микроскопия - нативного влажного мазка</b> | Используйте увеличение микроскопа x100, а затем 400. При просмотре нативных влажных препаратов обратите внимание на наличие полиморфноядерных лейкоцитов и дрожжеподобных грибов (псевдогифов и дрожжевых клеток).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>- мазка, окрашенного метиленовой синью</b>        | Исследование проводится при увеличении микроскопа x100, а затем x1000. Обратите внимание на наличие полиморфноядерных лейкоцитов, лактобацилл и дрожжеподобных грибов (гифы и дрожжевые клетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Культуральная диагностика</b>                     | <p>Взятое тампоном или инокуляционной петлей в 10 мкл отделяемое влагалища помещается на специальные питательные среды (среда Сабуро или др. Инкубация при +35-37°C 24-72 часа - до 5 суток.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ! Для культуральной диагностики взятый материал должен быть доставлен в лабораторию как можно быстрее.</b></p>                                                                                                                                                                                   |
| <b>ВЫДАЧА ОТВЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Микроскопическая диагностика</b>                  | <p>При проведении прямой микроскопии нативного влажного препарата ответ выдается сразу. При микроскопии мазка, окрашенного метиленовой синькой, ответ выдается на следующий день.</p> <p>Варианты ответа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методом микроскопии обнаружены элементы дрожжеподобных грибов (мицелий, почкующиеся дрожжи).</li> <li>2. Методом микроскопии дрожжеподобные грибы не обнаружены.</li> </ol>                                                                             |
| <b>Культуральная диагностика</b>                     | <p>Ответ выдается через 5 дней.</p> <p>Варианты ответов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Культуральным методом выделены <i>Candida</i> spp. (<i>Candida albicans</i>, (<i>Candida krusei</i>, <i>Candida tropicalis</i> и др.).</li> <li>2. Культуральным методом дрожжеподобные грибы не выделены.</li> </ol>                                                                                                                                                                                    |

### 13.9 Взятие проб для диагностики бактериального вагиноза

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Влагалище</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• инокуляционной петлей в 10 мкл берется отделяемое передней и боковой стенок влагалища.</li><li>• Готовится нативный влажный мазок с использованием 0,9% физиологического раствора для прямой микроскопии (См. раздел 13.1.)</li></ul>                                                                                                                    |
| <b>Микроскопия - нативного влажного мазка</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Используется увеличение микроскопа x100, а затем x400.</li><li>• При просмотре нативного препарата отмечают отсутствие лактобацилл и присутствие «ключевых клеток», т.е. клетки вагинального эпителия, покрытые в несколько слоев мелкими коккобактериями, вибрионами, тонкими палочковидными бактериями.</li></ul>                                      |
| <b>- мазка, окрашенного МС</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Используется увеличение микроскопа x100, а затем x1000.</li><li>• Микроскопия фиксированных и окрашенных метиленовой синью мазков также отмечают отсутствие лактобацилл и присутствие «ключевых клеток», т.е. клетки вагинального эпителия, покрытые в несколько слоев мелкими коккобактериями, вибрионами, тонкими палочковидными бактериями.</li></ul> |
| <b>Культуральная диагностика</b>              | Культуральная диагностика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ВЫДАЧА ОТВЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>             | Ответ выдается в день исследования.<br>Варианты ответа:<br>1. В мазке обнаружены лактобациллы, «ключевых клеток» нет. Признаки бактериального вагиноза отсутствуют<br>2. В мазке обнаружены «ключевые клетки», лактобациллы отсутствуют. Признаки бактериального вагиноза.                                                                                                                       |

### 13.10 ВЗЯТИЕ ПРОБ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЧЕСОТКИ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Техника взятия материала</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Каплю 40% раствора молочной кислоты наносят на чесоточный элемент (ход, пузырек, узелок, корочку и др.).</li><li>• Через 5 минут разрыхленный эпидермис соскабливают острой глазной ложечкой до появления капиллярного кровотечения, немного захватывая и прилегающую здоровую кожу.</li><li>• Полученный материал переносят на предметное стекло в каплю молочной кислоты, накрывают покровным стеклом и сразу же исследуют под малым увеличением микроскопа (x80) при среднем положении конденсора и диафрагмы.</li><li>• Обнаруженного клеща и стадии его развития изучают при большем увеличении (x400).</li><li>• Препараты из каждого хода, папулы, везикулы и других элементов готовят отдельно.</li></ul> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕ

## СИФИЛИС

Окончательный диагноз устанавливается врачом-дерматовенерологом в специализированном медицинском учреждении дерматовенерологического профиля. Если положительная проба выявлена в другой организации здравоохранения, то врач должен заполнить и направить в региональное КВУ Извещение по форме №089/у, а больного направить для подтверждения диагноза в это же КВУ.

### Порядок действий доверенного врача:

1. Сообщить больному о диагнозе.
2. Предоставить информацию о гигиенических правилах поведения во время лечения, обязательности и сроках лечения и контрольного наблюдения, запрещении быть донором, юридической ответственности в случаях его уклонения от лечения и действий, несущих опасность заражения окружающих
3. Дать больному подписать Предупреждение лицу, заболевшему венерической болезнью
4. Собрать половой анамнез.
5. Назначить больному лечение
6. Выявление и обследование половых контактов проводится при:
  - первичном сифилисе за последние 6-8 недель;
  - вторичном за последние 6 мес.;
  - при отсутствии клинических проявлений за 2 года и более.
7. Выявление и обследование бытовых контактов больного проводится:
  - среди лиц, совместно проживающих на одной жилплощади (особое внимание уделяется детям до 3-х лет);
  - в случаях выявления сифилиса у работников декретированных профессий (ДДУ, роддома) в учреждениях обследуются все контактные с ними лица;
  - в случае выявления сифилиса у ребенка, посещающего ДДУ, обследуются дети и работники группы.
8. Провести эпид. мероприятия среди выявленных контактных лиц (санация эпид. очага):
  - осмотр и обследование контактных лиц;
  - констатация лабораторных данных;
  - решение вопроса о необходимости лечения, его объеме и сроках наблюдения.
9. При выявлении сифилиса у донора направить информацию о больном на региональную станцию переливания крови.
10. В случае проживания контактных лиц на других территориях, направить в территориальное КВУ «Поручение по розыску лица, бывшего в контакте с больным венерическим заболеванием».

## ГОНОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Окончательный диагноз устанавливается врачом дерматовенерологом в специализированном медицинском учреждении дерматовенерологического профиля. Если положительная проба выявлена в другой организации здравоохранения, то врач должен заполнить и направить в региональное КВУ Извещение по форме №089/у, а больного направить для лечения в это же КВУ.

### **Порядок действий доверенного врача:**

1. Сообщить больному о диагнозе.
2. Предоставить информацию о гигиенических правилах поведения во время лечения, обязательности и сроках лечения и контрольного наблюдения, юридической ответственности в случаях его уклонения от лечения и действий, несущих опасность заражения окружающих
3. Дать больному подписать Предупреждение лицу, заболевшему венерической болезнью
4. Собрать половой анамнез.
5. Назначить больному лечение
6. Выявление и обследование половых контактов проводится в зависимости от клинических проявлений заболевания и предполагаемого срока заражения:
  - при острых проявлениях заболевания - от 3-х дней до 3- месяцев;
  - при торпидном и малосимптомном процессе - 6 месяцев.
7. Выявление бытовых контактов больного проводится:
  - среди девочек совместно проживающих на одной жилплощади;
  - в случае выявления гонореи у ребенка (девочки), посещающего ДДУ, обследуются дети (девочки) и работники группы.
8. В случае выявления гонореи у роженицы или родильницы проводится обследование новорожденного со взятием материала для микроскопии, бак. посева из вульвы и конъюнктивальных мешков обоих глаз.
9. Проведение эпидемиологических мероприятий среди контактных лиц (санация эпид. очага) предполагает:
  - осмотр и обследование контактных лиц;
  - констатацию лабораторных данных;
  - решение вопроса о необходимости лечения, его объеме и сроках наблюдения.
10. В случае проживания контактных лиц на других территориях, направить в территориальное КВУ «Поручение по розыску лица, бывшего в контакте с больным венерическим заболеванием».

### **ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ**

Окончательный диагноз устанавливается врачом-дерматовенерологом, акушером-гинекологом, урологом.

### **Порядок действий доверенного врача:**

1. Сообщить больному о диагнозе.
2. Предоставить информацию о гигиенических правилах поведения во время лечения, опасности заражения окружающих, сроках лечения и контрольного наблюдения
3. Собрать половой анамнез.
4. Назначить больному лечение
5. Выявление и обследование половых контактов проводится в зависимости от клинических проявлений заболевания и предполагаемого срока заражения - от 15 дней до 6 месяцев.
6. Выявление обследования бытовых контактов больного проводится у лиц, совместно проживающих на одной жилплощади, при наличии симптомов уретрита, конъюнктивита, артрита.
7. В случае выявления хламидийной инфекции у роженицы, родильницы или беременной, не получившей своевременного лечения, проводится обследование новорожденного с взятием материала из конъюнктивальных мешков обоих глаз
8. Проведение эпидемиологических мероприятий среди контактных лиц (санация эпидочага) предполагает:
  - осмотр и обследование контактных лиц;
  - констатацию лабораторных данных;



- решение вопроса о необходимости лечения, его объеме и сроках наблюдения.  
9. В случае проживания контактных лиц на других территориях, направить в территориальное КВУ письмо с просьбой привлечь к обследованию лицо, бывшее в контакте с больным.

### **ТРИХОМОНИАЗ**

Окончательный диагноз устанавливается врачом дерматовенерологом, акушером-гинекологом, урологом.

#### **Порядок действий доверенного врача:**

1. Сообщить больному о диагнозе.
2. Предоставить информацию о гигиенических правилах поведения во время лечения, опасности заражения окружающих, сроках лечения и контрольного наблюдения
3. Собрать половой анамнез.
4. Назначить больному лечение
5. Выявление и обследование половых контактов проводится в зависимости от клинических проявлений заболевания и предполагаемого срока заражения - от 3-х дней до 6 месяцев.
6. Выявление и обследование бытовых контактов проводится:
  - у детей (девочек) совместно проживающих на одной жилплощади;
  - в случае выявления трихомониаза у ребенка (девочки), посещающего ДДУ, осматриваются и при необходимости обследуются дети и работники группы.
7. В случае выявления трихомониаза у роженицы или родильницы проводится обследование новорожденной девочки
8. Проведение эпидемиологических мероприятий среди контактных лиц (санация эпидемиологического очага) предполагает:
  - осмотр и обследование контактных лиц;
  - констатацию лабораторных данных;
  - решение вопроса о необходимости лечения, его объеме и сроках наблюдения.
9. В случае проживания контактных лиц на других территориях, направить в территориальное КВУ письмо с просьбой привлечь к обследованию лицо, бывшее в контакте с больным.

### **АНОГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС И АНОГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ (ВЕНЕРИЧЕСКИЕ)**

Окончательный диагноз устанавливается дерматовенерологом, акушером-гинекологом, урологом.

#### **Порядок действий доверенного врача:**

1. Сообщить больному о диагнозе.
2. Предоставить информацию о гигиенических правилах поведения во время лечения, опасности заражения окружающих, сроках лечения и контрольного наблюдения
3. Собрать половой анамнез.
4. Назначить больному лечение
5. Выявить и привлечь к обследованию половых партнеров заболевшего.
6. Проведение эпидемиологических мероприятий среди контактных лиц (санация эпидемиологического очага) предполагает:
  - осмотр и обследование контактных лиц;
  - констатацию лабораторных данных;
  - решение вопроса о необходимости лечения, его объеме и сроках наблюдения.
7. В случае проживания контактных лиц на других территориях, направить в территориальное КВУ письмо с просьбой привлечь к обследованию лицо, бывшее в контакте с больным.

## ВЫЯВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ

Выявление контактов означает изучение и получение информации, каких лиц мог инфицировать или уже инфицировал Ваш пациент, и обследование этих лиц. Лечащий врач отвечает за прослеживание контактов, но он может передать эту обязанность куратору (специально обученному для такой работы медицинскому работнику), другому врачу, мед. сестре или иному медицинскому персоналу.

Первостепенной задачей прослеживания контактов является:

- Обеспечить лечение инфицированных лиц;
- Предотвратить развитие осложнений у инфицированных лиц;
- Понизить вероятность распространения инфекции.

Очень важно, чтобы лицо, осуществляющее прослеживание контактов, могло заниматься этим спокойно, без временного давления. Прослеживание контактов часто требует много времени, и врачу, работающему в клинике, может быть трудно выполнять это. Медицинские работники, имеющие опыт в прослеживании контактов, имеют более высокие результаты, выражающиеся в количестве выявленных партнеров. Все прослеживание контактов основывается на доверительной работе с пациентом.

Для того, чтобы добиться лучшего понимания, необходимо, чтобы лицо, прослеживающее контакты, проявляло активную заинтересованность, но никогда не прибегало к порицанию. В разговоре с пациентом очень важен подбор слов. Помните, что он мог иметь половой контакт с лицом своего пола, контакты следует называть «партнером» или «тот, с кем вы занимались сексом».



# ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

## 16.1. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ИППП

При выявлении гонококков пациенты направляются в КВУ по месту жительства (прописки). При этом необходимо выполнение следующих требований:

1. Подача телефонограммы из организации здравоохранения в районный КВД (КВО, КВК) в день получения результата лабораторных исследований с сообщением следующих данных:

- наименование учреждения, выявившего больного;
- Ф.И.О. (полностью);
- возраст;
- адрес проживания и прописки;
- дата проведения лабораторного исследования;
- ФИО, должность сотрудника, передававшего телефонограмму.

Все телефонограммы, передаваемые в КВУ, фиксируются в специальном журнале ответственным лицом.

2. Отправление письма из учреждения, выявившего больного, почтой с указанием данных:

- наименование учреждения, куда адресовано письмо;
- ФИО.;
- возраст;
- адрес проживания и прописки;
- предполагаемый диагноз;
- данные проведенного лабораторного исследования;
- дата отправления документа;
- подпись (разборчивая).

3. Заполнение направления в КВУ, которое выдается на руки пациенту, с указанием адреса и телефона учреждения, в которое он должен явиться для уточнения диагноза.

4. ЛПУ, направившее больного, должно проконтролировать явку больного в КВУ телефонным звонком и получить обратный ответ из КВУ с уточненным диагнозом.

**При выявлении других ИППП: уrogenитальных трихомониаза, хламидиоза, аногенитального герпеса, аногенитальных (венерических) бородавок больные равноправно могут получать лечение как у врачей-дерматовенерологов, так и у акушеров-гинекологов и урологов.**

Все эпидмероприятия, требуемые при выявлении данных инфекций, должны выполняться доверенным врачом. На всех выявленных больных сифилисом и гонореей составляются Извещения (№089/у), которые направляются в КВУ по месту жительства больного в конце каждого месяца с цифровым отчетом. В случае выявления у больного нескольких ИППП Извещения заполняются отдельно на каждое заболевание.

## 16.2. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕ (МИКРОРЕАКЦИИ) НА СИФИЛИС

При выявлении положительной пробы (микрореакции) на сифилис пациенты направляются в КВУ по месту жительства (прописки). При этом необходимо выполнение следующих требований:

1. Отправление телефонограммы в территориальный КВД (КВО, КВК) из орга-

низации здравоохранения в день получения результата с сообщением следующих данных :

- наименование учреждения, выявившего больного;
- Ф.И.О. (полностью);
- возраст;
- адрес проживания и прописки;
- дата положительной пробы (микрореакции);
- Ф.И.О., должность сотрудника, передавшего и принявшего телефонограмму.

Все телефонограммы, передаваемые в КВУ, фиксируются в специальном журнале ответственным лицом.

2. Отправление письма из учреждения, выявившего больного, почтой с указанием данных :

- наименование учреждения, куда адресовано письмо;
- Ф.И.О.;
- возраст;
- адрес проживания (прописки);
- предполагаемый диагноз;
- предварительное лечение;
- данные проведенного лабораторного исследования на сифилис;
- сведения о членах семьи и предполагаемом источнике заражения;
- дата отправления документа;
- подпись (разборчиво).

3. На руки пациенту выдается направление в КВУ с указанием адреса и телефона учреждения, в которое он должен явиться для уточнения диагноза.

4. ЛПУ, направившее больного, должно проконтролировать явку больного в КВУ телефонным звонком и получить обратный ответ из КВУ с уточненным диагнозом.



# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### А. Анкета для мужчин

Для повышения качества обследования и лечения просим Вас ответить на поставленные в анкете вопросы. Это сократит также время Вашего пребывания в медицинском учреждении.

Отметьте правильный ответ. В случае затруднения оставьте пустое место. Вам поможет ответить врач.

Медицинская карта № \_\_\_\_\_ Дата обращения \_\_\_\_\_

Анамнез пациента: \_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_

Семейное положение: Женат ☐ Пост. партнер ☐ В разводе ☐ Не женат ☐

#### Причина обращения:

Жалобы ☐ После лечения ☐ Профилактически ☐

После случайной половой связи ☐ Симптомы у партнера ☐ Другое \_\_\_\_\_

Хочу провериться на: хламидии ☐ трихомонады ☐ гонококки ☐ грибы ☐

вирус папилломы человека ☐ сифилис ☐ ВИЧ ☐ герпес ☐

другие инфекции \_\_\_\_\_

Болел ли ранее гепатитом ☐ туберкулезом ☐ малярией ☐

Донор да ☐ нет ☐

Переливание крови в прошлом да ☐ нет ☐

Операции за последние 6 месяцев да ☐ нет ☐

Употребление наркотиков да ☐ нет ☐ в т. ч. внутривенные да ☐ нет ☐

Образование: среднее ☐ среднее специальное ☐ высшее ☐

Вы: учащийся ☐ студент ☐ рабочий ☐ безработный ☐ служащий

☐ военнослужащий ☐ Ваша профессия \_\_\_\_\_

Последний раз мочились \_\_\_\_\_ часов назад

Аллергические реакции в прошлом да ☐ нет ☐

в т. ч. на медикаменты да ☐ нет ☐ препарат \_\_\_\_\_

Использовали ли антибиотики за последние 3 месяца

да ☐ нет ☐ сколько дней назад \_\_\_\_\_ препарат \_\_\_\_\_ причина \_\_\_\_\_

Какие методы защиты от ИППП Вы используете сейчас:

презерватив ☐ крем ☐ другое ☐

Начало половой жизни \_\_\_\_\_ лет

Ваш половой партнер: женщина ☐ мужчина ☐ оба ☐

Сколько дней тому назад Вы имели последнее половое сношение: \_\_\_\_\_

Сколько месяцев \_\_\_\_\_ или лет \_\_\_\_\_ длится Ваша последняя связь

Число партнеров за последние 6 месяцев : \_\_\_\_\_ (число)

Число партнеров за последний год: \_\_\_\_\_ (число)

Имели ли Вы половые связи с другими мужчинами? нет ☐ да ☐

Если да, сколько времени назад? \_\_\_\_\_ Презерватив: да ☐ нет ☐

Имели ли Вы случайные половые связи? да ☐ нет ☐

Если да, сколько времени назад? \_\_\_\_\_ Презерватив: да ☐ нет ☐

Длительность работы в секс-бизнесе \_\_\_\_\_ (число месяцев, лет)

#### Признаки болезни (жалобы) СЕГОДНЯ:

**ДА:** ☐ Если да – как долго (сколько дней) **НЕТ:** ☐

Выделения из мочеиспускательного канала ☐ \_\_\_\_\_ дней

Выделения из мочеиспускательного канала только по утрам ☐ \_\_\_\_\_ дней  
 Болезненность: при мочеиспускании ☐ \_\_\_\_\_ дней,  
 во время полового акта ☐ \_\_\_\_\_ дней, внизу живота ☐ \_\_\_\_\_ дней,  
 в яичках ☐ \_\_\_\_\_ дней, другой локализации ☐ где \_\_\_\_\_  
 Зуд в области половых органов ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 учащенное мочеиспускание ☐ \_\_\_\_\_ дней,  
 учащенное мочеиспускание ночью ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 кондиломы (выросты) ☐ \_\_\_\_\_ дней; высыпания/пузырьки ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 покраснение ☐ \_\_\_\_\_ дней; нарушение эрекции ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 налет ☐ \_\_\_\_\_ дней; неприятный запах ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 другое ☐ что \_\_\_\_\_

### Признаки болезни (жалобы) РАНЬШЕ:

**ДА:** ☐ Если да – как долго (сколько дней) **НЕТ:** ☐  
 Выделения из мочеиспускательного канала ☐ \_\_\_\_\_ дней  
 Выделения из мочеиспускательного канала только по утрам ☐ \_\_\_\_\_ дней  
 Болезненность : при мочеиспускании ☐ \_\_\_\_\_ дней,  
 во время полового акта ☐ \_\_\_\_\_ дней, внизу живота ☐ \_\_\_\_\_ дней,  
 в яичках ☐ \_\_\_\_\_ дней, другой локализации ☐ где \_\_\_\_\_  
 Зуд в области половых органов ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 учащенное мочеиспускание ☐ \_\_\_\_\_ дней,  
 учащенное мочеиспускание ночью ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 кондиломы (выросты) ☐ \_\_\_\_\_ дней; высыпания /пузырьки ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 покраснение ☐ \_\_\_\_\_ дней; нарушение эрекции ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 налет ☐ \_\_\_\_\_ дней; неприятный запах ☐ \_\_\_\_\_ дней;  
 другое ☐ что \_\_\_\_\_

Принимали ли лекарства, когда появились признаки заболевания:

да ☐ нет ☐ если да, то какие \_\_\_\_\_

Были ли половые сношения после появления признаков заболевания:

да ☐ нет ☐

Был ли раньше поставлен диагноз следующего заболевания: хламидиоз ☐  
 кондиломатоз ☐ герпес ☐ трихомониаз ☐ гонорея ☐ воспаление мочеиспус-  
 кательного канала ☐ сифилис ☐. Если да, сколько месяцев назад?

Признаки болезни (жалобы) вне половых органов нет ☐ да ☐ если да, какие:  
 болезненность в суставах ☐ воспаление глаз ☐ высыпания на коже ☐ уве-  
 личение лимфатических узлов паховых ☐ увеличение лимфатических узлов  
 другой локализации ☐ другое \_\_\_\_\_

**Имеет ли партнерша СЕЙЧАС** признаки (жалобы) инфекций, передаваемых половым путем: да ☐ нет ☐ не знаю ☐

**Партнерша:** обследована ☐ не обследована ☐ не знаю ☐ Если обследо-  
 вана, что обнаружено: хламидии ☐ гонококки ☐ сифилис ☐ ВИЧ ☐ герпес ☐  
 дрожжи ☐ бактериальный вагиноз ☐ трихомонады ☐ вирус папилломы чело-  
 века ☐ воспалительные заболевания органов малого таза ☐ не знаю ☐

**Партнерша РАНЬШЕ** болела инфекциями, передаваемыми половым путем:  
 да ☐ нет ☐ не знаю ☐ Если да: сколько \_\_\_\_\_ месяцев назад Какими: хла-  
 мидиоз ☐ гонорея ☐ сифилис ☐ трихомоноз ☐ герпес ☐ негонококковый  
 уретрит ☐ кандидозный кольпит ☐ другие \_\_\_\_\_



**Б. АНКЕТА ДЛЯ ЖЕНЩИН**

**Для повышения качества обследования и лечения просим Вас ответить на поставленные в анкете вопросы. Это сократит также время Вашего пребывания в медицинском учреждении.**

Отметьте правильный ответ. В случае затруднения оставьте пустое место. Вам поможет ответить врач.

**Медицинская карта № \_\_\_\_\_ Дата обращения \_\_\_\_\_**

**Анамнез пациентки:** Возраст \_\_\_\_\_

**Семейное положение:**

Не замужем ☐ Замужем ☐ Гражданский брак ☐ Разведена ☐  
(пост. партнер)

**Причина обращения:**

Жалобы ☐ После лечения ☐ Профилактически ☐ : После случайной половой связи ☐ Симптомы у партнера ☐ Другое \_\_\_\_\_

Хочу провериться на: хламидии ☐ трихомонады ☐ гонококки ☐  
грибы ☐ вирус папилломы человека ☐ сифилис ☐ ВИЧ ☐ герпес ☐  
другие инфекции \_\_\_\_\_

Болела ли ранее гепатитом ☐ туберкулезом ☐ малярией ☐

Донор да ☐ нет ☐

Переливание крови в прошлом да ☐ нет ☐

Операции за последние 6 месяцев да ☐ нет ☐

Употребление наркотиков да ☐ нет ☐ в т. ч. внутривенные да ☐ нет ☐

Образование: среднее ☐ среднее специальное ☐ высшее ☐

Вы: учащаяся ☐ студентка ☐ рабочая ☐ безработная ☐ служащая ☐  
домохозяйка ☐

Аллергические реакции в прошлом да ☐ нет ☐

в т. ч. на медикаменты да ☐ нет ☐ препарат \_\_\_\_\_

Использовали ли антибиотики за последние 3 месяца да ☐ нет ☐

сколько дней назад \_\_\_\_\_ препарат \_\_\_\_\_ причина \_\_\_\_\_

Беременны ли Вы сейчас: да ☐ нет ☐ Если да, то сколько недель \_\_\_\_\_

Лечилась от бесплодия да ☐ нет ☐

Начало месячных в \_\_\_\_\_ лет Начало половой жизни в \_\_\_\_\_ лет

Какие методы защиты от ИППП Вы используете сейчас:

презерватив ☐ крем ☐ другое ☐

Ваш постоянный половой партнер: мужчина ☐ женщина ☐ оба ☐

Сколько дней тому назад Вы имели последнее половое сношение: \_\_\_\_\_ дней

Сколько месяцев \_\_\_\_\_ или лет \_\_\_\_\_ длится Ваша последняя связь

Число партнеров за последние 6 месяцев : \_\_\_\_\_ (число)

Случайные половые связи да ☐ нет ☐

Если да, сколько времени назад? \_\_\_\_\_ (дней, недель)

Презерватив: да ☐ нет ☐

Длительность работы в секс-бизнесе \_\_\_\_\_ (число месяцев, лет)

**Признаки болезни (жалобы) СЕГОДНЯ:**

**ДА:** ☐ Если да – как долго (сколько дней, дн.) \_\_\_\_\_ **НЕТ:** ☐

Выделения \_\_\_\_\_ дн. Болезненность: при мочеиспускании \_\_\_\_\_ дн. ,  
 во время полового акта ☐ \_\_\_\_\_ дн., внизу живота ☐ \_\_\_\_\_ дн.,  
 другой локализации ☐ где \_\_\_\_\_  
 Зуд в области половых органов ☐ \_\_\_\_\_ дн.,  
 учащенное мочеиспускание ☐ \_\_\_\_\_ дн.; кондиломы (выросты) ☐ \_\_\_\_\_ дн.;  
 высыпания/пузырьки ☐ \_\_\_\_\_ дн.; покраснение ☐ \_\_\_\_\_ дн.;  
 неприятный запах ☐ \_\_\_\_\_ дн. Кровянистые выделения ☐ \_\_\_\_\_ дн.  
 другое ☐ : что \_\_\_\_\_

### Признаки болезни (жалобы) РАНЬШЕ:

**ДА:** Если да – сколько месяцев тому назад \_\_\_\_\_ **НЕТ:** ☐  
 Выделения \_\_\_\_\_ мес. Болезненность: при мочеиспускании ☐ \_\_\_\_\_ мес.,  
 во время полового акта ☐ \_\_\_\_\_ мес., внизу живота ☐ \_\_\_\_\_ мес.,  
 другой локализации ☐ где \_\_\_\_\_  
 Зуд в области половых органов ☐ \_\_\_\_\_ мес.;  
 учащенное мочеиспускание ☐ \_\_\_\_\_ мес.; кондиломы (выросты) ☐ \_\_\_\_\_ мес.;  
 высыпания/пузырьки ☐ \_\_\_\_\_ мес.; покраснение ☐ \_\_\_\_\_ мес.;  
 неприятный запах ☐ \_\_\_\_\_ мес. Кровянистые выделения ☐ \_\_\_\_\_ месяцев,  
 другое ☐ : что \_\_\_\_\_

Принимали ли лекарства, когда появились признаки заболевания: да ☐ нет ☐,  
 если да, то какие \_\_\_\_\_

Были ли половые сношения после появления признаков заболевания:

да ☐ нет ☐

Был ли раньше поставлен диагноз следующего заболевания: хламидиоз ☐  
 кондиломатоз ☐ герпес ☐ гонорея ☐ сифилис ☐ трихомониаз ☐ кандидоз  
 (молочница) ☐ воспаление мочеиспускательного канала (уретрит) ☐ воспале-  
 ние канала шейки матки (цервицит) ☐ воспаление придатков матки ☐ бактери-  
 альный вагиноз ☐ Если да, сколько месяцев назад: \_\_\_\_\_ не знаю ☐  
 Признаки болезни (жалобы) вне половых органов ☐ если да, какие: воспалие-  
 ние глаз ☐ болезненность в суставах ☐ высыпания на коже ☐ увеличение лим-  
 фатических узлов ☐ другое \_\_\_\_\_

Последние месячные начались \_\_\_\_\_ дней назад.

Месячные регулярные: да ☐ нет ☐

Рожали Вы: нет ☐ да ☐ если да, сколько раз \_\_\_\_\_, сколько лет назад \_\_\_\_\_

Прерывали ли беременность нет ☐ да ☐ если да, сколько раз \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ лет  
 назад. Если да, в связи с каким заболеванием \_\_\_\_\_

Были ли выкидыши: нет ☐ да ☐ если да, сколько раз \_\_\_\_\_,  
 сколько \_\_\_\_\_ лет назад

**Имеет ли партнер СЕЙЧАС** признаки (жалобы) инфекций,  
 передаваемых половым путем: да ☐ нет ☐ не знаю ☐

**Партнер:** обследован ☐ не обследован ☐ не знаю ☐ Если обследован, что об-  
 наружено: хламидии ☐ гонококки ☐ сифилис ☐ ВИЧ ☐ герпес ☐ грибы ☐ три-  
 хомонады ☐ вирус папилломы человека ☐ не знаю ☐

**Партнер РАНЬШЕ** болел инфекциями, передаваемыми половым путем:

да ☐ нет ☐ не знаю ☐ Если да: сколько \_\_\_\_\_ месяцев назад  
 Какими: хламидиоз ☐ гонорея ☐ сифилис ☐ трихомониаз ☐ герпес ☐ не гонококковый  
 уретрит ☐ кандидоз (молочница) ☐ другими \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Неправильно: термины-синонимы                               | Правильно: термины согласно МКБ-10                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВИЧ/СПИД                                                    | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека /ВИЧ/ (развернутый диагноз ставят с уточнением локализации или проявлений, например, болезнь, вызванная ВИЧ с проявлениями множественных злокачественных новообразований) |
| трихомоноз                                                  | трихомониаз (диагноз ставят с уточнением топической локализации процесса, например, трихомонадный уретрит, или трихомонадный кольпит)                                                                                        |
| хламидиоз                                                   | хламидийная инфекция (диагноз ставят с уточнением локализации, например, хламидийные уретрит, фарингит)                                                                                                                      |
| генитальный герпес                                          | аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex] (диагноз ставят с уточнением локализации, например, герпетическая инфекция головки полового члена)                                                           |
| остроконечные кондиломы                                     | аногенитальные (венерические) бородавки                                                                                                                                                                                      |
| гарднереллез                                                | бактериальный вагиноз                                                                                                                                                                                                        |
| лобковый педикулез, лобковая вшивость                       | фтириаз                                                                                                                                                                                                                      |
| мягкий шанкр                                                | шанкرويد                                                                                                                                                                                                                     |
| лимфогранулематоз паховый, 4-я венерическая болезнь         | хламидийная лимфогранулема (венерическая)                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
| гранулема венерическая, донованоз, 5-я венерическая болезнь | паховая гранулема                                                                                                                                                                                                            |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
**БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ИЗ**  
**ГРУПП РИСКА**

| № | Обследование |                |                      |                          |              |         |         |           |             |             |             |                       |                    |        | Диагноз |           |                         |                       |            |
|---|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------|---------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2            | 3              | 4                    | 5                        | 6            | 7       | 8       | 9         | 10          | 11          | 12          | 13                    | 14                 | 15     | 16      | 17        | 18                      | 19                    | 20         |
|   | ФИО, код     | Дата обращения | Год рождения/возраст | Номер амбулаторной карты | ВИЧ-инфекция | Сифилис | Гонорея | Хламидиоз | Трихомониаз | Уреаплазмоз | Микоплазмоз | Бактериальный вагиноз | Генитальный герпес | Другое |         | № рецепта | Дата назначения лечения | Дата выдачи лекарства | Примечание |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОГО УРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА МУЖЧИНЫ**

(нужное подчеркнуть)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата первичного осмотра)

Жалобы: НЕТ ЕСТЬ:

- на выделения из уретры

(скудные, умеренные, или обильные; слизистые, гнойные или смешанные)

- на зуд, резь, жжение при мочеиспускании

- на сыпь в области половых органов, туловища, конечностей, слизистой полости рта

- на увеличение лимфатических узлов \_\_\_\_\_

Анамнез настоящего заболевания: продолжительность болезни \_\_\_\_\_

половые контакты \_\_\_\_\_

Самолечение: НЕТ, ДА (названия лекарственных препаратов) \_\_\_\_\_

Анамнез жизни:

из перенесенных заболеваний отмечает - ОРЗ, ангина, бронхит, гепатит \_\_\_\_\_, туберкулез, вензаболевания \_\_\_\_\_

аллергические реакции в прошлом - НЕТ,

БЫЛИ (к лекарственным препаратам) \_\_\_\_\_

Вредные привычки: НЕТ, ДА – курит, алкоголь \_\_\_\_\_, наркотики \_\_\_\_\_

Донорство: ДА, НЕТ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата последней сдачи крови)

Консультирование по ВИЧ-инфекции:

дотестовое « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. послетестовое « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сексуальный анамнез:

Половая жизнь с \_\_\_\_\_ лет в браке, вне брака

Сексуальные контакты с мужчинами: НЕТ, ДА

Наличие постоянного партнера: НЕТ, ДА

Данные объективного обследования:

общее состояние удовлетворительное - ДА, НЕТ \_\_\_\_\_

АД \_\_\_\_\_ мм.рт.ст. Пульс \_\_\_\_\_ уд. в мин.

Тоны сердца - громкие, приглушенные, ритмичные, аритмия.

В легких дыхание - везикулярное, хрипы.

Щитовидная железа - не увеличена, увеличена \_\_\_\_\_ степени.

Язык - чистый, влажный, сухой, обложен налетом \_\_\_\_\_

Живот - мягкий, безболезненный, (не)вздут, болезненный в области \_\_\_\_\_

Печень - не увеличена, выступает на \_\_\_\_\_ см из-под реберной дуги

Селезенка - не увеличена, увеличена на \_\_\_\_\_

Симптом поколачивания - отрицательный, положительный

(слева, справа, с обеих сторон)

Отеки: НЕТ, ЕСТЬ \_\_\_\_\_

Стул - норма, учащен до \_\_\_\_\_ раз в сутки, запоры

Мочеиспускание - норма, учащен до \_\_\_\_\_ раз в сутки, болезненное

Кожа: свободна от высыпаний; (яркая, не яркая) сыпь - розеолезная,

розеолезно-папулезная, папулезная, ладонно-подошвенный сифилид;

пустулезный сифилид; лейкодерма области шеи; очаговая алопеция;

выпадение ресниц, бровей \_\_\_\_\_

Слизистая рта и зева: розовая, без высыпаний; гиперемия зева;

гиперемия миндалин; поражение миндалин; (слева, справа, с обеих сторон);

папулы, эрозии, язвы на обеих (левой, правой) миндалинах;

эрозии на слизистой рта; папулы, эрозии на языке. Язык обычный \_\_\_\_\_

Лимфатические узлы: неувеличены, увеличены до \_\_\_\_\_

паховые (слева, справа, с обеих сторон), другие группы \_\_\_\_\_

при пальпации - болезненные, безболезненные \_\_\_\_\_

Локальный статус:

Половые органы: норма, отклонения \_\_\_\_\_, оволосение по мужскому (женскому) типу, без высыпаний.

Сыпь (где) \_\_\_\_\_,

характер сыпи - одиночные (множественные) эрозивные (язвенные) твердые

шанкры; рубец; папулы (лентикулярные, нумулярные, сливные),

широкие кондиломы; индуративный отек; остроконечные кондиломы. Фимоз.

Парафимоз \_\_\_\_\_

Губки уретры - обычные, гиперемизированные, отечные \_\_\_\_\_

Уретра - обычная; без инфильтратов; инфильтрированная; безболезненная (болезненная)

Выделения из уретры - НЕТ, ЕСТЬ - свободно истекающие, обильные, умеренные, скудные; слизистые, слизисто-гнойные, гнойные, геморрагические

Парауретральные ходы - неопределяются, ЕСТЬ (их состояние) \_\_\_\_\_

Органы мошонки - без патологических отклонений; варикозное расширение вен (слева, справа, с обеих сторон) \_\_\_\_\_

Яички - не увеличены, увеличены (слева, справа, с обеих сторон), безболезненные, болезненные \_\_\_\_\_

Придатки яичек - не изменены, инфильтрированы \_\_\_\_\_, болезненны \_\_\_\_\_

Перианальная область - без особенностей; единичный (множественные) эрозивный (язвенный) твердый шанкр; рубец; язвенные папулы; эрозивные папулы;

широкие кондиломы; остроконечные кондиломы; трещина \_\_\_\_\_

Предстательная железа - не обследована. Обследована: размер - \_\_\_\_\_

срединная борозда - выражена, сглажена, не определяется; при пальпации болезненна в области \_\_\_\_\_, безболезненная; консистенция

- плотная, плотно-эластическая, мягкая, тестообразная, четко отграничена (спаяна) от окружающих тканей; инфильтраты \_\_\_\_\_

Семенные пузырьки - не определяются; обычные, безболезненные (болезненные)

Прямая кишка - без патологии, патология \_\_\_\_\_

При массаже предстательной железы - получен (не получен) молочного (молочно-серого, зеленоватого, красноватого) цвета секрет.

Секрет - отправлен для исследования (\_\_\_\_\_), нет.

Двухстаканная проба: 1 порция - прозрачная, нити, хлопья, мутная;

2 порция - прозрачная, нити, хлопья, мутная.

### Протокол первичного гинекологического осмотра женщины

(нужное подчеркнуть)

"\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ г.

(дата первичного осмотра)

Жалобы: НЕТ. ЕСТЬ:

- на выделения из уретры (скудные, умеренные, или обильные; слизистые, гнойные или смешанные)

- на зуд, резь, жжение при мочеиспускании

- на сыпь в области половых органов, туловища, конечностей, слизистой полости рта

- на увеличение лимфатических узлов \_\_\_\_\_

Анамнез настоящего заболевания:

продолжительность болезни \_\_\_\_\_

половые контакты \_\_\_\_\_

Самолечение: НЕТ, ДА (названия лекарственных препаратов) \_\_\_\_\_

Анамнез жизни:

из перенесенных заболеваний отмечает - ОРЗ, ангина, бронхит, гепатит \_\_\_\_\_,

туберкулез, вензаболевания \_\_\_\_\_

аллергические реакции в прошлом - НЕТ, БЫЛИ (к лекарственным препаратам) \_\_\_\_\_

Вредные привычки: НЕТ, ДА - курит, алкоголь \_\_\_\_\_, наркотики \_\_\_\_\_

Донорство: ДА, НЕТ «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

(дата последней сдачи крови)

Консультирование по ВИЧ-инфекции:

дотестовое «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

послетестовое «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Сексуальный анамнез:

Половая жизнь с \_\_\_\_\_ лет в браке, вне брака

Mensis с \_\_\_\_\_ лет, по \_\_\_\_\_ дней, через \_\_\_\_\_ дней, регулярные, нерегулярные; болезненные, безболезненные, последние \_\_\_\_\_,

Беременностей \_\_\_\_\_, закончились: родами \_\_\_\_\_, аборт \_\_\_\_\_

Наличие постоянного партнера: НЕТ, ДА

Длительность работы в секс-бизнесе \_\_\_\_\_ (число месяцев, лет)

Данные объективного обследования:

общее состояние удовлетворительное - ДА, НЕТ \_\_\_\_\_

АД \_\_\_\_\_ мм.рт.ст. Пульс \_\_\_\_\_ уд. в мин.

Тоны сердца - громкие, приглушенные, ритмичные, аритмия.

В легких дыхание - везикулярное, хрипы.

Щитовидная железа - не увеличена, увеличена \_\_\_\_\_ степени.

Язык - чистый, влажный, сухой, обложен налетом \_\_\_\_\_

Живот - мягкий, безболезненный, (не)вздут, болезненный в области \_\_\_\_\_

Печень - не увеличена, выступает на \_\_\_\_\_ см из-под реберной дуги



Селезенка - не увеличена, увеличена на \_\_\_\_\_

Симптом поколачивания - отрицательный, положительный

(слева, справа, с обеих сторон)

Отеки: НЕТ, ЕСТЬ \_\_\_\_\_

Стул - норма, учащен до \_\_\_\_\_ раз в сутки, запоры

Мочеиспускание - норма, учащен до \_\_\_\_\_ раз в сутки, болезненное

Кожа: свободна от высыпаний; (яркая, не яркая) сыпь - розеолезная, розеолезно-папулезная, папулезная, ладонно-подошвенный сифилид; пустулезный сифилид; лейкодерма области шеи; очаговая алопеция; выпадение ресниц, бровей

Слизистая рта и зева: розовая, без высыпаний; гиперемия зева; гиперемия миндалин; поражение миндалин; (слева, справа, с обеих сторон); папулы, эрозии, язвы на обеих (левой, правой) миндалинах; эрозии на слизистой рта; папулы, эрозии на языке. Язык обычный \_\_\_\_\_

Лимфатические узлы: не увеличены, увеличены до \_\_\_\_\_

паховые (слева, справа, с обеих сторон), другие группы \_\_\_\_\_

при пальпации - болезненные, безболезненные \_\_\_\_\_

Локальный статус:

Половые органы: норма, отклонения \_\_\_\_\_,

оволосение по мужскому (женскому) типу, без высыпаний.

Сыпь (где) \_\_\_\_\_,

характер сыпи - одиночные (множественные) эрозивные (язвенные)

твердые шанкры; рубец; папулы (ленткулярные, нумулярные, сливные), широкие кондиломы; индуративный отек; остроконечные кондиломы.

Губки уретры - обычные, гиперемизированные, отечные \_\_\_\_\_

Уретра - обычная; без инфильтратов; инфильтрированная; безболезненная (болезненная)

Выделения из уретры - НЕТ, ЕСТЬ - свободно истекающие, обильные, умеренные, скудные; слизистые, слизисто-гнойные, гнойные, геморрагические

Парауретральные ходы - неопределяются, ЕСТЬ (их состояние) \_\_\_\_\_

БартOLIиновы железы - без патологических изменений; гиперемия в области устья выводных протоков; проток пальпируется в виде плотного тяжа, железа \_\_\_\_\_ в виде безболезненного узелка; определяется болезненная опухоль в нижней трети большой половой губы, справа, слева \_\_\_\_\_

Per speculum: вход во влагалище свободный, болезненный. Стенки розового цвета, гиперемизированы, имеются эрозии, язвы. В заднем своде: умеренный влагалищный секрет молочного цвета; скудные (обильные) гнойные, творожистые, менструальные, кровянистые выделения; без запаха, с неприятным \_\_\_\_\_ запахом.

Шейка матки: коническая, цилиндрическая, увеличена (да, нет), зев щелевидный, круглый, неправильной формы. Покровы обычной окраски, гиперемизированы, цианотичны, имеется эрозия \_\_\_\_\_, язва \_\_\_\_\_.

Цервикальный канал: выделения в виде пробки, тяжа, ленты; слизь - прозрачная, мутная, слизисто-гнойные выделения, кровянистые, менструальные, густые, жидкие \_\_\_\_\_.

Внутриматочная спираль: есть, нет.

Per vaginam: своды - свободны, укорочены - справа, слева. Матка - в антефлексии, ретрофлексии, увеличена (нет), до \_\_\_\_\_ недель беременности. Консистенция: мягковатая, плотная, тестообразная; подвижная, ограничено подвижная; отклонена влево, вправо. Болезненность - есть, нет.

Перианальная область - без особенностей; единичный (множественные) эрозивный (язвенный) твердый шанкр; рубец; язвенные папулы; эрозивные папулы; широкие кондиломы; остроконечные кондиломы; трещина \_\_\_\_\_

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

### **Список литературы**

1. Лосева О.К., Поршина О.В., Кузнецова Ю.Е.. Особенности диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем у лиц, оказывающих сексуальные услуги за плату. Руководство для доверенных врачей в программах профилактики. – Москва: РОО «СПИД инфосвязь», 2008.- 96 с.
2. Саранков Ю. Медицинские потребности и проблемы мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами. – Киев: «СПИД Фонд Восток-запад», 2007. – 96 с.
3. Результаты дозорного эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь/авт.Л.А.Мелешко[и др.]. Минск: Ковчег, 2007. – 43 с.:ил.
4. Рекомендации по сбору поведенческих данных среди представителей сообщества мужчин, практикующих секс с мужчинами, в рамках эпидемиологического надзора второго поколения за ВИЧ/ Тоскин И.А. Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт Министерства здравоохранения Российской Федерации (ЦНИКВИ). Москва, 2005.- 72 с.
5. Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения Республики Беларусь: информационно-просветительские материалы для кураторов проблемы ВИЧ/ СПИД организаций/сост.Л.А.Мелешко – Минск: Геопринт, 2007.- 98 с.
6. Методические материалы по диагностике, лечению и профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Стандарты ведения больных/ Соколовский Е. В., Аравийская Е. Р. и др . Санкт-Петербург, 2002. – 105 с.
7. Клинические протоколы диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем (проект)./ Шиманская И.Г., Панкратов О.В. и др. Минск, 2009, 88 с.
8. Оценка качества медицинской помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем (Инструкция по применению)/Люцко В.В., Глушанко В.С., Адаскевич В.П. Минск, 2005.- 22 с.
9. Хансфилд Х. Заболевания, передающиеся половым путем. Цветной атлас-справочник. Под общей редакцией чл.-корр. РАМН, проф. А.А.Кубановой. Москва, 2004. 295 с.

**Автор: Навроцкий Александр Людгерович,**  
доцент кафедры кожных и венерических болезней  
Белорусского государственного медицинского университета,  
кандидат медицинских наук, секретарь Белорусского научного  
медицинского общества врачей-дерматовенерологов

